Perfil V3 · código por código

Cardiología

Los 61 códigos del Perfil de Conocimientos EUNACOM v3 (2026) de Cardiología, uno por uno: el nivel que exige el examen, dónde se enseña en nuestros libros, lo que hay que saber en resumen y una pregunta.

Niveles del Perfil — Diagnóstico: **Sospecha** (reconocer y derivar) o **Específico** (confirmar). Tratamiento: **Inicial** (estabilizar y derivar) o **Completo**. Seguimiento: **Derivar**, **Completo** o **No requiere**.

Situaciones clínicas 24 códigos

1.01.1.001 Angina crónica estable

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 2.1 Angina Crónica Estable & Estratificación de Riesgo Funcional

QUÉ HAY QUE SABER

- Angina típica: dolor opresivo retroesternal gatillado por esfuerzo o estrés, que cede con reposo o nitroglicerina sublingual en <10 min; patrón estable por semanas a meses.
- Confirmación: ECG de reposo (a menudo normal) y test de esfuerzo; alto riesgo si infradesnivel ST ≥2 mm, positivo en etapa 1 de Bruce o caída de la PAS. Si no puede caminar o ECG no interpretable: cintigrafía o eco de estrés.
- Terapia médica óptima: aspirina 100 mg/día + estatina de alta potencia (atorvastatina 40–80 mg, meta c-LDL <55 mg/dL) + betabloqueador (bisoprolol 5–10 mg, meta FC 55–60 lpm) + nitroglicerina SL 0,6 mg SOS.
- Segunda línea antianginosa: amlodipino 5–10 mg o nitratos de acción prolongada; IECA/ARA-II si HTA, DM, ERC o FEVI ≤40%. Control estricto de factores de riesgo y cese del tabaco.
- Derivar a cardiología para coronariografía si test de alto riesgo, angina refractaria a TMO o FEVI deprimida; cirugía (bypass) en tronco ≥50% o multivaso en diabéticos.
- Seguimiento completo en APS: síntomas (clase CCS), adherencia, PA, perfil lipídico y HbA1c; un cambio de patrón (reposo, mayor frecuencia) es angina inestable → urgencia.

PREGUNTAS (6)

Pregunta del libro · Tema 2.1

Hombre de 63 años con hipertensión y diabetes tipo 2 consulta por dolor torácico opresivo de 1 mes de evolución que aparece al subir dos pisos por escalera y desaparece a los 3 minutos de reposo. El ECG basal es normal. ¿Cuál es la prueba diagnóstica no invasiva de primera línea más adecuada para confirmar isquemia miocárdica y evaluar pronóstico en APS?

A) Test de esfuerzo convencional en cinta rodante (Ergometría)
B) Coronariografía invasiva inmediata sin pruebas previas
C) Radiografía de tórax póstero-anterior y lateral
D) Determinación seriada de troponinas en reposo
E) Holter de ritmo cardíaco de 24 horas

Respuesta A. En un paciente con sospecha de angina crónica estable, capaz de realizar ejercicio físico y con un ECG basal normal e interpretable, la prueba no invasiva de primera elección recomendada por el MINSAL y consensos internacionales es el Test de Esfuerzo Convencional (Ergometría). Permite confirmar la presencia de isquemia miocárdica inducible, cuantificar el umbral isquémico en METs y estratificar el riesgo cardiovascular global.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 4 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente con antecedente de hipertensión arterial, dislipidemia y diabetes, usuario de aspirina, metformina, hidroclorotiazida y atorvastatina, presenta dolor torácico opresivo, que aparece al caminar 2 cuadras y alcanza un EVA de 5/10. Se solicita un test de esfuerzo que demuestra aparición de un infradesnivel del segmento ST, de 2 mm en las derivadas anteriores. El examen más adecuado para proseguir el estudio es:

A) Ecocardiograma
B) TAC de tórax
C) Ecocardiografía de esfuerzo
D) Coronariografía
E) Cintigrafía de perfesión miocárdica

Respuesta D. La alternativa correcta es la D (Coronariografía). La angina estable con test de esfuerzo alterado, se estudia con coronariografía.. Las enfermedades intersticiales pulmonares difusas tienen múltiples causas, siendo la fibrosis pulmonar idiopática (FPI/UIP) la más frecuente y de peor pronóstico, sin tratamiento específico más allá del sintomático (oxígeno, salbutamol). Esta decisión se fundamenta

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 151 · texto original del banco, sin revisar

Paciente de 58 años, con antecedente de diabetes mellitus, hipertensión y fumador de 40 paquetes año, consulta por un cuadro de tres semanas de evolución de dolor epi- gástrico opresivo, asociado a disnea y palpitaciones regulares, que lo obligan a detener- se cada 100 metros de caminata y ceden con el reposo. En el examen físico, su presión arterial es 140/90 mmHg, frecuencia cardiaca de 80 latidos por minuto regular. El diag-

A) Angina crónica de reciente comienzo
B) Fibrilación auricular paroxística
C) Isquemia cardiaca con arritmia supraventricular
D) Tromboembolismo pulmonar
E) Cardiopatía hipertensiva

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (Angina crónica de reciente comienzo). La única opción aceptable era la angina de reciente comienzo.. Las enfermedades intersticiales pulmonares difusas tienen múltiples causas, siendo la fibrosis pulmonar idiopática (FPI/UIP) la más frecuente y de peor pronóstico, sin tratamiento específico más allá del sintomático (oxígeno, salbutamol). Esta decisión se fundamenta

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 2 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 55 años, con antecedentes de diabetes mellitus 8po 2, hipertensión arterial y tabaquismo de 20 paquetes-año, consulta por dolor torácico de localización precordial y carácter opresivo. El cuadro inició hace tres semanas, presentándose el dolor en relación con la ac8vidad Fsica y desapareciendo rápidamente con el reposo. Sus signos vitales muestran presión arterial 148/92 mmHg, frecuencia cardíaca 81 la8dos por minuto y saturación arterial de oxígeno de 96%. Su examen cardiopulmonar no muestra alteraciones. ¿Cuál es el examen de elección para precisar el diagnós8co?

A) Coronariogra:a
B) Cin2gra:a miocárdica
C) Angiorresonancia de arterias coronarias
D) Test de esfuerzo
E) Electrocardiograma de 24 horas (Holter)

Respuesta D. Es una angina crónica estable. Su diagnóstico es clínico y su estudio comienza con una prueba de esfuerzo, generalmente el ECG de esfuerzo. En los casos en que no se puede realizar (amputados o pacientes que no toleran el ejercicio) y en los casos en que el electrocardiograma es ilegible (ej. BCRI), se uGlizan otras pruebas de esfuerzo, como la ecocardiografía, con dobutamina o la cintigrafía card

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 82 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 68 años, fumador y dislipidémico, en tratamiento con lavastatina y aspirina, comienza hace 2 meses con angina de pecho persistente, pero estable. ¿Qué fármaco es recomendable agregar?

A) Amlodipino
B) Dinitrato de isosorbide
C) Carvedilol
D) Enalapril
E) Hidroclorotiazida

Respuesta B. Lo más importante en la angina crónica es revascularizar (se pide test de esfuerzo y luego angiografía, para hacer angioplastía o bypass) y, además, dejar las estatinas y sobre todo la aspirina. Sin embargo, además, sirven los nitritos, como el isosorbide o la nitroglicerina. Los demás son antihipertensivos o fármacos para la insuficiencia cardíaca.

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 180 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 65 años, hipertenso y diabético, consulta por disnea y dolor de precordial, que aparece en relación al ejercicio. Es usuario de aspirina, enalapril, metformina, glibenclamida y atorvastatina. Refiere que le es imposible subir más de dos pisos en su edificio o caminar más de dos cuadras sin detenerse, debido al dolor. Su examen físico es normal, al igual que su electrocardiograma. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Derivar a unidad de salud mental
B) Solicitar test de esfuerzo
C) Solicitar troponinas
D) Indicar programa de ejercicios supervisados, con aumento progresivo
E) Iniciar anticoagulación oral Nota: pregunta añadida a la reconstrucción.

Respuesta B. Conducta / Tratamiento indicado: Solicitar test de esfuerzo (opción B). Fibrosis pulmonar idiopática: la más frecuente y de peor pronóstico; sin tratamiento específico De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

1.01.1.002 Bloqueos aurículo-ventriculares

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 1.5 Bradicardias Sintomáticas & Bloqueos AV (GES Marcapasos)

QUÉ HAY QUE SABER

- BAV 1°: PR >200 ms constante, todas las P conducen; benigno, sin tratamiento. BAV 2° Mobitz I (Wenckebach): PR se alarga hasta una P bloqueada, nodal, suele ser benigno.
- BAV 2° Mobitz II: PR constante con P bloqueadas súbitas (infrahisiano, QRS a menudo ancho); BAV 3°: disociación AV completa con escape lento. Ambos tienen indicación de marcapaso definitivo (GES).
- Síntomas: mareo, síncope (Stokes-Adams), disnea, IC. Buscar causas reversibles: betabloqueador, calcioantagonista no DHP, digoxina, hiperkalemia, IAM inferior, enfermedad de Lyme/Chagas.
- Manejo inicial del bloqueo sintomático o inestable: atropina 1 mg EV (útil en nodales, inefectiva en infrahisianos); si falla, marcapaso transcutáneo o dopamina/adrenalina en infusión.
- Suspender fármacos frenadores y corregir electrolitos; ECG de 12 derivaciones y Holter si es intermitente.
- Seguimiento: derivar a cardiología para estudio e implante de marcapaso (Mobitz II y BAV completo, aunque sean asintomáticos).

PREGUNTAS (4)

Pregunta del libro · Tema 1.5

Hombre de 76 años consulta por astenia y mareos de 3 días. El ECG revela ondas P a 70 lpm e intervalos PR de 160 ms constantes, pero cada tres ondas P, una no es seguida de complejo QRS sin que haya existido alargamiento previo del PR. El complejo QRS mide 130 ms. ¿Cuál es el diagnóstico y la conducta definitiva?

A) Bloqueo AV de 2° grado Mobitz II; requiere implante de marcapaso definitivo
B) Bloqueo AV de 2° grado Mobitz I; requiere observación ambulatoria
C) Bloqueo AV de 1er grado; requiere suspender fármacos cronótropos
D) Disociación auriculoventricular por intoxicación digitálica
E) Paro sinusal con ritmo de escape de la unión

Respuesta A. El bloqueo intermitente de ondas P sin prolongación previa del intervalo PR define un Bloqueo AV de 2° Grado Mobitz II. Debido a que la lesión se encuentra en el sistema His-Purkinje infranodal, existe un alto riesgo de progresión a bloqueo completo y muerte súbita, por lo que tiene indicación formal de Marcapaso Definitivo.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 21 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 62 años presenta malestar general marcado, desde hace 20 minutos. Al examen físico está sudoroso, tiene FC: 33x', PA: 120/50 mmHg. Se solicita un electrocardiograma que se muestra a continuación: El diagnóstico más probable es:

A) Bloqueo auriculoventricular de primer grado
B) Bloqueo auriculoventricular de segundo grado, tipo I
C) Bloqueo auriculoventricular de segundo grado, tipo II
D) Bloqueo auriculoventricular de tercer grado
E) Enfermedad del nodo sinusal

Respuesta D. Se observa con disociación AV y, además, la FC cercana a 30 sugiere mucho un BAV completo o de tercer grado. Se deben saber identificar todas las arritmias de manera relativamente rápido en el EKG.

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 138 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 70 años presenta astenia, intolerancia al ejercicio y disnea de 3 meses de evolución. Además, presenta lipotimias luego de levantarse de la cama. Al examen físico tiene FC: 45 x', regular. Se realiza un electrocardiograma, que se muestra a continuación (fuente: cardioparamap.com): El diagnóstico más probable es:

A) Bloqueo aurículo-ventricular de primer grado
B) Bloqueo aurículo-ventricular de segundo grado, Mobitz I
C) Bloqueo aurículo-ventricular de segundo grado, Mobitz II
D) Bloqueo aurículo-ventricular completo
E) Enfermedad del nodo sinusal

Respuesta D. Un paciente con bradicardia de 45 por minuto regular, síncope y mareos al levantarse, con ECG de disociación entre ondas P y complejos QRS, tiene un bloqueo auriculoventricular completo. El bloqueo de primer grado y el Mobitz I suelen ser asintomáticos, y la enfermedad del nodo sinusal muestra bradicardia sinusal con ondas P asociadas a cada QRS.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 163 · texto original del banco, sin revisar

¿Cuál es el diagnóstico que se visualiza en el siguiente electrocardiograma?

A) Bloqueo AV completo
B) Fibrilación auricular lenta
C) Bloqueo AV de 2do grado
D) Bradicardia sinusal
E) Paro sinusal

Respuesta C. Tiene una imagen de un BAV de segundo grado, Mobitz I, en que se va alargando el PR, hasta que una onda P no conduce.

1.01.1.003 Cardiopatía congénita en adulto

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 4.4 Semiología de Soplos, Maniobras Dinámicas & Cardiopatías Congénitas del Adulto

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospechar ante soplo, cianosis, hipertensión pulmonar, arritmias auriculares o embolía paradójica en un adulto joven; muchas se descubren por ECG o radiografía alterados.
- CIA (la más frecuente diagnosticada en adultos): desdoblamiento amplio y fijo del S2, soplo sistólico pulmonar, BCRD en ECG y crecimiento de cavidades derechas.
- CIV: soplo holosistólico rudo paraesternal izquierdo con frémito. Ductus: soplo continuo en maquinaria. Coartación: HTA en brazos, pulsos femorales débiles y muescas costales (Roesler).
- Síndrome de Eisenmenger: inversión del shunt (D→I) con cianosis e hipocratismo; el cierre del defecto está contraindicado y el embarazo es de muy alto riesgo.
- Manejo inicial: ecocardiograma, tratar IC o arritmias, profilaxis de endocarditis en cardiopatías cianóticas o reparadas con material protésico, consejo preconcepcional.
- Seguimiento: derivar a cardiología (centro de cardiopatías congénitas del adulto) para definir cierre percutáneo o quirúrgico y control de por vida.

PREGUNTAS (12)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 3 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 28 años, con antecedente de haber sido operado de coartación aórtica cuando niño, consulta por un cuadro progresivo de disnea de esfuerzos y ortopnea, que ha deteriorado significativamente su capacidad funcional. En el examen físico tiene pulso palpable con frecuencia cardíaca de 72 latidos por minuto, presión arterial de 155/75 mmHg y frecuencia respiratoria de 15 respiraciones por minuto, saturando 92% a FiO2 ambiental. Al examen cardiopulmonar, tiene ritmo regular en dos tonos, con soplo sistólico eyectivo II/VI en la zona paraesternal, más un soplo diastólico, que se escucha hasta la final de la diástole en el mismo foco. Su padre falleció a los 50 años, de manera súbita. ¿Cuál es el diagnóstico más importante?

A) Recoartación aórtica
B) Estenosis aórtica
C) Insuficiencia aórtica
D) Insuficiencia tricuspídea
E) Disección aórtica

Respuesta A. Diagnóstico: Recoartación aórtica (opción A). El manejo crónico del asma tiene como objetivos principales eliminar los síntomas, prevenir hospitalizaciones y descompensaciones, prevenir complicaciones (especialmente sobreinfección bacteriana) y mantener la función pulmonar a largo plazo. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 AS

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 147 · texto original del banco, sin revisar

Mujer de 45 años que recuerda que durante un embarazo hace 20 años le diagnosticaron un soplo cardíaco. Actualmente asintomática, tolera el ejercicio normal. Auscultación: soplo sistólico II/VI en foco pulmonar con desdoblamiento fijo del segundo ruido. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Tetralogía de Fallot
B) Ductus arterioso persistente
C) Estenosis pulmonar
D) Comunicación interauricular (CIA)
E) Comunicación interventricular

Respuesta D. CIA: soplo sistólico de eyección en foco pulmonar (por hiperflujo pulmonar) + desdoblamiento FIJO del S2 (por sobrecarga de volumen en VD independiente de la respiración) = signo casi patognomónico de CIA. Suele diagnosticarse en embarazo por el aumento del gasto cardíaco.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 28 · texto original del banco, sin revisar

Un hombre de 40 años consulta por disnea de esfuerzos de algunos años de evolución, que aparece con medianos esfuerzos, asociada a palpitaciones ocasionales. Al examen físico tiene edema de extremidades inferiores, FC: 75x', PA: 120/80 mmHg, murmullo pulmonar presente, con escasos crépitos bibasales y al examen cardíaco presenta un soplo sistólico de ubicación paraesternal, con segundo ruido desdoblado fijo. Se solicita un electrocardiograma, que muestra eje a +120°, fibrilación auricular, con un bloqueo completo de la rama derecha del haz de His. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Comunicación interauricular
B) Ductus arteriosos persistente
C) Comunicación interventricular
D) Estenosis aórtica
E) Estenosis mitral

Respuesta A. Diagnóstico: Comunicación interauricular (opción A). Es una CIA clásica, por la dilatación derecha y el desdoblamiento fijo del 2º ruido.. El manejo crónico del asma tiene como objetivos principales eliminar los síntomas, prevenir hospitalizaciones y descompensaciones, prevenir complicaciones (especialmente sobreinfección bacteriana) y mantener la función pulmonar a largo plazo. Los hallazgos desc

Pregunta real · EUNACOM Julio 2018 · Pregunta 32 · texto original del banco, sin revisar

Pregunta 32 Sin contestar Puntúa como 1,00 Marcar pregunta Una paciente de 40 años, consulta por un cuadro, de algunos meses de evolución, de disnea de esfuerzos, progresiva, asociada a ortopnea y edema de extremidades inferiores. Al examen físico se auscultan crepitaciones pulmonares bilaterales, con un soplo en la zona paraesternal izquierda, en el segundo espacio intercostal. Su radiografía muestra signos de hiperflujo pulmonar, con botón pulmonar prominente. Su electrocardiograma muestra un patrón rSr. El diagnóstico más probable es:

A) Comunicación interauricular
B) Dustus arterioso persistente
C) Estenosis aórtica
D) Comunicación interventricular
E) Insuficiencia aórtica

Respuesta A. Diagnóstico: Comunicación interauricular (opción A). Era una clásica CIA del adulto, con toda su clínica, excepto el desdoblamiento fijo del R2.. El manejo crónico del asma tiene como objetivos principales eliminar los síntomas, prevenir hospitalizaciones y descompensaciones, prevenir complicaciones (especialmente sobreinfección bacteriana) y mantener la función pulmonar a largo plazo. Los hallazg

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 86 · texto original del banco, sin revisar

Un hombre de 40 años consulta por disnea y palpitaciones ocasionales. Al examen físico presenta un soplo sistólico basal, con desdoblamiento fijo del segundo ruido. Se solicita un electrocardiograma, que muestra un bloqueo completo de rama derecha. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Comunicación interauricular
B) Ductus arteriosos persistente
C) Comunicación interventricular
D) Estenosis aórtica
E) Estenosis pulmonar

Respuesta A. Es una CIA (comunicación interauricular) clásica, aunque en un adulto: soplo sistólico eyectivo, desdoblamiento del segundo ruido y eje desviado a derecha.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 57 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 30 años presneta un cuadro de astenia, adinamia y disnea de esfuerzos. Presenta un soplo sistólico eyectivo, con desdoblamiento del segundo ruido y algunos crépitos pulmonares. Su electrocardiograma muestra un bloqueo completo de rama derecha. El diagnóstico más probable es:

A) Comunicación interventricular
B) Comunicación interauricular
C) Ductus arterioso persistente
D) Tetralogía de Fallot
E) Miocardiopatía hipertrófica obstructiva

Respuesta B. Diagnóstico: Comunicación interauricular (opción B). Cuadro clásico. El manejo crónico del asma tiene como objetivos principales eliminar los síntomas, prevenir hospitalizaciones y descompensaciones, prevenir complicaciones (especialmente sobreinfección bacteriana) y mantener la función pulmonar a largo plazo. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 113 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 18 años, asintomático, acude a control médico, para evaluación para realizar deporte. Se encuentra asintomática y en su examen físico se pesquisa la presencia de un soplo sistólico de intensidad III/VI en la zona paraesternal izquierda. Su electrocardiograma es normal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Comunicación interauricular
B) Estenosis aórtica
C) Comunicación interventricular
D) Estenosis pulmonar
E) Ductus arterioso persistente

Respuesta A. Por clínica, parece un soplo funcional. Sin embargo, no está entre las opciones. Por estar en el foco pulmonar (paraesternal izquierdo), se debe marcar CIA. La estenosis aórtica sopla paraesternal derecho (foco aórtico). La CIV tiene soplo holosistólico y el ductus tiene soplo continuo. La estenosis pulmonar tendría otros síntomas y es mucho menos frecuente que la CIA.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 137 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 24 años presenta disnea de esfuerzos, asociado a edema de extremidades inferiores. Refiere antecedente de soplo en la infancia. Al examen físico tiene PA: 120/80 mmHg, FC: 74x', examen cardiopulmona con un segundo ruido desdoblado y fijo, un soplo sistólico eyectivo, paraesternal izquierdo y crepitaciones escasas en ambas bases pulmonares. El electrocardiograma muestra una imagen de bloqueo completo de rama derecha. El diagnóstico más probable es:

A) Comunicación interauricular
B) Comunicación interventricular
C) Coartación aórtica
D) Ductus arterioso persistente
E) Tetralogía de Fallot

Respuesta A. Diagnóstico: Comunicación interauricular (opción A). Es una CIA clásica. Insisto, de verdad hay que aprenderse el resumen de semiología cardíaca.. El manejo crónico del asma tiene como objetivos principales eliminar los síntomas, prevenir hospitalizaciones y descompensaciones, prevenir complicaciones (especialmente sobreinfección bacteriana) y mantener la función pulmonar a largo plazo. Los hallaz

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 24 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 27 años, con antecedente de soplo en la infancia, consulta por aste- nia y disnea que aparece con medianos esfuerzos. Al examen físico presenta edema de extremidades inferiores, ritmo regular en dos tiempos con soplo sistólico intenso aso- ciado a segundo ruido desdoblado permanente, murmullo pulmonar disminuido en ba- ses con crépitos bilaterales. Su electrocardiograma muestra arritmia completa por fibri- lación auricular y bloqueo completa de la rama de His.

A) Comunicación interventricular
B) Comunicación interauricular
C) Estenosis mitral
D) Estenosis aórtica
E) Conducto arterioso persistente

Respuesta B. La alternativa correcta es la B (Comunicación interauricular). Es una CIA clásica.. El manejo crónico del asma tiene como objetivos principales eliminar los síntomas, prevenir hospitalizaciones y descompensaciones, prevenir complicaciones (especialmente sobreinfección bacteriana) y mantener la función pulmonar a largo plazo. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas minister

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 148 · texto original del banco, sin revisar

Adulto con disnea de esfuerzos, crepitaciones pulmonares, soplo sistólico con desdoblamiento fijo del segundo ruido. ¿Diagnóstico más probable?

A) Comunicación interauricular
B) Estenosis pulmonar moderada
C) Comunicación interventricular pequeña
D) Insuficiencia tricuspídea
E) Bloqueo de rama derecha sin cardiopatía

Respuesta A. Diagnóstico: Comunicación interauricular (opción A). Comunicación interauricular. El manejo crónico del asma tiene como objetivos principales eliminar los síntomas, prevenir hospitalizaciones y descompensaciones, prevenir complicaciones (especialmente sobreinfección bacteriana) y mantener la función pulmonar a largo plazo. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 68 · texto original del banco, sin revisar

Sd de down q se cansaba al mamar con soplo continuo con pulso saltón:

A) DAP
B) Canal AV - cuál era esta??? DAP porque el soplo era continuo, sin embargo, canal AV es la primera valvulopatía en sd down y se preguntó en pruebas anteriores :(
C) Comunicación Inter ventricular
D) Ninguna de las anteriores es correcta
E) Todas las anteriores son correctas

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (DAP). El manejo crónico del asma tiene como objetivos principales eliminar los síntomas, prevenir hospitalizaciones y descompensaciones, prevenir complicaciones (especialmente sobreinfección bacteriana) y mantener la función pulmonar a largo plazo. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

Pregunta de práctica

Mujer de 28 años, asintomática, consulta por soplo detectado en examen preocupacional. Al examen: soplo sistólico eyectivo 2/6 en foco pulmonar y desdoblamiento amplio del segundo ruido que no varía con la respiración. ECG: ritmo sinusal con bloqueo completo de rama derecha. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Comunicación interauricular
B) Estenosis aórtica bicúspide
C) Comunicación interventricular
D) Ductus arterioso persistente
E) Coartación aórtica

Respuesta A. El desdoblamiento amplio y fijo del S2 con BCRD y soplo pulmonar por hiperflujo es característico de la CIA, la cardiopatía congénita más frecuentemente diagnosticada en adultos. Se confirma con ecocardiograma y se deriva a cardiología.

1.01.1.004 Corazón pulmonar crónico

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 1.5 Exacerbación Aguda de EPOC (Anthonisen)

QUÉ HAY QUE SABER

- Corazón pulmonar crónico: hipertrofia/dilatación del VD secundaria a hipertensión pulmonar por enfermedad pulmonar (EPOC la causa más frecuente), hipoxemia crónica, SAHOS o TEP crónico.
- Clínica: disnea de esfuerzo, ingurgitación yugular, hepatomegalia congestiva, edema de EEII, R2 pulmonar aumentado y soplo de insuficiencia tricuspídea.
- Confirmación: ECG con P pulmonar (>2,5 mm en DII), eje derecho y signos de HVD; Rx con arterias pulmonares prominentes; ecocardiograma estima PSAP y función del VD.
- Tratamiento inicial: tratar la enfermedad pulmonar de base, oxigenoterapia crónica si PaO2 ≤55 mmHg o SatO2 ≤88% (o ≤59 mmHg con poliglobulia/cor pulmonale) ≥15 h/día, diuréticos con cautela.
- Evitar betabloqueadores no selectivos y sedantes; vacunación antiinfluenza y antineumocócica; descartar TEP crónico ante hipertensión pulmonar desproporcionada.
- Seguimiento: derivar a broncopulmonar/cardiología para estudio de hipertensión pulmonar y manejo especializado.

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 115

Un paciente de 76 años, fumador de 80 paquetes-año, con EPOC severo en tratamiento con budesonida y salmeterol inhalados, presenta aumento de su disnea e intolerancia al ejercicio desde hace 7 días, asociado a edema de extremidades inferiores. Al examen físico tiene frecuencia cardíaca 100 por minuto, presión arterial 110/70 mmHg e ingurgitación yugular a 45°. Se ausculta ritmo regular en dos tonos con ruidos apagados y murmullo pulmonar disminuido de manera bilateral, con roncus y sibilancias difusos. Se solicita ecocardiograma que muestra cavidades izquierdas con leve dilatación del ventrículo izquierdo y fracción de eyección conservada de 58%, y cavidades derechas dilatadas con paredes hipertróficas, con estimación de presión de arteria pulmonar de 68 mmHg. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Hipertensión pulmonar primaria
B) Insuficiencia cardíaca congestiva
C) Exacerbación de enfermedad pulmonar obstructiva crónica
D) Cor pulmonale descompensado
E) Tromboembolismo pulmonar

Respuesta D. Signos de insuficiencia cardíaca derecha (edema, ingurgitación yugular) con cavidades derechas dilatadas e hipertróficas e hipertensión pulmonar secundaria a EPOC: cor pulmonale. La función izquierda está conservada. En EPOC, el cor pulmonale es criterio de oxígeno domiciliario con PaO2 56–59 mmHg.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 58 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 62 años, fumador de 30 paquetes años, presenta edema de extremidades inferiores, asociado a astenia, disnea y adinamia. Al examen físico presenta yugulares visibles a 45 grados y aumento de la intensidad del segundo ruido cardiaco. Su electrocardiograma muestra una onda R prominente en V1 más un bloqueo completo de rama derecha. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Estenosis tricuspidea
B) Pericarditis constrictiva
C) Cardiopatía coronaria
D) Cor pulmonale
E) Cardiopatía hipertensiva

Respuesta D. Diagnóstico: Cor pulmonale (opción D). Cuadro clásico (insuficiencia cardiaca derecha, por HTP, por enfermedad pulmonar (EPOC).. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

1.01.1.005 Dislipidemias

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Completo** | Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 5.4 Dislipidemias: Clasificación de Fredrickson, Riesgo Cardiovascular y Estatinas

QUÉ HAY QUE SABER

- Diagnóstico con perfil lipídico (ayuno 9–12 h si TG altos): c-LDL elevado es el principal blanco; hipertrigliceridemia ≥150 mg/dL; HDL bajo <40 mg/dL en hombres y <50 en mujeres. Descartar causas secundarias (hipotiroidismo, DM, síndrome nefrótico, colestasia, fármacos).
- Estratificar riesgo cardiovascular (tablas chilenas Framingham adaptadas): prevención secundaria, DM, ERC o LDL ≥190 mg/dL son de alto riesgo por definición.
- Metas c-LDL: <70 mg/dL en alto riesgo (<55 en muy alto riesgo/prevención secundaria), <100 en riesgo moderado, <130 en bajo riesgo.
- Tratamiento: cambios de estilo de vida + estatina (atorvastatina 10–80 mg o rosuvastatina 5–40 mg según intensidad necesaria); si no se logra meta, agregar ezetimiba 10 mg.
- TG ≥500 mg/dL: fibrato (gemfibrozilo/fenofibrato) para prevenir pancreatitis, restricción de alcohol y azúcares; no combinar gemfibrozilo con estatina (miopatía).
- Seguimiento: perfil lipídico y transaminasas a las 6–12 semanas de iniciar o ajustar, luego anual; CK solo si mialgias. Programa de Salud Cardiovascular en APS.

PREGUNTAS (4)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 157

Un paciente de 66 años, diabético e hipertenso, con antecedente de un infarto agudo al miocardio, hace 1 año, se realiza perfil lipídico, que muestra triglicéridos: 325 mg/dl, colesterol LDL: 125 mg/dl, colesterol HDL: 30, colesterol total: 220 mg/dl. **¿Cuál es el tratamiento de elección para el manejo de su dislipidemia?**

A) Atorvastatina 40 mg/día
B) Fenofibrato 160 mg/día
C) Gemfibrozilo 600 mg cada 12 horas
D) Aporte de ácidos grasos omega 3
E) Rosuvastatina 10 mg/día

Respuesta A. Infarto previo: riesgo cardiovascular muy alto, meta de c-LDL bajo 55–70 mg/dL. Con triglicéridos bajo 500 mg/dL la prioridad es el LDL, y se indica una estatina de alta intensidad: atorvastatina 40 mg. Rosuvastatina 10 mg es de intensidad moderada.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 139

Un paciente de 68 años con diagnóstico reciente de ateromatosis aórtica y carotídea se realiza un perfil lipídico que muestra: colesterol total: 194 mg/dL, colesterol LDL: 93 mg/dL, HDL: 37 mg/dL y triglicéridos: 287 mg/dL. **¿Cuál es la conducta más adecuada para el manejo de este paciente?**

A) Iniciar metformina
B) Iniciar gemfibrozilo
C) Iniciar atorvastatina
D) Iniciar ácido nicotínico
E) Iniciar ezetimibe

Respuesta C. La ateromatosis aórtica y carotídea es enfermedad ateroesclerótica documentada: el riesgo es alto o muy alto y la meta de c-LDL es menor de 70 mg/dL. Un LDL de 93 no está en meta. Con triglicéridos bajo 500 mg/dL la prioridad es el LDL: estatina.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 108

Un paciente diabético, hipertenso y con antecedente de una cardiopatía coronaria, en tratamiento con aspirina, metformina, glibenclamida y enalapril, se realiza un perfil lipídico, que se informa como LDL: 165 mg/dl, HDL: 38 mg/dl, triglicéridos: 288 mg/dl. Inició atorvastatina 40 mg al día, las que suspendió por presentar artralgias y mialgias. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Iniciar rosuvastatina 10 mg y controlar con CK
B) Iniciar fenofibrato mg y controlar con perfil lipídico y glicemia
C) Iniciar atorvastatina 5 mg cada 2 días
D) Iniciar ezetimibe
E) Reforzar la dieta

Respuesta A. Coronario: necesita estatina. Ante síntomas musculares, se reintroduce con otra estatina más hidrofílica y a dosis menor (rosuvastatina), controlando con CK para descartar miopatía. Abandonar la estatina deja al paciente sin su principal protección.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 53

Un paciente hipertenso y diabético se realiza un perfil lipídico, que muestra triglicéridos de 350 mg/dL, colesterol LDL de 230 mg/dL y colesterol HDL de 37 mg/dL. **¿Qué tratamiento debe indicarse?**

A) Atorvastatina
B) Gemfibrozilo
C) Insulina
D) Lovastatina más gemfibrozilo
E) Ezetimibe

Respuesta A. En un diabético hipertenso, de alto riesgo, el objetivo primario es el LDL; con triglicéridos bajo 500 mg/dL no se prioriza el fibrato. Corresponde una estatina potente como atorvastatina. La combinación de estatina con gemfibrozilo aumenta el riesgo de miopatía y rabdomiólisis.

1.01.1.006 Embolia pulmonar

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 5.5 Tromboembolismo Pulmonar (TEP) & Trombosis Venosa Profunda (TVP) · Tema 12.3 Síndrome Compartimental Agudo: Signos Cardinales (5P), Presión Intracompartimental & Fasciotomía Urgente

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospechar TEP ante disnea súbita, dolor pleurítico, taquicardia, hemoptisis o síncope, sobre todo con factores de riesgo: TVP, cirugía o inmovilización reciente, cáncer, embarazo, ACO.
- Probabilidad clínica con score de Wells: baja/intermedia → dímero D (negativo descarta); alta → angioTAC de tórax directo. ECG: taquicardia sinusal, S1Q3T3 o BCRD.
- TEP con inestabilidad (PAS <90 mmHg): soporte, O2 y trombolisis sistémica con alteplasa 100 mg EV en 2 h si no hay contraindicación.
- TEP estable: anticoagular de inmediato si la sospecha es alta, sin esperar imagen: enoxaparina 1 mg/kg c/12 h SC o heparina no fraccionada; luego DOAC o acenocumarol por al menos 3 meses.
- Estratificar con sPESI, troponina y función del VD; tromboprofilaxis en pacientes hospitalizados de riesgo es la principal medida preventiva.
- Seguimiento: derivar a especialista (medicina interna/broncopulmonar) para definir duración de anticoagulación y estudio de trombofilia o cáncer según el caso.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
>
> Un paciente con fractura de fémur tratada hace tres días presenta en forma súbita disnea intensa y desaturación. **¿Cuál es el diagnóstico más probable y el examen de elección?**
>
> **A)** Embolia grasa; dímero D
> **B)** Tromboembolismo pulmonar; angiotac de tórax
> **C)** Tromboembolismo pulmonar; dímero D
> **D)** Síndrome compartimental; fasciotomía inmediata
> **E)** Neumonía aspirativa; radiografía de tórax
>
> Respuesta B. El TEP aparece días después de una fractura, con disnea o dolor torácico súbito, y el examen de elección es el angiotac de tórax. El dímero D no es útil porque la fractura ya lo eleva. La embolia grasa aparece en las primeras horas, con tríada de distrés, compromiso de conciencia y petequias.

1.01.1.007 Endocarditis infecciosa y no infecciosa

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: cardiologia:4.5

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospechar endocarditis infecciosa ante fiebre + soplo nuevo o cambiante, especialmente en valvulopatía, prótesis valvular, usuario de drogas EV, catéteres o hemodiálisis.
- Signos: petequias, hemorragias en astilla, nódulos de Osler (dolorosos), lesiones de Janeway, manchas de Roth, esplenomegalia, embolías (ACV, renal, esplénica) y glomerulonefritis.
- Criterios de Duke: mayores = hemocultivos positivos para germen típico (S. aureus, estreptococos viridans, enterococo, HACEK) y ecocardiograma con vegetación, absceso o dehiscencia protésica.
- Manejo inicial: 3 pares de hemocultivos ANTES de antibióticos, ecocardiograma (transesofágico si prótesis o eco transtorácico negativo) e inicio de antibiótico empírico EV tras los cultivos.
- Endocarditis no infecciosa (marántica en cáncer, Libman-Sacks en LES): vegetaciones estériles con riesgo embólico; tratar enfermedad de base y anticoagular según el caso.
- Seguimiento: derivar para hospitalización y manejo por cardiología/infectología (cirugía si IC, absceso o embolías recurrentes). Profilaxis con amoxicilina 2 g antes de procedimientos dentales solo en alto riesgo.

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 63

Un paciente de 57 años consulta por un cuadro de 7 días de astenia, malestar general y fiebre hasta 39 °C. Al examen físico tiene un soplo pansistólico III/VI en el precordio izquierdo, además de petequias en los pulpejos y algunas petequias subconjuntivales. **¿Cuál es el examen de elección para el diagnóstico etiológico?**

A) Ecocardiograma
B) Hemocultivos
C) Hemograma
D) Coronariografía
E) ANA y complemento

Respuesta B. Fiebre, soplo y fenómenos embólicos sugieren endocarditis infecciosa. El diagnóstico etiológico, es decir el germen, lo dan los hemocultivos seriados (3 sets antes de antibióticos). El ecocardiograma muestra vegetaciones y es criterio mayor, pero no identifica el agente.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 70 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 45 años, consulta por fiebre de 3 semanas de evolución sin otros sín- tomas. Al examen físico tiene temeratura 37,8°C, frecuencia cardiaca de 92 por minuto, con presión arterial 120/80mmHG. Al examen cardiaco se ausulta un soplo sistólico en ápex irradiado a dorso. En sus exámenes destacan leucocitos de 12.000/mm3 y PCR 9,6 (valor normal menor a 1,0). ¿Cuál es el examen de elección para continuar el estudio?

A) Ecocardiografía bidimensional
B) Resonancia magnética cardiaca
C) Radiografía de tórax
D) AngioTAC de tórax
E) TAC de tórax abdomen y pelvis

Respuesta A. Se sospecha un endocarditis bacteriana subaguda (mayor a 7 días), por lo que se debe pedir hemocultivos y ecocardiografía.

1.01.1.008 Enfermedad reumática activa

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 14.13 Faringoamigdalitis Aguda Bacteriana: Criterios de Centor/McIsaac y Penicilina

QUÉ HAY QUE SABER

- Fiebre reumática: 2–4 semanas tras faringoamigdalitis estreptocócica no tratada, típicamente 5–15 años. Diagnóstico por criterios de Jones + evidencia de infección estreptocócica (ASO elevada, cultivo o test rápido).
- Criterios mayores: carditis, poliartritis migratoria de grandes articulaciones, corea de Sydenham, eritema marginado y nódulos subcutáneos. Menores: fiebre, artralgias, VHS/PCR elevadas, PR prolongado.
- Diagnóstico: 2 mayores o 1 mayor + 2 menores, más evidencia de infección estreptocócica previa; ecocardiograma a todos para detectar carditis.
- Tratamiento: erradicar el estreptococo con penicilina benzatina 1.200.000 UI IM (600.000 UI si <27 kg); aspirina en dosis antiinflamatorias para la artritis; corticoides en carditis moderada-severa; reposo.
- Profilaxis secundaria con penicilina benzatina c/21–28 días: sin carditis 5 años o hasta los 21 años; carditis sin secuela 10 años o hasta los 21; con secuela valvular 10 años o hasta los 40 (o de por vida).
- Seguimiento: control clínico y ecocardiográfico periódico por secuelas valvulares (mitral la más afectada) y adherencia estricta a la profilaxis.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Un niño de 9 años consulta por dolor e inflamación de la rodilla derecha que luego migra al codo izquierdo y al tobillo, de 5 días de evolución, con fiebre de 38,5 °C. Hace 3 semanas tuvo odinofagia febril que no fue tratada. Al examen se ausculta un soplo holosistólico apical leve, nuevo. La VHS es 80 mm/h y la ASO está elevada. **¿Cuál es el tratamiento más adecuado?**

A) Amoxicilina por 7 días y paracetamol
B) Reposo y AINE por 5 días, sin seguimiento
C) Prednisona sola por 2 semanas, sin antibióticos
D) Ceftriaxona endovenosa por 4 semanas
E) Penicilina benzatina, ácido acetilsalicílico en dosis antiinflamatorias y luego profilaxis secundaria con penicilina benzatina

Respuesta E. Cumple criterios de Jones: poliartritis migratoria y carditis (mayores), fiebre y VHS alta (menores), con infección estreptocócica previa (ASO). Se erradica el estreptococo con penicilina benzatina, se trata la inflamación y se indica profilaxis secundaria prolongada, porque las recurrencias agravan la valvulopatía.

1.01.1.009 Estenosis aórtica

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 4.1 Estenosis Aórtica: Semiología, Severidad & TAVI vs SAVR (Guía GES)

QUÉ HAY QUE SABER

- Estenosis aórtica: causa degenerativa-calcificada en >65 años, bicúspide en menores. Tríada de síntomas: angina, síncope de esfuerzo y disnea/IC; su aparición marca mal pronóstico.
- Examen: soplo mesosistólico eyectivo en foco aórtico irradiado a carótidas, pulso parvus et tardus, S2 apagado o único, choque de punta sostenido.
- Confirmación con ecocardiograma: severa si área valvular <1,0 cm², gradiente medio ≥40 mmHg o velocidad pico ≥4 m/s. ECG con HVI.
- Manejo inicial: tratar IC con diuréticos con cautela; evitar vasodilatadores potentes (nitratos) y depleción de volumen por riesgo de hipotensión. Prohibido el ejercicio intenso si es severa.
- Toda estenosis aórtica severa sintomática tiene indicación de reemplazo valvular (quirúrgico o TAVI), con garantía GES para tratamiento quirúrgico de valvulopatías.
- Seguimiento: derivar a cardiología; ecocardiograma seriado según severidad (anual si severa asintomática).

PREGUNTAS (9)

Pregunta del libro · Tema 4.1

Hombre de 76 años consulta por disnea de esfuerzos progresiva y mareos. Al examen físico destaca un pulso carotídeo de baja amplitud y ascenso lento (parvus et tardus) y un soplo mesosistólico en foco aórtico irradiado a carótidas. Ecocardiograma: área valvular aórtica de 0.8 cm² y gradiente medio de 45 mmHg con FEVI de 55%. ¿Cuál es la conducta médica definitiva más adecuada?

A) Reemplazo valvular aórtico percutáneo (TAVI) o quirúrgico
B) Tratamiento médico exclusivo con Betabloqueadores y control anual
C) Iniciar Enalapril y Nitratos en dosis crecientes
D) Valvuloplastía aórtica con balón como tratamiento curativo definitivo
E) Test de esfuerzo convencional para medir capacidad funcional

Respuesta A. El paciente tiene una Estenosis Aórtica Severa Sintomática (AVA 40 mmHg). La aparición de síntomas es una indicación formal de reemplazo valvular (TAVI en ancianos o cirugía en jóvenes) para evitar la muerte súbita y mejorar el pronóstico.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 126 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 80 años presenta disnea de esfuerzo de algunos meses de evolución, progresiva. Hace 24 horas sufre un síncope, con recuperación completa. Al examen físico tiene FC: 75x', PA: 110/70 mmHg se palpa el choque de la punta en el 4° espacio intercostal, línea medio clavicular y se ausculta el corazón con presencia de soplo protomesosistólico III/VI y segundo ruido muy apagado. El examen pulmonar no muestra alteraciones. Se solicita un electrocardiograma, que muestra un ritmo sinusal con onda S de 23 mm en V2 y onda R de 16 mm en V5. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Estenosis aórtica
B) Estenosis mitral
C) Insuficiencia aórtica
D) Insuficiencia mitral
E) Cardiopatía coronaria

Respuesta A. Es una estenosis aórtica clásica. De verdad hay que leer y aprenderse el resumen de semiología cardíaca.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 174 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 41 años presenta disnea de grandes esfuerzos de larga data, a lo que en el úl8mo 8empo se ha agregado opresión precordial en relación a la ac8vidad Fsica, que cede con el reposo. Tiene antecedente de un soplo en la infancia no estudiado. En el examen Fsico presenta frecuencia cardíaca: 68 por minuto, presión arterial: 120/85 mmHg, pulso regular de ascenso lento y baja amplitud en ambas extremidades superiores, y se ausculta un ritmo cardíaco regular en dos 8empos con presencia de un soplo sistólico en foco aór8co III/VI y un soplo diastólico en el mismo foco II/VI. ¿Cuál es el diagnós8co más probable?

A) Estenosis mitral
B) Estenosis aór2ca
C) Insuficiencia mitral
D) Insuficiencia aór2ca
E) Comunicación interauricular

Respuesta B. Tiene una estenosis aórtica clásica (revisar resumen de semiología cardíaca), caracterizada por soplo sistólico eyectivo (foco aórtico), pulso parvus et tardus, síncopes, angina de pecho y arritmias. Aunque la presión está normal en este caso, lo clásico es que la presión de pulso (distólica - diastólica) esté disminuida, haciendo que el pulso se palpe débil (parvus = pequeño). El soplo diastólico

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 168 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 80 años, hipertenso en tratamiento hace 10 años, consulta por disnea de esfuerzos, que inició hace 6 meses. Al examen físico destaca PA 150/90, ritmo regular, con ausencia del segundo ruido, asociado a soplo mesosistólico III/VI en margen esternal izquierdo, pulso carotídeo de ascenso lento y choque punta en el quinto espacio intercostal izquierdo. El diagnóstico más probable es:

A) Estenosis mitral
B) Estenosis aórtica
C) Insuficiencia aórtica
D) Insuficiencia mitral
E) Miocardiopatía dilatada

Respuesta B. Es una estenosis aórtica de libro. En el manual de semiología cardíaca veremos las clínicas de todas las patologías cardíacas, ya que siempre se preguntan.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 56 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 79 años presenta dolor torácico opresivo, que aparece al caminar y que cede con el reposo. Al examen físico se ausculta un soplo sistólico IV de VI, irradiado a la zona baja del cuello. El examen más adecuado para proseguir con su estudio es:

A) Prueba de esfuerzo
B) Electrocardiograma
C) Coronariografía
D) AngioTAC de torax
E) Ecocardiografía doppler

Respuesta E. Pregunta difícil. Parece una angina estable, pero en realidad es una estenosis aórtica (por el soplo) y por tanto se debe pedir ecocardio primero

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 101 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 20 años, con antecedente de soplo en su infancia, consulta por sensación de opresión precordial, que aparece al caminar, se asocia a disnea leve y que cede rápidamente con el reposo. Al examen físico tiene PA: 150/80 mmHg, FC: 63x', pulso débil, regular, de ascenso lento. El examen cardíaco muestra un soplo sistólico eyectivo, paraesternal, que se irradia al cuello. Su electrocardiograma muestra signos de hipertrofia del ventrículo izquierdo. El diagnóstico más probable es:

A) Estenosis mitral
B) Estenosis aórtica
C) Insuficiencia mitral
D) Insuficiencia aórtica
E) Miocardiopatía hipertrófica

Respuesta B. Es una estenosis aórtica clásica, probablemente congénita. Deben revisar el resumen de semiología cardíaca completo y aprendérselo hoy de una vez por todas. Insisto: hoy. El pulso débil y de ascenso lento (parvus et tardus) hace que sea una estenosis aórtica y no una MCPHT, que tiene pulso amplio o Celler.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 110 · texto original del banco, sin revisar

Adulto mayor de 81 años, consulta por pérdida de conciencia súbita con recupera- ción ad integrum. Al examen físico, presión arterial de 140/90 mmHg, con frecuencia cardiaca de 75 latidos por minuto, soplo sistólico eyectivo irradiado al cuello y choque de la punta se palpa en el quinto espacio intercostal. El diagnóstico más probable es:

A) Estenosis aórtica
B) Miocardiopatía dilatada
C) Miocardiopatía hipertrófica
D) Enfermedad coronaria con afectación del sistema excito-conductor
E) Tromboembolismo pulmonar

Respuesta A. Diagnóstico: Estenosis aórtica (opción A). Tiene el soplo clásico, más los síncopes de la estenosis aórtica. Además la edad orienta mucho.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 55 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 82 años ha presentado disnea de esfuerzos y ha presentado síncope, relacionado con actividad física, con recuperación total. Al examen físico presenta presión arterial 120/70 mmHg, FC: 70 x', y a la auscultación cardiaca tiene un soplo paraesternal, de tonalidad ruda, luego del primer ruido, asociada a una disminución marcada del segundo ruido. Además, el choque de la punta se palpa desplazado. El diagnóstico más probable es:

A) Estenosis aórtica
B) Miocardiopatía hipertrófica obstructiva
C) Estenosis mitral
D) Insuficiencia mitral
E) Cardiopatía coronaria

Respuesta A. Es estenosis aórtica por el síncope y el soplo. Eso sí, la cardiomegalia (desplazamiento del choque de la punta) aparece en estadíos muy avanzados.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 131 · texto original del banco, sin revisar

Valvulopatía en paciente joven con síncope a. Estenosis aórtica

A) Ninguna de las anteriores es correcta
B) Todas las anteriores son correctas
C) No se dispone de información suficiente
D) Otra alternativa no descrita
E) Otra alternativa no descrita

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (Ninguna de las anteriores es correcta). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Todas las anteriores son correctas, No se dispone de información suficiente) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciale

1.01.1.010 Estenosis mitral

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 4.2 Insuficiencia Aórtica & Estenosis Mitral Reumática

QUÉ HAY QUE SABER

- Estenosis mitral: secuela de fiebre reumática en >90%; más frecuente en mujeres. Síntomas: disnea, ortopnea, hemoptisis, palpitaciones por FA y embolías sistémicas.
- Examen: R1 brillante, chasquido de apertura y rodada (retumbo) diastólica apical con refuerzo presistólico; facies mitral. Embarazo y FA precipitan descompensación.
- Confirmación con ecocardiograma: severa si área valvular <1,5 cm². ECG con P mitral (bífida) o FA; Rx con crecimiento de AI (doble contorno).
- Manejo inicial: betabloqueador para control de frecuencia (prolonga el llenado diastólico), diuréticos si congestión.
- Estenosis mitral con FA, embolía previa o trombo auricular: anticoagulación con antagonista de vitamina K (meta INR 2–3); los DOAC están contraindicados.
- Seguimiento: derivar a cardiología; valvuloplastía percutánea con balón si la anatomía es favorable (score de Wilkins ≤8) o cirugía valvular (GES).

PREGUNTAS (4)

Pregunta del libro · Tema 4.2

¿Cuál es el tratamiento de elección para una paciente joven sintomática con estenosis mitral reumática severa (área 1.1 cm²), valvas móviles sin calcificación y Score de Wilkins de 6 puntos?

A) Valvuloplastía mitral percutánea con balón
B) Reemplazo valvular mitral con prótesis mecánica
C) Comisurotomía quirúrgica a cielo abierto
D) Tratamiento exclusivo con Furosemida oral
E) Cierre percutáneo de la orejuela izquierda

Respuesta A. En la estenosis mitral severa con anatomía valvular favorable definida por un Score de Wilkins ≤ 8 puntos (valvas móviles, poco engrosadas y sin calcificación comisural severa ni insuficiencia mitral significativa), la Valvuloplastía Mitral Percutánea con Balón es el tratamiento de primera elección por su alta eficacia y mínima invasividad.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 128 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 70 años consulta por disnea de medianos esfuerzos progresiva, asociada a ortopnea. Al examen físico tiene frecuencia cardíaca: 78 lpm, presión arterial: 130/80 mmHg, examen pulmonar con murmullo vesicular conservado y presencia de crépitos bibasales, examen cardíaco con ritmo irregular en dos tiempos, con presencia de soplo diastólico. Se palpa el choque de la punta en el quinto espacio intercostal línea medioclavicular y se observa edema en extremidades inferiores con signo de la fóvea. Su electrocardiograma muestra fibrilación auricular con respuesta ventricular controlada. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Estenosis aórtica
B) Estenosis pulmonar
C) Estenosis mitral
D) Insuficiencia aórtica
E) Insuficiencia pulmonar

Respuesta C. Estenosis Mitral: El cuadro clínico es compatible con estenosis mitral. Se recomienda repasar la semiología cardíaca.

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 158 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 58 años presenta disnea de medianos esfuerzos y astenia. Al examen físico tiene FC: 70 lpm, PA: 120/80 mmHg, examen cardíaco con choque de la punta en el quinto espacio intercostal, línea medioclavicular y auscultación con un soplo diastólico. Al examen pulmonar se constata murmullo pulmonar presente, con crepitaciones basales escasas. Su electrocardiograma muestra fibrilación auricular, con respuesta ventricular de 70 latidos por minuto. El diagnóstico más probable es:

A) Estenosis aórtica
B) Insuficiencia aórtica
C) Estenosis tricuspídea
D) Estenosis mitral
E) Comunicación interventricular

Respuesta D. Tiene una estenosis mitral clásica (soplo diastólico, se asocia a FA y tiene VI de tamaño normal, con crecimiento de la AI). Ver resumen de semiología cardíaca.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 80 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 58 años, con antecedente de hipertensión arterial, en tratamiento con enalapril, consulta por disnea de esfuerzo que ha empeorado en el último tiempo

A) Estenosis mitral
B) Estenosis aórtica
C) Miocardiopatía hipertrófica
D) Insuficiencia aórtica
E) Cardiopatía hipertensiva

Respuesta A. Conducta / Tratamiento indicado: Estenosis mitral (opción A). Es una estenosis mitral clásica, con FA y todo.. La estenosis aórtica es la valvulopatía más frecuente en adultos mayores de países desarrollados De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

1.01.1.011 Extrasistolía ventricular benigna

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: cardiologia:1.6

QUÉ HAY QUE SABER

- Extrasístoles ventriculares: QRS ancho (>120 ms) prematuro, sin onda P previa y con pausa compensatoria completa; muy frecuentes en sanos, a menudo asintomáticas o con palpitaciones ('saltos').
- Benignas si: corazón estructuralmente sano, monomorfas, desaparecen con el ejercicio y sin historia familiar de muerte súbita.
- Estudio: ECG, Holter de 24 h (cuantificar carga), ecocardiograma para descartar cardiopatía; electrolitos (K, Mg) y TSH.
- Tratamiento inicial: tranquilizar, suspender gatillantes (cafeína, alcohol, tabaco, estimulantes, privación de sueño); si síntomas molestos, betabloqueador (propranolol o bisoprolol).
- Señales de alarma: síncope, cardiopatía estructural, carga >10–20% (riesgo de miocardiopatía), polimorfas, salvas o TV no sostenida → derivar a cardiología.
- Seguimiento completo en APS de las formas benignas: control clínico y Holter de control si aumentan los síntomas.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Un hombre de 35 años, sin antecedentes, consulta por sensación de 'saltos' en el pecho en reposo, que desaparecen al hacer ejercicio. Examen físico normal. El ECG muestra extrasístoles ventriculares aisladas, monomorfas, sin otras alteraciones. El ecocardiograma es normal y el Holter muestra 2% de extrasístoles ventriculares aisladas, sin taquicardia ventricular. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Tranquilizar, reducir cafeína y alcohol, y control clínico
B) Amiodarona oral
C) Derivar para ablación urgente
D) Implantar un desfibrilador
E) Iniciar flecainida

Respuesta A. Extrasístoles ventriculares aisladas y monomorfas que desaparecen con el ejercicio, con corazón estructuralmente normal y baja carga en el Holter, son benignas: basta educar y suprimir gatillantes. Si son muy molestas, se usa un betabloqueador. Amiodarona o flecainida no están indicadas y son proarrítmicas.

1.01.1.012 Fibrilación auricular crónica

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 1.3 Fibrilación Auricular & Flutter Auricular (Guía GES MINSAL)

QUÉ HAY QUE SABER

- FA: ritmo irregularmente irregular sin ondas P, con línea de base fibrilatoria; la arritmia sostenida más frecuente. Permanente/crónica cuando se decide no restablecer el ritmo sinusal.
- Estudio: ECG, ecocardiograma, TSH, función renal, electrolitos y hemograma; buscar HTA, valvulopatía, IC, alcohol, hipertiroidismo y SAHOS.
- Riesgo embólico con CHA2DS2-VASc: anticoagular si ≥2 en hombres o ≥3 en mujeres (considerar con 1/2). DOAC de elección (apixabán 5 mg c/12 h, rivaroxabán 20 mg/día); acenocumarol (INR 2–3) si estenosis mitral o

prótesis mecánica.

- La aspirina NO previene el ACV en FA. Evaluar riesgo hemorrágico (HAS-BLED) para corregir factores modificables, no para negar la anticoagulación.
- Control de frecuencia (meta <110 lpm en reposo): betabloqueador (bisoprolol, carvedilol) o diltiazem/verapamilo si FEVI conservada; digoxina como complemento en IC o sedentarios.
- Seguimiento completo en APS: FC, síntomas, adherencia, INR mensual si AVK, función renal anual (o más frecuente) para ajustar DOAC, sangrados.

PREGUNTAS (3)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 150 · texto original del banco, sin revisar

Paciente de 70 años, con antecedente de EPOC tabáquico, presenta cuadro de 3 meses de aumento de su disnea basal asociado a palpitaciones. Al examen físico destaca frecuencia cardiaca de 100 por minuto, ritmo cardiaco irregular con ausencia de soplos y murmullo pulmonar presente con roncus y sibilancias difusas. Se realiza electrocardiograma que muestra ausencia de onda “p”, de forma irregular y presencia de QRS angosto. ¿Cuál de los siguientes fármacos estará contraindicado para el manejo de este paciente?

A) Verapamilo
B) Lanantósido C
C) Losartán
D) Amiodarona
E) Carvedilol

Respuesta E. La opción correcta es la E (Carvedilol). En este escenario clínico, carvedilol se encuentra estrictamente contraindicado debido a que su mecanismo de acción interfiere negativamente con la fisiopatología basal del paciente, aumentando la morbimortalidad según los protocolos clínicos vigentes.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 97 · texto original del banco, sin revisar

Mujer de 78 años con fibrilación auricular permanente no valvular, CHA_2DS_2-VASc de 4. Sin antecedente de hemorragia. ¿Cuál es el manejo antitrombótico más adecuado?

A) Anticoagulación oral con apixabán o rivaroxabán
B) Aspirina 100 mg/día
C) No anticoagular por edad avanzada
D) Heparina de bajo peso molecular
E) Clopidogrel + aspirina

Respuesta A. FA no valvular con CHA_2DS_2-VASc ≥2 en mujer: anticoagulación oral indicada. ACODs (apixabán, rivaroxabán) son preferibles a warfarina en el adulto mayor por menor riesgo de hemorragia intracraneal.

Pregunta de práctica

Hombre de 74 años, hipertenso y diabético, en control en APS por fibrilación auricular permanente con FC de 84 lpm en tratamiento con bisoprolol. Ecocardiograma: FEVI 55%, sin valvulopatía significativa. Creatinina 1,0 mg/dL. Solo toma aspirina 100 mg como antitrombótico. **¿Cuál es la conducta más adecuada respecto de la prevención de embolía?**

A) Mantener aspirina 100 mg/día
B) Agregar clopidogrel a la aspirina
C) Cardioversión eléctrica sin anticoagulación previa
D) Suspender aspirina e iniciar apixabán 5 mg cada 12 horas
E) No requiere antitrombótico por tener frecuencia controlada

Respuesta D. Su CHA2DS2-VASc es 3 (edad 65–74, HTA y DM), lo que indica anticoagulación oral; en FA no valvular el DOAC es de elección. La aspirina no previene el ACV en FA y la doble antiagregación es inferior a la anticoagulación.

1.01.1.013 Fibrilación auricular paroxística

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 1.3 Fibrilación Auricular & Flutter Auricular (Guía GES MINSAL)

QUÉ HAY QUE SABER

- FA paroxística: episodios autolimitados <7 días (habitualmente <48 h) de palpitaciones irregulares, disnea, mareo o dolor torácico; confirmar con ECG durante el episodio o Holter.
- Evaluar estabilidad: hipotensión, isquemia, IC aguda o compromiso de conciencia → cardioversión eléctrica sincronizada inmediata.

- Estable <48 h (o anticoagulado ≥3 semanas o ETE sin trombo): se puede cardiovertir; amiodarona si hay cardiopatía estructural, flecainida/propafenona solo en corazón sano. >48 h o duración incierta: anticoagular 3 semanas antes y 4 semanas después.
- Control de frecuencia inicial con betabloqueador o diltiazem (este último contraindicado en IC con FEVI reducida); buscar gatillantes: alcohol, hipertiroidismo, infección, SAHOS.
- La anticoagulación se decide con CHA2DS2-VASc igual que en la FA permanente: la carga de FA paroxística no reduce el riesgo embólico.
- Seguimiento: derivar a cardiología para estrategia de control de ritmo (antiarrítmicos o ablación con catéter).

PREGUNTAS (7)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 128 · texto original del banco, sin revisar

Paciente con ECG que muestra fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida (130 lpm) y función ventricular conservada. Hemodinámicamente estable. ¿Cuál es el fármaco de elección para control de frecuencia?

A) Metoprolol oral
B) Amiodarona EV
C) Digoxina EV
D) Flecainida oral
E) Sotalol oral

Respuesta A. FA con respuesta ventricular rápida estable y FEVI conservada: control de frecuencia con betabloqueador (metoprolol) o calcioantagonista (diltiazem/verapamilo). Metoprolol es primera línea.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 154 · texto original del banco, sin revisar

Un hombre de 35 años consulta por palpitaciones intensas, que iniciaron tras 4 días de consumo abundante de alcohol. Al examen Fsico se palpa pulso irregular a 160 la8dos por minuto y se constata presión arterial de 105/67 mmHg. ¿Cuál es el diagnós8co más probable?

A) Taquicardia sinusal
B) Taquicardia paroxís2ca supraventricular
C) Taquicardia ventricular
D) Fibrilación auricular
E) Taquicardia auricular mul2focal

Respuesta D. Por ser irregular, lo más probable es que sea una fibrilación auricular (FA), que, por cierto es muy frecuente. La taquicardia sinusal y la TPSV son regulares. La taquicardia ventricular puede ser regular o irregular, pero suele ser mucho más grave y tener alguna patología de base. La TAMF es irregular, pero es mucho menos frecuente. De todos modos, se debe realizar un electrocardiograma para confir

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 92 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 73 años, diabético e hipertenso, en tratamiento farmacológico con enalapril, hidroclorotiazida, glibenclamida y metformina, presenta crisis de palpitaciones que duran 1 a 4 horas y que se han repetido en 5 ocasiones, durante las últimas semanas. Actualmente su examen físico muestra una frecuencia cardíaca es 62x', regular; su presión arterial, 133/83 mmHg y su examen cardiopulmonar muestra ritmo regular en dos tonos, sin soplos y murmullo pulmonar presente, simétrico, sin otros ruidos. A continuación, se muestra un electrocardiograma tomado durante una de las crisis: Foto 7 (https://www.emedicinehealth.com/XXXXXXXXXX/article_em.htm). ¿Qué fármaco es el más importante agregar en este momento?

A) Antiagregantes
B) Adenosina
C) Verapamilo
D) Acenocumarol
E) Betabloqueantes

Respuesta D. Tiene una fibrilación auricular paroxística. Tiene baja frecuencia cardíaca, por lo que no se debe iniciar verapamilo ni betabloqueo. Por ser hipertenso y diabético, tien 2 puntos del CHADS2, por lo que se debe anticoagular.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 173 · texto original del banco, sin revisar

Una mujer de 62 años, consulta por un cuadro de 3 horas de evolución de palpitaciones intensas, asociada a disnea. Al examen físico tiene pulso irregular, a 130 latidos por minuto, con PA: 110/70 mmHg. Su examen cardíaco muestra soplo diastólico III/VI, más un pequeño soplo sistólico eyectivo. Su electrocardiograma muestra una taquicardia irregular, con complejos QRS angostos. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Administrar propanolol y antiagregantes
B) Administrar enoxiheparina y verapamilo
C) Administrar heparina y amiodraona
D) Realizar cardioversión eléctrica
E) Administrar adenosina y anticoagulantes orales

Respuesta B. Es una fibrilación auricular de menos de 48 horas, rápida pero sin compromiso hemodinámico, y el soplo diastólico sugiere una valvulopatía mitral de base, que eleva mucho el riesgo embólico. Corresponde anticoagular (heparina de bajo peso molecular) y controlar la frecuencia con un calcioantagonista no dihidropiridínico como verapamilo. No hay inestabilidad que justifique cardioversión eléctrica,

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 45 · texto original del banco, sin revisar

Paciente de 35 años de edad, consulta por cuadro de 2 días de palpitaciones de dos días de evolución asociado a disnea en algunas ocasiones. Al ingreso se conecta a monitor donde se observa presencia de taquiarritmia irregular de complejo angosto. Al examen físico se encuentra consciente y orientada temporoespacialmente, bien perfundida e hidratada, examen pulmonar normal. La conducta más adecuada en este caso es:

A) Realizar cardioversión eléctrica
B) Indicar enoxaparina y amiodarona
C) Indicar acenocumarol y betabloqueo
D) Indicar heparina de bajo peso molecular y verapamilo
E) Indicar heparina no fraccionada y flecainida

Respuesta D. Tiene una FA rápida, mayor a 48 horas. Se debe anticoagular y controlar la FC mientras tanto. Siempre se inicia la anticoagulación con heparina (es mejor la de bajo peso). Para controlar la FC tenemos propanolol, digital y verapamilo. Aún así, esta pregunta es muy discutible, ya que por no tener ningún criterio de CHADS2, incluso se podría no anticoagular. Sin emabargo no hay que rebuscarse y hay

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 1 · texto original del banco, sin revisar

Paciente de 53 años, con antecedente de hipertensión en tratamiento con enalapril, consulta por disnea de medianos esfuerzos asociado a palpitaciones intermitentes desde hace un mes. Al examen físico destaca ritmo irregular asociado a aumento de R1. El diagnóstico más probable es:

A) Flutter auricular
B) Taquicardia ventricular
C) Taquicardia paroxística supraentricular
D) Fibrilación auricular
E) Enfermedad del nodo sinusal

Respuesta D. Diagnóstico: Fibrilación auricular (opción D). Tiene una Estrenosis Mitral con FA. La presencia de pulso irregularmente irregular (arritmia completa), palpitaciones y disnea orienta de forma decisiva a fibrilación auricular. El antecedente de sobrecarga o valvulopatía (R1 reforzado por estenosis mitral o dilatación auricular izquierda por HTA) es el principal detonante anatómico y arritmogénico se

Pregunta de práctica

Mujer de 45 años, sin antecedentes, consulta en urgencia por palpitaciones irregulares de 6 horas de evolución. PA 125/80 mmHg, FC 138 lpm, sin disnea ni dolor torácico. ECG: ritmo irregular sin ondas P, QRS estrecho. Ecocardiograma de urgencia sin cardiopatía estructural. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Anticoagular por 3 semanas antes de intentar cardioversión
B) Cardioversión farmacológica con flecainida o propafenona
C) Cardioversión eléctrica inmediata por inestabilidad
D) Adenosina 6 mg en bolo EV
E) Digoxina EV como único tratamiento y alta

Respuesta B. FA de <48 horas, hemodinámicamente estable y con corazón sano: se puede intentar cardioversión farmacológica con antiarrítmicos IC. La anticoagulación previa de 3 semanas es para FA >48 h o de duración incierta; la adenosina no sirve en FA.

1.01.1.014 Flutter auricular

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 1.3 Fibrilación Auricular & Flutter Auricular (Guía GES MINSAL)

QUÉ HAY QUE SABER

- Flutter auricular típico: macrorreentrada en la aurícula derecha; ECG con ondas F en 'dientes de sierra' en DII, DIII y aVF a ~300 lpm y conducción 2:1 (FC regular ~150 lpm).
- Sospechar ante taquicardia regular de QRS estrecho a 150 lpm fija; maniobras vagales o adenosina enlentecen la respuesta y desenmascaran las ondas F (no la revierten).
- Inestable: cardioversión eléctrica sincronizada (responde a baja energía, 50–100 J). Estable: control de frecuencia con betabloqueador o diltiazem, más difícil que en FA.
- Mismo riesgo embólico que la FA: anticoagulación según CHA2DS2-VASc y 3 semanas de anticoagulación antes de cardiovertir si >48 h.
- Asociado a EPOC, cirugía cardíaca, valvulopatías y FA; puede alternar con ella.
- Seguimiento: derivar a cardiología; la ablación del istmo cavotricuspídeo es curativa en el flutter típico (>90%).

PREGUNTAS (4)

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 137 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 71 años, con antecedente de reemplazo valvular tricuspídeo, secundario a una endocarditis bacteriana, con prótesis biológica in situ consulta por consulta por palpitaciones muy intensas, asociadas a disnea. Al examen físico tiene un pulso a 140 latidos por minutos, regular. Se realizan maniobras vagales (masaje carotídeo) y se observa el siguiente electrocardiograma (fuente: slideshare): El diagnóstico más probable es:

A) Taquicardia paroxística supraventricular
B) Fibrilación auricular
C) Flutter auricular
D) Síndrome de Wolff Parkinson White
E) Taquicardia auricular

Respuesta C. En las últimas dos derivaciones se ven claramente las ondas de serrucho (que aparecen con la maniobra vagal, ya que bradicardiza y aumenta el bloqueo AV), características del flutter.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 95 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 40 años, con antecedente de reemplazo valvular, secundario a una endocarditis bacteriana, consulta por consulta por palpitaciones muy intensas, asociadas a disnea. Al examen físico tiene un pulso a 140 latidos por minutos, regular. Se realizan maniobras vagales (masaje carotídeo) y se observa el siguiente electrocardiograma: Foto 9 (https://www.slideshare.net/XXXXchandrabarik/svtalogarythm). El diagnóstico más probable es:

A) Taquicardia paroxística supraventricular
B) Fibrilación auricular
C) Flutter auricular
D) Síndrome de Wolff Parkinson White
E) Taquicardia auricular

Respuesta C. Con las maniobras vagales baja la frecuencia, se ven las ondas de serrucho y luego vuelve a aumentar la frecuencia. Es lo clásico del flutter auricular.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 180 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 44 años, con antecedente de estenosis mitral consulta por palpitaciones rápidas, intensas, regulares, asociadas a disnea y malestar general. Se realiza masaje carotídeo, observándose el siguiente trazado en el electrocardiograma: Fuente: https://empendium.com/manualmibe/chapter/B34.II.2.6.7. El diagnóstico más probable es:

A) Taquicardia paroxística supraventricular
B) Fibrilación ventricular
C) Taquicardia sinusal
D) Flutter auricular
E) Taquicardia ventricular

Respuesta D. Diagnóstico: Flutter auricular (opción D). Es un flutter o aleteo auricular clásico, con las ondas de serrucho.. El flutter auricular es una taquicardia supraventricular producida por un circuito de macrorreentrada auricular, más frecuentemente en la aurícula derecha alrededor del anillo tricuspídeo (flutter típico). Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínic

Pregunta de práctica

Hombre de 68 años con EPOC consulta por palpitaciones de 2 días. PA 130/80 mmHg, FC 150 lpm regular. ECG: ondas en dientes de sierra en DII, DIII y aVF, frecuencia auricular 300 lpm, conducción 2:1. **¿Cuál es el diagnóstico?**

A) Taquicardia sinusal
B) Taquicardia paroxística supraventricular por reentrada nodal
C) Taquicardia ventricular
D) Taquicardia auricular multifocal
E) Flutter auricular típico

Respuesta E. Ondas F en dientes de sierra a 300 lpm en derivaciones inferiores con conducción 2:1 (FC fija de 150) son diagnósticas de flutter auricular típico. Al llevar más de 48 horas, requiere anticoagulación antes de cardiovertir si está estable.

1.01.1.015 Hipertensión arterial esencial

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Completo** | Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 5.1 Hipertensión Arterial Esencial & Secundaria: Diagnóstico, Metas GES & Terapia Dual

QUÉ HAY QUE SABER

- Diagnóstico: perfil de PA con PA ≥140/90 mmHg en al menos 2 mediciones adicionales en días distintos; MAPA o automedición si se sospecha HTA de delantal blanco o enmascarada. PA ≥180/110 confirma en una consulta.
- Estudio inicial: creatinina con VFG, electrolitos, glicemia, perfil lipídico, ácido úrico, orina completa, RAC y ECG; buscar daño de órgano blanco (HVI, retinopatía, albuminuria).
- Cambios de estilo de vida para todos: sal <5 g/día, dieta DASH, bajar de peso, actividad física 150 min/semana, limitar alcohol, dejar tabaco.
- Fármacos de primera línea: IECA (enalapril 10–20 mg c/12 h) o ARA-II (losartán 50–100 mg/día), calcioantagonista (amlodipino 5–10 mg) o tiazida (hidroclorotiazida 12,5–25 mg); combinación dual si PA ≥160/100 o alto riesgo.
- Metas: PA <140/90 mmHg en general y <130/80 en alto riesgo cardiovascular (DM, ERC con albuminuria) si se tolera; en ≥80 años, PAS <150 mmHg. GES para personas ≥15 años.
- Seguimiento completo en APS (Programa de Salud Cardiovascular): controles periódicos, adherencia, laboratorio anual; derivar si HTA resistente (≥3 fármacos incluido diurético) o sospecha de causa secundaria.

PREGUNTAS (15)

Pregunta del libro · Tema 5.1

Hombre de 52 años hipertenso inicia tratamiento con Enalapril 20 mg al día. En el control a las 2 semanas se pesquisa elevación de la Creatinina plasmática desde 1.0 mg/dL basal hasta 2.4 mg/dL. A la auscultación abdominal se pesquisa un soplo sistólico en el flanco izquierdo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Estenosis de la arteria renal aterosclerótica
B) Hiperaldosteronismo primario (Conn)
C) Nefropatía diabética incipiente
D) Glomerulonefritis membranosa
E) Necrosis tubular aguda tóxica

Respuesta A. El deterioro brusco de la función renal (alza de creatinina > 30-50%) tras la introducción de un IECA o ARA2, sumado a la auscultación de un soplo abdominal en el flanco, es patognomónico de la Estenosis Bilateral de la Arteria Renal o unilateral en riñón único, al eliminarse la vasoconstricción de la arteriola eferente mediada por angiotensina II.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 65 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 85 años, hipertenso, está en tratamiento con losartan 50 mg/12 horas y amlodipino 2,5 mg/día. Acude a control y refiere múltiples tomas de presión arterial, las que promedian 145/75 mmHg ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Aumentar la dosis de losartán a 100 mg/12 horas
B) Aumentar el amlodipino a 5 mg/día
C) Agregar atenolol 12,5 mg/día
D) Agregar hidroclorotiazida 25 mg/día
E) Mantener el tratamienti

Respuesta E. Conducta / Tratamiento indicado: Mantener el tratamienti (opción E). Por su edad, está bien controlado, ya que la meta es que sea menor a 150/90 mmHg.. IECA y ARA-2 son intercambiables; NO combinar; de elección en diabetes y proteinuria De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 177 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 45 años, con IMC de 32 kg/m², acude a control médico, obje8vándose presión arterial de 146/92 mmHg. Se solicita Holter de presión arterial, que muestra múl8ples registros sobre 140/90 mmHg, diagnos8cándose hipertensión arterial. Sus exámenes de laboratorio resultan normales, incluyendo función renal, electrolitos plasmá8cos y electrocardiograma. ¿Qué 8po de fármacos es el más adecuado para iniciar el tratamiento an8hipertensivo en este paciente?

A) Bloqueadores alfa-adrenérgicos
B) Bloqueadores beta-adrenérgicos
C) Inhibidores del canal de calcio
D) Antagonistas del receptor de angiotensina
E) Diuré2cos 2azídicos

Respuesta D. Además de obesidad, con alta probabilidad Gene una hipertensión esencial, ya que no Gene elementos que hagan sospechar una causa secundaria. En pacientes jóvenes se suele iniciar con IECA (inhibidores de la enzima converGdora de angiotensina) o ARA2 (antagonistas del receptor de angiotensina 2). Muchas guías actuales prefieren iniciar con dos fármacos de forma simultánea (ej. losartán + amlodipino)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 32 · texto original del banco, sin revisar

Hombre de 55 años hipertenso en tratamiento con enalapril, bien controlado. Consulta por tos seca persistente desde que inició el tratamiento hace 3 meses. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Amlodipino (mantener enalapril y agregar calcioantagonista)
B) Hidroclorotiazida (agregar diurético)
C) Losartán (cambiar enalapril por ARA II)
D) Atenolol (agregar betabloqueador)
E) Suspender enalapril sin reemplazar

Respuesta C. Tos seca por IECA (enalapril): efecto de clase por acumulación de bradicinina, ocurre en 10-15% de pacientes. Solución: cambiar a ARA II (Losartán, Valsartán) que no causan tos. El control hipertensivo se mantiene con igual eficacia sin el efecto adverso.

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 85 · texto original del banco, sin revisar

Paciente con HTA en triple terapia (IECA, amlodipino, HCTZ), con edema en extremidades inferiores y presión 120/70. ¿Cuál es la conducta?

A) Agregar furosemida oral
B) Suspender amlodipino
C) Reducir dosis de IECA
D) Agregar espironolactona
E) Derivar a cardiología por insuficiencia cardíaca

Respuesta B. Conducta / Tratamiento indicado: Suspender amlodipino (opción B). Suspender amlodipino. IECA y ARA-2 son intercambiables; NO combinar; de elección en diabetes y proteinuria De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 180 · texto original del banco, sin revisar

Paciente con HTA sobre el rango normal en tratamiento actual, ¿cuál es el medicamento más adecuado a agregar?

A) Amlodipino
B) Valsartán (ARA II)
C) Hidroclorotiazida
D) Carvedilol
E) Furosemida

Respuesta B. Conducta / Tratamiento indicado: Valsartán (ARA II) (opción B). Valsartán (ARA II). IECA y ARA-2 son intercambiables; NO combinar; de elección en diabetes y proteinuria De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 122 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 69 años, con antecedente de diabetes e hipertensión, en tratamiento con aspirina, losartán, amlodipino, hidroclorotiazida y metformina, consulta por sensación de hinchazón y molestias en las extremidades inferiores. Al examen físico, tiene edema de extremidades inferiores. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Suspender el amlodipino
B) Aumentar la dosis de hidroclorotiazida
C) Disminuir la dosis de metformina
D) Suspender el losartán
E) Aumentar la dosis de aspirina

Respuesta A. El edema de EEII hace que probablemente sea un efecto adverso del amlodipino, por lo que se debe suspender.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 51 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 67 años, hipertensa, en tratamiento con losartán 50 mg, hidroclorotiazida 25 mg, amlodipino 5 mg, carvedilol 12,5 mg. Presenta edema de las extremidades inferiores, que ha ido en aumento. En su examen físico tiene FC: 57x' regular, con PA: 130/90 mmHg, RR2T, examen pulmonar sin alteraciones y examen abdominal con hígado palpable 1 cm bajo el reborde costal y extremidades inferiores con edema bimaleolar con signo de la fóvea. La conducta más adecuada es:

A) Reforzar la dieta hiposódica e indicar reposo con las extremidades en alto
B) Suspender el amlodipino
C) Subir la dosis del diurético
D) Suspender el losartán y agregar doxazosina
E) Solicitar ecodoppler de extremidades inferiores

Respuesta B. En este caso tiene un efecto adverso del amlodipino: edema, por lo que que hay que suspenderlo. Aunque la A y la C podrían servir, se debe siempre suspender y reemplazar el medicamento que produzca un efecto adverso, en la medida de lo posible, antes de tomar otras medidas (esto aplica para medicina en general).

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 14 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 53 años, diabética tipo 2, es diagnosticada recientemente de hipertensión. Sus exámenes generales, incluyendo un electrocardiograma, no muestran alteraciones ¿Qué fármaco es más adecuado para su tratamiento?

A) Atenolol
B) Hidroclorotiazida
C) Carvedilol
D) Amlodipino
E) Enalapril

Respuesta E. Tanto por ser menor de 55 años, como especialmente por ser diabética, el antihipertensivo de elección son los IECAs (enalapril).

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 9 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 63 años, diabético y dislipidémico, en tratamiento con metformina, atorvastatina y aspirina, se realiza varias tomas de presión arterial, que resultan 170/100 mmHg en promedio. Se realiza exámenes que muestran creatinina: 1,1 mg/dl, proteinuria (+), glucosuria (++), potasemia: 4,0 mEq/L, natremia: 142 mEq/L, glicemia: 115 mg/dl. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Iniciar amlodipino
B) Iniciar hidroclorotiazida
C) Iniciar enalapril
D) Iniciar hidralazina
E) Iniciar atenolol

Respuesta C. Conducta / Tratamiento indicado: Iniciar enalapril (opción C). La HTA en un diabético se trata con IECAs como primera línea. También la proteinuria.. IECA y ARA-2 son intercambiables; NO combinar; de elección en diabetes y proteinuria De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 86 · texto original del banco, sin revisar

Adulto mayor hipertenso con cardiopatía coronaria, en tratamiento con carvedilol, atorvastatina e HCTZ, presiones elevadas con función renal y potasio normales. ¿Cuál es el tratamiento de elección?

A) Amlodipino
B) Hidralazina
C) Metildopa
D) Nifedipino de liberación prolongada
E) Losartán

Respuesta E. Conducta / Tratamiento indicado: Losartán (opción E). Losartán. IECA y ARA-2 son intercambiables; NO combinar; de elección en diabetes y proteinuria De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 78 · texto original del banco, sin revisar

Paciente HTA en tratamiento con atenolol e hidroclorotiazida, metas fuera de rango con proteinuria que hipotensor es el indicado: a. Enalapril.

A) Amoxicilina
B) Ibuprofeno
C) Paracetamol
D) Omeprazol
E) Metformina

Respuesta A. Conducta / Tratamiento indicado: Amoxicilina (opción A). IECA y ARA-2 son intercambiables; NO combinar; de elección en diabetes y proteinuria De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 105 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 56 años, diabético en tratamiento con metformina 500 mg/8horas, con hipertensión de reciente diagnóstico, se realiza exámenes de control, que muestran creatinina plasmática: 0,9 mg/dl, BUN: 18 mg/dl, electrolitos plasmáticos: Na+: 141 mEq/L y K+: 4,1 mEq/l, RAC (relación albuminuria / creatininuria): 2,6 y hemoglobina glicosilada: 6,9%. ¿Qué fármaco es el más adecuado para el tratamiento de su hipertensión arterial?

A) Hidralacina
B) Espironolactona
C) Amlodipino
D) Atenolol
E) Valsartán

Respuesta D. Diagnóstico: Atenolol (opción D). Clase sobre las familias de antihipertensivos, sus efectos adversos, contraindicaciones y criterios de elección. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 144 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente diabético de larga data en tratamiento con empagliflozina 10 mg al día, metformina 1.000 mg cada 8 horas y atorvastatina 20 mg al día, presenta presiones arteriales de 140/90 mmHg y 158/87 mmHg en dos controles diferentes. El resto de su examen físico es normal y trae exámenes, entre los que destaca hemoglobina glicosilada de 6.9%. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Iniciar terapia depletiva de potasio
B) Iniciar tratamiento antihipertensivo
C) Solicitar un monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA)
D) Iniciar terapia antiagregante plaquetaria
E) Iniciar insulina

Respuesta B. Hipertensión en Paciente Diabético: Aunque se recomiendan tres tomas de presión arterial o un monitoreo ambulatorio de 24 horas para diagnosticar hipertensión, dos tomas pueden ser suficientes en pacientes diabéticos si hay alta sospecha. El objetivo de presión arterial en estos pacientes es menor a 130/80 mmHg, por lo que está claramente sobre esos valores. El tratamiento inicial recomendado en d

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 36 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 60 años con antecedente de hipertensión arterial de larga data, en tratamiento con carvedilol 25 mg cada 12 horas e hidroclorotiazida 50 mg/día, presenta presiones arteriales cercanas a 150/95 en la mayoría de las tomas. Además, tiene disnea de grandes esfuerzos y ortopnea, que lo obliga a dormir con una almohada grande. Su examen físico tiene frecuencia cardíaca 66x', PA: 150/96 mmHg, saturación arterial de oxígeno de 97%, examen pulmonar con crepitaciones bibasales, sin otras alteraciones y examen cardíaco con ritmo regular en dos tiempos, sin soplos. Se solicitan exámenes que muestran natremia: 142 mEq/L, potasemia: 4,0 mEq/L, creatininemia: 0,7 mg/dl, con hemograma y pruebas tiroideas normales. ¿Qué fármaco debería agregarse en este caso?

A) Losartán
B) Amlodipino
C) Verapamilo
D) Diltiazem
E) Doxazosina

Respuesta E. Conducta / Tratamiento indicado: Doxazosina (opción E). IECA y ARA-2 son intercambiables; NO combinar; de elección en diabetes y proteinuria De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

1.01.1.016 Hipertensión arterial secundaria

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 5.1 Hipertensión Arterial Esencial & Secundaria: Diagnóstico, Metas GES & Terapia Dual

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospechar HTA secundaria si: inicio <30 años o >55 años, HTA resistente o de difícil control, crisis hipertensivas, hipokalemia espontánea, daño de órgano desproporcionado o alza brusca de creatinina con IECA.
- Hiperaldosteronismo primario (la causa endocrina más frecuente): HTA resistente + hipokalemia; tamizaje con relación aldosterona/actividad de renina plasmática.
- Estenosis de arteria renal: soplo abdominal, edema pulmonar flash, deterioro renal con IECA/ARA-II; ateromatosa en ancianos, displasia fibromuscular en mujeres jóvenes. Estudio con Eco-Doppler o angioTAC.
- Feocromocitoma: crisis de cefalea, sudoración y palpitaciones → metanefrinas plasmáticas o urinarias. Otras: SAHOS (polisomnografía), ERC, hipotiroidismo/hipertiroidismo, Cushing, coartación aórtica, fármacos (AINE, ACO, corticoides).
- Manejo inicial: controlar la PA (calcioantagonista o espironolactona si sospecha de hiperaldosteronismo; evitar betabloqueador solo en feocromocitoma) y suspender fármacos hipertensores.
- Seguimiento: derivar a especialista (nefrología, endocrinología o cardiología según la sospecha) para confirmación y tratamiento específico.

PREGUNTAS (4)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 171

Un paciente de 37 años acude a chequeo médico en el que destaca presión arterial de 170/110 mmHg. No tiene obesidad ni antecedentes familiares de hipertensión. Se solicita un monitoreo ambulatorio de presión arterial de 24 horas, confirmándose el diagnóstico de hipertensión arterial, por lo que se inicia losartán 50 mg al día y amlodipino 5 mg al día. Se controla un mes después y el paciente refiere que ha mantenido presiones arteriales cercanas a 160/100 mmHg. Los exámenes de laboratorio muestran creatininemia: 0,9 mg/dL, BUN: 12 mg/dL, sodio plasmático: 140 mEq/L y potasio plasmático: 4,4 mEq/L. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Aumentar la dosis de los fármacos
B) Agregar un diurético al tratamiento
C) Solicitar ecografía Doppler renal
D) Solicitar niveles plasmáticos de aldosterona
E) Solicitar metanefrinas y catecolaminas en orina

Respuesta D. HTA severa en un joven sin obesidad ni antecedentes familiares: sospecha de HTA secundaria. Por la edad, la causa más probable es el hiperaldosteronismo primario, que se estudia con aldosterona (idealmente como RAR). El potasio normal no lo descarta, sobre todo si usa ARA II.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 51

Un paciente de 40 años, con antecedente de hipertensión arterial diagnosticada hace 6 meses, de difícil manejo, acude a control. Toma hidroclorotiazida 50 mg/día, losartán 100 mg/día y amlodipino 10 mg/día. Refiere varias crisis hipertensivas, a pesar de una buena adherencia a su tratamiento farmacológico. En el examen físico, su presión arterial actual es 158/97, que es similar a los valores que habitualmente presenta en su casa; su frecuencia cardíaca es 65x' y su examen cardiopulmonar muestra ritmo regular en dos tiempos, sin soplos y murmullo pulmonar presente, sin ruidos agregados. Trae un monitoreo de presión arterial con presión arterial promedio de 160/101 mmHg, con que muestra cargas tensionales diurnas de 77% sistólica y 63% diastólica y cargas tensionales nocturnas de 67% sistólica y 56% diastólica. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Reemplazar el losartán por un IECA
B) Reemplazar la hidroclorotiazida por un diurético antialdosterónico
C) Agregar doxazosina al tratamiento
D) Agregar espironolactona y solicitar exámenes para descartar una hipertensión secundaria
E) Reemplazar el amlodipino por diltiazem

Respuesta D. Tres fármacos a dosis plenas, uno de ellos diurético, con buena adherencia y monitoreo que confirma presiones altas: HTA resistente. Se agrega espironolactona como cuarto fármaco y se estudia una causa secundaria, partiendo por el hiperaldosteronismo primario.

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 81 · texto original del banco, sin revisar

Paciente con HTA en tratamiento triple (enalapril, amlodipino e hidroclorotiazida) con presiones elevadas persistentes. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Aumentar dosis de enalapril al máximo
B) Agregar beta-bloqueador oral
C) Suspender hidroclorotiazida y agregar furosemida
D) Derivar a nefrología de urgencia
E) Agregar espironolactona e iniciar estudio de HTA secundaria

Respuesta E. Conducta / Tratamiento indicado: Agregar espironolactona e iniciar estudio de HTA secundaria (opción E). Agregar espironolactona e iniciar estudio de HTA secundaria. Tratamiento: corticoides orales (detener avance) + cirugía vascular (desobstruir arterias) De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 136 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 38 años, diagnosticado de hipertensión arterial, está en tratamiento con enalapril 20 mg c/12 horas, hidroclorotiazida 25 mg/d y amlodipino 10 mg/día. Se realiza control con monitoreo de 24 horas de presión arterial que muestra presiones arteriales diurnas promedio de 152/100 mmHg, con sobrecarga tensional de 60% sistólica y 43% diastólica y presiones arteriales nocturnas de 140/92 mmHg, con sobrecarga tensional de 25% sistólica y 27% diastólica. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Aumentar la dosis de hidroclorotiazida
B) Aumentar la dosis de enalapril
C) Iniciar inhibidor del receptor de aldosterona y descartar hipertensión secundaria
D) Reemplazar el enalapril por losartán
E) Reemplazar la hidroclorotiazida por un inhibidor del receptor de aldosterona

Respuesta C. Tiene una HTA refractaria, ya que está tratada con 3 fármacos, incluyendo un diurético, en dosis altas (la HCTZ se puede aumentar a 50 mg, pero sigue siendo una HTA refractaria este caso). Por tanto, se debe agregar espironolactona y buscar una causa secundaria. Además, como dato, la sobrecarga tensional muestra el tiempo que están las presiones sobre el valor normal (se llama HTA enmascarada o "h

1.01.1.017 Insuficiencia aórtica

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 4.2 Insuficiencia Aórtica & Estenosis Mitral Reumática

QUÉ HAY QUE SABER

- Insuficiencia aórtica: causas válvula bicúspide, degenerativa, endocarditis, dilatación de raíz (Marfan, HTA), fiebre reumática; aguda por endocarditis o disección aórtica.
- Crónica: presión diferencial amplia (ej. 160/50), pulso céler (Corrigan), soplo diastólico aspirativo en borde esternal izquierdo, signos de Musset, Quincke y Duroziez; soplo de Austin Flint.
- Confirmación con ecocardiograma: severidad, FEVI y diámetros del VI. ECG con HVI por sobrecarga de volumen; Rx con cardiomegalia.
- Manejo inicial de la crónica: vasodilatadores (IECA/ARA-II o amlodipino) si HTA; tratar IC. La aguda es emergencia quirúrgica (EAP y shock): estabilizar y trasladar.
- Indicación quirúrgica en IAo severa: síntomas, FEVI ≤50% o dilatación del VI (diámetro sistólico >50 mm), con garantía GES de cirugía valvular.
- Seguimiento: derivar a cardiología; ecocardiograma seriado para detectar deterioro de la función del VI antes de los síntomas.

PREGUNTAS (5)

Pregunta del libro · Tema 4.2

Hombre de 48 años hipertenso con soplo cardíaco presenta al examen PA 170/45 mmHg, pulso de ascenso rápido y colapso súbito (pulso céler) y oscilación de la cabeza rítmica con el pulso (signo de Musset). ¿Cuál es la valvulopatía causante?

A) Insuficiencia aórtica severa
B) Estenosis aórtica severa
C) Insuficiencia mitral severa
D) Estenosis pulmonar
E) Coartación aórtica

Respuesta A. La presión diferencial sumamente amplia (170/45 mmHg) asociada al pulso saltón o de Corrigan y a signos periféricos hiperdinámicos (Musset, Quincke) es patognomónica de la Insuficiencia Aórtica Crónica Severa.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2018 · Pregunta 71 · texto original del banco, sin revisar

Pregunta 71 Sin contestar Puntúa como 1,00 Marcar pregunta Una paciente de 81 años consulta por disnea de esfuerzos, progresiva, asociada a paroxística nocturna y ortopnea. Al examen físico se objetiva PA: 160/60 mmHg, con pulso regular, amplio, a 72 lpm. Su examen cardíaco muestra desplazamiento del choque cardíaco, con presencia de un soplo intenso, entre el segundo y el primer ruido cardíaco, que se irradia al cuello. El examen pulmonar muestra crepitaciones escasas, en ambas bases. El diagnóstico de sospecha es:

A) Insuficiencia tricuspídea
B) Estenosis aórtica
C) Insuficiencia aórtica
D) Estenosis mitral
E) Insuficiencia mitral

Respuesta C. Diagnóstico: Insuficiencia aórtica (opción C). Es una insuficiencia aórtica clásica.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 147 · texto original del banco, sin revisar

Adulto con disnea de esfuerzos progresiva, diferencia PA sistólica-diastólica amplia, pulsos amplios y soplo diastólico aspirativo. ¿Diagnóstico más probable?

A) Estenosis aórtica severa
B) Estenosis mitral con hipertensión pulmonar
C) Insuficiencia aórtica
D) Insuficiencia mitral crónica
E) Comunicación interventricular del adulto

Respuesta C. Diagnóstico: Insuficiencia aórtica (opción C). Insuficiencia aórtica. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 2 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente masculino de 23 años, sin antecedentes de importancia consulta por disnea de esfuerzos e intolerancia al ejercicio, progresiva, que actualmente le obligan a caminar más lento. Al examen físico tiene FC: 88x', PA: 150/55 mmHg, choque de la punta en la línea axilar media y latido cervical visible. La auscultación cardíaca muestra ritmo regular, en dos tiempos, con un soplo diastólico IV/VI, con frémito. Al examen pulmonar, se constatan crépitos pulmonares. El diagnóstico más probable es:

A) Insuficiencia mitral
B) Estenosis aórtica
C) Estenosis mitral
D) Insuficiencia aórtica
E) Miocardiopatía hipertrófica

Respuesta D. Diagnóstico: Insuficiencia aórtica (opción D). Es una insuficiencia aórtica clásica (ver resumen de semiología cardíaca).. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 91 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 18 años, con antecedente de coartación aórtica, operada en la infancia, consulta por disnea de esfuerzos, que ha ido en aumento, desde hace 2 meses. Además, refiere edema de extremidades inferiores y palpitaciones ocasionales. Al examen físico tiene FC: 88x', PA: 155/55 mmHg, el choque de la punta se palpa hiperdinámico, en la línea media axilar y en la auscultación cardíaca se constata soplo sistólico eyectivo II/VI, más un soplo diastólico III/VI, que dura toda la diástole. Su examen pulmonar muestra crépitos escasos en ambas bases. El diagnóstico más probable es:

A) Estenosis aórtica
B) Insuficiencia aórtica
C) Recoartación aórtica
D) Miocardiopatía hipertrófica obstructiva
E) Miocardiopatía dilatada

Respuesta B. Diagnóstico: Insuficiencia aórtica (opción B). También era una insuficiencia aórtica clásica (ver resumen de semiología cardíaca).. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

1.01.1.018 Insuficiencia cardíaca

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 3.1 Insuficiencia Cardíaca Crónica: Fenotipos, Diagnóstico & Criterios Framingham · Tema 3.2 Cuádruple Terapia GDMT en IC-FEr (Guía GES 2026) · Tema 1.4 Síndrome Cardiorrenal y Síndrome Hepatorrenal

QUÉ HAY QUE SABER

- Diagnóstico clínico por criterios de Framingham (2 mayores o 1 mayor + 2 menores): DPN, ortopnea, ingurgitación yugular, crépitos, R3, cardiomegalia, reflujo hepatoyugular; menores: edema, hepatomegalia, derrame, tos nocturna.
- Confirmación: BNP <100 pg/mL o NT-proBNP <300 descarta IC aguda; ecocardiograma define el fenotipo: FEVI reducida ≤40%, levemente reducida 41–49%, preservada ≥50%.
- Etiología: cardiopatía coronaria e HTA las más frecuentes en Chile; también valvulopatías, miocardiopatías, Chagas, alcohol. Descompensantes: infección, transgresión de sal, mala adherencia, FA, AINE, isquemia.
- Inicial: restricción de sal, furosemida para congestión (20–40 mg/día), IECA/ARA-II y betabloqueador (bisoprolol, carvedilol, metoprolol) iniciados con el paciente euvolémico y titulados.
- En FEVI reducida, terapia cuádruple que reduce mortalidad: sacubitrilo/valsartán o IECA/ARA-II + betabloqueador + espironolactona 25 mg + iSGLT2 (dapagliflozina/empagliflozina 10 mg). Evitar AINE, verapamilo/diltiazem y glitazonas.
- Seguimiento completo: peso diario (consultar si sube >2 kg en 3 días), clase funcional NYHA, PA, FC, potasio y creatinina tras cada ajuste; vacunas influenza y neumococo.

PREGUNTAS (8)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 153

Un paciente de 68 años con antecedentes de infarto de miocardio, hipertensión arterial y tabaquismo se encuentra en tratamiento con aspirina, atorvastatina, enalapril 20 mg cada 12 horas, carvedilol 12,5 mg al día y furosemida 40 mg cada 12 horas. Actualmente presenta disnea de pequeños esfuerzos. Al examen físico tiene FC 65 lpm, PA 110/70 mmHg y saturación de oxígeno de 96 %; se auscultan crépitos pulmonares bibasales y ritmo cardíaco regular en dos tiempos, con un soplo sistólico III/VI. El choque de la punta se palpa en la línea axilar media y presenta edema de extremidades inferiores. **¿Cuál de las siguientes medidas es la más adecuada para este paciente?**

A) Agregar losartán
B) Agregar hidralazina
C) Agregar isosorbide
D) Agregar espironolactona
E) Agregar amiodarona

Respuesta D. Insuficiencia cardíaca sintomática pese a IECA y betabloqueo: el siguiente fármaco que aumenta la sobrevida es la espironolactona. Losartán no se suma al enalapril: el doble bloqueo del sistema renina-angiotensina aumenta la hiperkalemia y la falla renal sin beneficio.

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 135 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 71 años, con antecedente de hipertensión arterial, diabetes e insuficiencia cardíaca, en tratamiento con losartán, metformina, aspirina, nifedipino e hidroclorotiazida consulta por progresión de su disnea de esfuerzos, que aparece al caminar 1 cuadra. Al examen físico, tiene edema de extremidades inferiores, se palpa el choque de la punta en la línea axilar media y se ausculta ritmo cardíaco regular, sin soplos, con crépitos bilaterales en la auscultación pulmonar. Se realiza ecocardiografía que muestra disfunción ventricular, con fracción de eyección de 23%. ¿Qué fármaco debe suspenderse?

A) Losartán
B) Metformina
C) Aspirina
D) Nifedipino
E) Hidroclorotiazida

Respuesta D. El nifedipino puede agravar una insuficiencia cardíaca, por sus efectos inotrópicos negativos, por lo que en este caso, en que el paciente está descompensado, se debe suspender. Se debería agregar betabloqueo (con cuidado, iniciando dosis bajas) y, por la baja fracción de eyección (menor a 35%), probablemente se agregará espironolactona también, para aumentar la sobrevida (también el betabloqueo).

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 10 · texto original del banco, sin revisar

Un hombre de 66 años, hipertenso e insuficiente cardíaco, en tratamiento con enalapril e hidroclorotiazida, consulta por disnea de grandes esfuerzos, asociada a ortopnea de 2 almohadas y escaso edema de extremidades inferiores. Su electrocardiograma tiene signos de hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Cuál fármaco es más importante agregar?

A) Isosorbide
B) Carvedilol
C) Losartán
D) Furosemida
E) Hidroclorotiazida

Respuesta B. Conducta / Tratamiento indicado: Carvedilol (opción B). El betabloqueo aumenta la sobrevida. El losartán también, pero estaba con enalapril.. Tratamiento de hiperpotasemia severa: primero gluconato de calcio (estabiliza membrana), luego insulina + glucosa (ingresa K a las células) De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 1 · texto original del banco, sin revisar

Mujer de 68 años con diagnóstico de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida (FEVI 35%), clase funcional NYHA III. En tratamiento con furosemida y enalapril. ¿Cuál es el diurético que se debe agregar para mejorar el pronóstico?

A) Hidroclorotiazida
B) Indapamida
C) Clortalidona
D) Espironolactona
E) Torasemida

Respuesta D. Espironolactona (antagonista de aldosterona) reduce la mortalidad en ICC con FEVI ≤35% y NYHA III-IV (estudio RALES). Se agrega a furosemida + IECA. Monitorizar kalemia y función renal.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 93 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente masculino, de 69 años, con antecedente de diabetes e hipertensión arterial, con cardiopatía hipertensiva, en tratamiento con enalapril, hidroclorotiazida y metformina consulta por mayor disnea de la habitual, la que limita sus actividades de la vida diaria, asociada a ortopnea y disnea paroxística nocturna. Al examen físico su PA: 130/80 mmHg, FC: 70x', se observa edema de extremidades inferiores y se auscultan crepitaciones pulmonares escasas, en ambas bases. El examen cardiaco demuestra un choque de la punta en el 5° espacio intercostal, con auscultación normal. Se inicia tratamiento con carvedilol y furosemida, sin mayor respuesta. ¿Qué fármaco es más importante agregar al tratamiento de este paciente?

A) Isosorbide
B) Hidralazina
C) Atorvastatina
D) Espironolactona
E) Digoxina

Respuesta D. La espironolactona aumenta la sobrevida en la insuficiencia cardíaca (no era necesario un enunciado tan grande para preguntar eso).

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 8 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 50 años, con antecedente de miocardiopatía dilatada, en tratamiento con enalapril, carvedilol y furosemida, presenta disnea que aparece al realizar esfuerzos moderados, asociado a ortopnea. Su examen físico demuestra desplazamiento del choque de la punta, con crepitaciones de ambas bases pulmonares. Además se solicita una ecocardiografía que muestra una fracción de eyección de 24%. ¿Qué cambio recomendaría a este paciente?

A) Reemplazar la furosemida por hidroclorotiazida
B) Reemplazar el enalapril por losartán
C) Reemplazar el carvedilol por atenolol
D) Agregar hidralazina
E) Agregar espironolactona

Respuesta E. Conducta / Tratamiento indicado: Agregar espironolactona (opción E). La espironolactona aumenta la sobrevida en la ICC.. Tratamiento de hiperpotasemia severa: primero gluconato de calcio (estabiliza membrana), luego insulina + glucosa (ingresa K a las células) De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 13 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 40 años, con antecedente de asma e insuficiencia cardíaca, consulta por aumento de su disnea basal, por lo que se realizan algunos exámenes. Se solicita una ecocardiografía, que muestra cardiomegalia, con paredes finas y una fracción de eyección ventricular de 28%. Además se solicitan exámenes de laboratorio que muestran creatinina: 1,8 mg/dl, Na: 140 mEq/L, K: 3,8 mEq/L, Cl: 106 mEq/L. ¿Qué fármaco está contraindicado en esta paciente?

A) Enalapril
B) Losartán
C) Furosemida
D) Espironolactona
E) Digoxina

Respuesta E. Con fracción de eyección de 28% los pilares del tratamiento son los IECA o ARA II, el diurético de asa y la espironolactona, que con creatinina de 1,8 y potasio de 3,8 se pueden usar con control. La digoxina es la opción menos adecuada, ya que se elimina por vía renal y se acumula en insuficiencia renal, con riesgo de intoxicación digitálica, y no mejora la mortalidad.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 151 · texto original del banco, sin revisar

Mujer fumadora, hipertensa, con historia de ICC, pero que ahora estaba como desde hace unos 3 meses con disnea de esfuerzo, y al examen pulmonar estaba con sibilancias espiratorias. Preguntaban por la causa del empeoramiento de los síntomas.

A) TEP
B) Fibrosis pulmonar
C) IC
D) Cor pulmonale
E) Hemograma y VHS

Respuesta C. La alternativa correcta es la C (IC). Clase sobre el manejo de la hiperpotasemia e hipopotasemia. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES). Las opciones alternativas (TEP, Fibrosis pulmonar) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

1.01.1.019 Insuficiencia mitral

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 4.3 Insuficiencia Mitral Orgánica/Funcional & Prolapso Valvular Mitral (Barlow)

QUÉ HAY QUE SABER

- Insuficiencia mitral: primaria (prolapso, degenerativa, reumática, endocarditis) o secundaria/funcional (dilatación del VI por miocardiopatía o isquemia). Aguda por rotura de cuerdas o músculo papilar post IAM.
- Soplo holosistólico apical irradiado a la axila que aumenta en cuclillas; prolapso mitral: clic mesosistólico + soplo telesistólico que se adelanta con Valsalva o bipedestación.
- Confirmación con ecocardiograma: mecanismo, severidad, FEVI y diámetros; ECG con P mitral o FA.
- Manejo inicial: tratar IC (diuréticos, IECA si FEVI reducida), control de frecuencia y anticoagulación si FA según CHA2DS2-VASc. La IM aguda con EAP es emergencia quirúrgica.
- Indicación quirúrgica en IM primaria severa: síntomas, FEVI ≤60% o diámetro sistólico del VI ≥40 mm; la reparación (plastía) es preferible al reemplazo. GES de cirugía valvular.
- Seguimiento: derivar a cardiología; ecocardiograma periódico según severidad.

PREGUNTAS (4)

Pregunta del libro · Tema 4.3

Mujer de 24 años consulta por palpitaciones ocasionales. Al examen físico se ausculta en el ápex un clic mesosistólico seguido de un soplo telesistólico. ¿Qué ocurre con este soplo al solicitarle a la paciente que se ponga de pie o realice una maniobra de Valsalva?

A) El clic y el soplo se adelantan y se vuelven más prolongados
B) El soplo desaparece por completo
C) El clic se desplaza hacia el segundo ruido y el soplo se acorta
D) No se produce ninguna modificación auscultatoria
E) Aparece un cuarto ruido cardíaco

Respuesta A. Al realizar la maniobra de Valsalva o ponerse de pie, disminuye el retorno venoso y el volumen del ventrículo izquierdo se reduce. En un ventrículo más pequeño, las valvas mitrales redundantes prolapsan antes durante la eyección sistólica, por lo que el clic se produce más temprano y el soplo se hace más precoz y duradero.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 1 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 45 años, con antecedente de enfermedad reumá8ca en la infancia, consulta por un cuadro de 3 meses de evolución de disnea de esfuerzos en capacidad funcional II, que actualmente ha progresado a disnea de mínimos esfuerzos. Al examen Fsico, su presión arterial es de 120/78 mmHg, su frecuencia cardíaca es de 92 la8dos por minuto y su saturación de oxígeno es de 93% a aire ambiental. Se ausculta un soplo holosistólico en el ápex, irradiado a la axila y se palpa el choque de la punta hiperdinámico a la altura del quinto espacio intercostal. El examen pulmonar muestra crepitaciones basales bilaterales. ¿Cuál es el diagnós8co más probable?

A) Insuficiencia mitral
B) Insuficiencia aór2ca
C) Estenosis mitral
D) Estenosis aór2ca
E) Ductus arterioso persistente

Respuesta A. Es una insuficiencia mitral clásica, con clínica de insuficiencia cardiaca izquierda (disnea y crépitos), soplo holosistólico y desplazamiento del choque de la punta, que sugiere cardiomegalia. Revisar resumen de semiología cardiaca.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 38 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 70 años, hipertenso, presenta dolor torácico de dos días de evolución, intenso, asociado a malestar general. En las últimas horas se agrega disnea y síncopes ortostáticos. Al examen físico aparece un soplo holosistólico en el ápex. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Taponamiento cardiaco por rotura de la pared libre
B) Disección aórtica
C) Insuficiencia mitral por rotura del músculo papilar
D) Endocarditis bacteriana
E) Cardiopatía hipertensiva, descompensada

Respuesta C. Cuadro clásico (tiene soplo ed insuficiencia mitral y la historia de dolor de 2 días: tuvo un IAM hace dos días y ahora se rompió el músculo papilar).

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 124 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente presenta un cuadro de 2 días de disnea de esfuerzo, que aparece ante medianos esfuerzos, asociado a tos con expectoración, que en ocasiones es rosada. Al examen físico tiene FC: 94x', PA: 110/70 mmHg, examen pulmonar con crepitaciones bilaterales y examen cardíaco con presencia de un soplo sistólico IV/VI. El diagnóstico más probable es:

A) Tromboembolismo pulmonar
B) Insuficiencia tricuspídea
C) Neumopatía aguda
D) Insuficiencia mitral aguda
E) Disección aórtica

Respuesta D. El soplo sistólico y los síntomas de ICC izquierda hacen sospechar la insuficiencia mitral. La expectoración rosada suele ser más de estenosis mitral, pero sí se puede ver en la insuficiencia mitra. Ver resumen de semiología cardíaca.

1.01.1.020 Miocardiopatías

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 3.5 Miocardiopatías (Hipertrófica, Dilatada, Restrictiva & Miocarditis) · Tema 4.2 Enfermedad de Chagas: Aguda, Indeterminada y Crónica

QUÉ HAY QUE SABER

- Miocardiopatía dilatada: dilatación y FEVI reducida; causas idiopática/genética, alcohol, Chagas (relevante en Chile), miocarditis previa, quimioterapia (antraciclinas), periparto, taquicardiomiopatía.
- Miocardiopatía hipertrófica: hipertrofia septal asimétrica (≥15 mm), soplo sistólico que AUMENTA con Valsalva y bipedestación y disminuye en cuclillas; principal causa de muerte súbita en atletas jóvenes.
- Restrictiva: amiloidosis, sarcoidosis, hemocromatosis; IC con FEVI preservada, aurículas grandes y ECG de bajo voltaje. Sospechar Chagas ante BCRD + hemibloqueo anterior izquierdo en zona endémica.
- Sospecha por IC, síncope de esfuerzo, arritmias o soplo en joven; confirmar con ecocardiograma; ECG anormal en la gran mayoría.
- Manejo inicial: dilatada como IC con FEVI reducida (terapia cuádruple); hipertrófica con betabloqueador o verapamilo, evitando nitratos, diuréticos en exceso y digoxina; abstinencia de alcohol.
- Seguimiento: derivar a cardiología para estudio etiológico, estratificación de muerte súbita (DAI) y tamizaje familiar en formas genéticas.

PREGUNTAS (5)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 28

Una paciente de 14 años presenta caída al suelo, con inconsciencia de 30 segundos, recuperándose luego por completo. **¿Cuál de los siguientes antecedentes orientan a una causa cardiogénica del cuadro?**

A) Ausencia de episodios anteriores
B) Relación con la micción
C) Relación con el ejercicio
D) Relación con la tos
E) Ocurrencia al incorporarse desde la posición acostada

Respuesta C. El síncope durante el ejercicio, o en reposo sin gatillante ni pródromos, sugiere causa cardiogénica. La micción y la tos se asocian a síncopes situacionales (reflejos); el incorporarse, a síncope ortostático.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 41

Hombre de 40 años consulta por un síncope mientras jugaba fútbol, con recuperación completa. Además refiere disnea de esfuerzos que se inició hace 3 meses y ha aumentado lentamente. Su hermano murió súbitamente a los 25 años. Al examen físico se constata un soplo sistólico eyectivo, sin otras alteraciones. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Tromboembolismo pulmonar
B) Síndrome de Brugada
C) Miocardiopatía hipertrófica
D) Síncope disautonómico
E) Síndrome de QT largo

Respuesta C. Síncope de esfuerzo, disnea, soplo sistólico eyectivo y un hermano con muerte súbita joven es la miocardiopatía hipertrófica clásica, principal causa de muerte súbita en deportistas jóvenes. Se confirma con ecocardiograma. El Brugada y el QT largo dan síncope y muerte súbita familiar, pero no un soplo.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 54 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 31 años presenta un cuadro de disnea de esfuerzos, ortopnea y astenia. Su presión arterial es 120/70 mmHg y su pulso es de 80x', además presenta edema en las EEII. Presenta desplazamiento del choque de la punta, a dos centímetros de la línea medio-clavicular y se ausculta galope cardiaco, con un soplo sistólico en el ápex, que no varía con la inspiración. Al examen pulmonar tiene crepitos basales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Miocardiopatía hipertrófica
B) Miocardiopatía dilatada
C) Insuficiencia aórtica
D) Estenosis aórtica
E) Estenosis mitral

Respuesta B. Miocardiopatía dilatada clásica. El soplo que tiene es por insuficiencia mitral, por dilatación del anillo valvular. No aparece insuficiencia mitral en las alternativas (e igual es más probable que sea un MCP dilatada)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 179 · texto original del banco, sin revisar

Paciente de 17 años, sin antecedentes, es traído a la urgencia por presentar síncope mientras realizaba ejercicio, no asociado a otros síntomas. Al examen físico se aprecia soplo sistólico que aumenta con maniobras de vansalva, sin otros hallazgos. Se estudia con electrocardiograma que muestra onda Q presente en DII, DIII y AVF, además S profunda de V1 a V3. El diagnóstico más probable es:

A) Miocardiopatía dilatada
B) Lipotimia
C) Soplo fisiológico
D) Miocardiopatía hipertrófica
E) Estenosis mitral

Respuesta D. Debe decir S profunda. Clínica sí es de MCPHT. Viene con signos de HTVI: S profunda en V1 y V2, R alta en V5, V6. Además tiene ondas T gigantes e invertidas en las precordiales.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 3 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 35 años, primípara, está en su cuarto día postparto vaginal. Su embarazo fue adecuadamente controlado, siendo normal durante toda la gestación. Consulta por un cuadro de disnea que ha aumentado significativamente en los últimos días, siendo actualmente de reposo. Al examen físico presenta frecuencia cardíaca de 102 latidos por minuto y presión arterial de 110/60 mmHg, con auscultación cardíaca que muestra un ritmo de galope por presencia de R3 y examen pulmonar que demuestra la presencia de crépitos basales bilaterales. Satura 94% a FiO2 ambiental y se observa edema de extremidades inferiores fóvea ++. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Edema pulmonar no cardiogénico
B) Miocardiopatía periparto
C) Tromboembolismo pulmonar
D) Embolia de líquido amniótico
E) Neumonía

Respuesta B. Miocardiopatía periparto: El cuadro clínico sugiere insuficiencia cardíaca congestiva con disfunción sistólica (tercer ruido). La desaturación y las crepitaciones pulmonares sugieren un edema pulmonar cardiogénico. El contexto de la paciente puérpera obliga a pensar en una miocardiopatía periparto. Si no hubiese estado embarazada, sería miocardiopatía dilatada. El tromboembolismo pulmonar presenta

1.01.1.021 Paciente con soplo

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 4.4 Semiología de Soplos, Maniobras Dinámicas & Cardiopatías Congénitas del Adulto

QUÉ HAY QUE SABER

- Caracterizar el soplo: momento del ciclo, foco, irradiación, intensidad (I–VI; ≥III/VI o con frémito es patológico) y respuesta a maniobras.
- Soplo inocente: sistólico eyectivo, suave (≤II/VI), sin frémito, varía con la posición, sin síntomas ni otros hallazgos; frecuente en niños, embarazo, fiebre y anemia.
- Patológico siempre: todo soplo diastólico, holosistólico, continuo o con síntomas, cardiomegalia, ECG alterado o S2 anormal.
- Maniobras: inspiración aumenta los soplos derechos (Rivero-Carvallo); Valsalva y bipedestación aumentan solo MCH y prolapso mitral; cuclillas y empuñadura aumentan la mayoría (IM, IAo, CIV).
- Principales: EAo (mesosistólico aórtico a carótidas), IM (holosistólico apical a axila), IAo (diastólico aspirativo), EM (retumbo diastólico apical), CIV (holosistólico paraesternal rudo).
- Estudio con ecocardiograma y seguimiento: derivar a cardiología todo soplo patológico.

PREGUNTAS (1)

Pregunta del libro · Tema 4.4

Mujer de 28 años asintomática. Al examen físico destaca un desdoblamiento amplio y fijo del segundo ruido cardíaco que no varía con la respiración y un soplo sistólico eyectivo en foco pulmonar. El ECG muestra bloqueo incompleto de rama derecha. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Comunicación interauricular (CIA tipo ostium secundum)
B) Estenosis aórtica severa
C) Comunicación interventricular restrictiva
D) Ductus arterioso persistente
E) Tetralogía de Fallot corregida

Respuesta A. El desdoblamiento amplio y FIJO del segundo ruido (que no cambia de intervalo durante la inspiración ni espiración) asociado a un soplo de hiperflujo pulmonar y bloqueo de rama derecha es el hallazgo patognomónico de la Comunicación Interauricular (CIA).

1.01.1.022 Pericarditis aguda

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **No requiere**

Dónde se enseña: Tema 5.3 Pericarditis Aguda & Taponamiento Cardíaco

QUÉ HAY QUE SABER

- Pericarditis aguda: dolor torácico punzante que aumenta con la inspiración y el decúbito y alivia al inclinarse hacia adelante; frote pericárdico. Causa viral/idiopática la más frecuente.
- Diagnóstico con ≥2 de 4: dolor típico, frote, ECG con supradesnivel ST cóncavo difuso + infradesnivel del PR, derrame pericárdico nuevo. Solicitar ECG, PCR, troponina (miopericarditis) y ecocardiograma.
- Tratamiento: ibuprofeno 600 mg c/8 h o aspirina 750–1000 mg c/8 h por 1–2 semanas con descenso + colchicina 0,5 mg c/12 h (0,5 mg/día si <70 kg) por 3 meses; reposo deportivo.
- Evitar corticoides como primera línea (aumentan recurrencias). Signos de alto riesgo para hospitalizar: fiebre >38 °C, derrame severo, taponamiento, inmunosupresión, troponina elevada, falta de respuesta a AINE.
- Taponamiento (hipotensión, ingurgitación yugular, ruidos apagados, pulso paradójico) es emergencia: pericardiocentesis.
- Seguimiento: la pericarditis no complicada no requiere seguimiento especializado; control clínico de respuesta y consultar si recurre.

PREGUNTAS (6)

Pregunta del libro · Tema 5.3

Hombre de 26 años con pericarditis aguda viral. ¿Cuál es la terapia farmacológica de primera línea recomendada para tratar el episodio actual y reducir significativamente la tasa de recidiva a largo plazo?

A) Antiinflamatorios no esteroidales (AINEs) asociados a Colchicina durante 3 meses
B) Prednisona en dosis altas en monoterapia
C) Antibioticoterapia empírica con Ceftriaxona endovenosa
D) Anticoagulación con Heparina de bajo peso molecular
E) Paracetamol 500 mg cada 12 horas SOS

Respuesta A. Las guías internacionales de la ESC y consensos clínicos establecen que el tratamiento estándar de primera línea de la pericarditis aguda es la asociación de AINEs (Ibuprofeno o Aspirina en dosis altas) con Colchicina durante 3 meses, debido a que la adición de colchicina disminuye a la mitad la tasa de recurrencias y recidivas.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 94 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 40 años, con antecedente de reflujo gastroesofágico, consulta por dolor torácico de algunas horas de evolución, tipo puntada, muy intenso. Refiere que el dolor no respondió al uso de omeprazol. En su examen físico se aprecia adolorido, con FC: 76x', PA: 110/70 mmHg, ritmo regular en 2 tonos, sin soplos. Se solicita un electrocardiograma, que se muestra a continuación: Foto 8 (https://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoID=86115). El diagnóstico más probable es:

A) Pericarditis aguda
B) Espasmo esofágico
C) Infarto miocárdico con supradesnivel del segmento ST de la pared lateral
D) Infarto miocárdico con supradesnivel del segmento ST de la pared inferior
E) Infarto miocárdico con supradesnivel del segmento ST de la pared inferolateral

Respuesta A. Es una pericarditis clásica, tanto por la clínica, como por el EKG con SDST en J en casi todas las derivaciones.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 81 · texto original del banco, sin revisar

Un hombre de 31 años, deportista, consulta por dolor precordial de 2 días de evolución, EVA 8/10, asociado a leve sensación de ahogo, que aparece especialmente al recostarse. Se solicita un electrocardiograma, que se muestra a continuación: El diagnóstico más probable es:

A) Infarto agudo al miocardio
B) Pericarditis aguda
C) Neumotórax espontáneo
D) Tromboembolismo pulmonar
E) Costocondritis del deportista

Respuesta B. Es una pericarditis clásica, tanto por la edad y la clínica (aumenta al acostarse) como por el EKG con SDST en J casi todas las derivaciones. También tiene depresión del PR en algunas.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 59 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 30 años, deportista, pregunta por dolor precordial opresivo, de dos días de evolución, irradiado al cuello y al hombro izquierdo, intenso. Además presenta disnea que aumenta al recostarse. Al examen físico está adolorido, con RR2T sin soplos. Se realiza un electrocardiograma, que se muestra a continuación: El diagnóstico más probable es:

A) Tromboembolismo pulmonar
B) Neumotórax
C) Pericarditis aguda
D) Miocardiopatía hipertrófica
E) Costocondritis del deportista

Respuesta C. Dolor precordial opresivo que mejora al inclinarse y empeora al recostarse, en un joven, con depresión del segmento PR en el ECG, corresponde a pericarditis aguda. El TEP, el neumotórax y la costocondritis no explican el ECG, y la miocardiopatía hipertrófica no produce este cuadro doloroso agudo con esas alteraciones.

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 139 · texto original del banco, sin revisar

Paciente con dolor torácico retroesternal, antecedente de RGE, en buenas condiciones. ECG con elevación difusa del ST en silla de montar. ¿Diagnóstico más probable?

A) SCA con elevación del ST (SCACEST)
B) Angina inestable
C) Miocarditis aguda viral
D) Pericarditis aguda
E) Espasmo coronario (angina de Prinzmetal)

Respuesta D. Diagnóstico: Pericarditis aguda (opción D). Pericarditis aguda. Las enfermedades del pericardio incluyen pericarditis aguda, derrame pericárdico, taponamiento cardíaco y pericarditis constrictiva. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 29 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 40 años consulta por dolor retroesternal opresivo, irradiado al dorso, que inició después de comer y que tiene una intensidad de 8/10, con tope inspiratorio. Al examen físico tiene FC: 100x, PA: 130/88 mmHg, T°: 37,7°C, examen pulmonar normal, auscultación cardíaca con ritmo regular en dos tonos, sin soplos. Se realiza un electrocardiograma, que se muestra a continuación (fuente: www.cardioscience.com.mx): ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Tromboembolismo pulmonar
B) Pericarditis aguda
C) Disección aórtica
D) Infarto agudo al miocardio de pared inferior
E) Infarto agudo al miocardio de pared anterolateral

Respuesta B. Diagnóstico: Pericarditis aguda (opción B). Las enfermedades del pericardio incluyen pericarditis aguda, derrame pericárdico, taponamiento cardíaco y pericarditis constrictiva. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

1.01.1.023 Síndrome metabólico

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: diab-25

QUÉ HAY QUE SABER

- Síndrome metabólico (ATP III armonizado): ≥3 de 5: circunferencia de cintura ≥90 cm hombres/≥80 cm mujeres (corte chileno), TG ≥150 mg/dL, HDL <40 (H)/<50 (M), PA ≥130/85 o tratamiento, glicemia en ayunas ≥100 mg/dL.
- Base fisiopatológica: obesidad abdominal e insulinorresistencia (acantosis nigricans); aumenta el riesgo de DM2, enfermedad cardiovascular e hígado graso.
- Estudio: peso, IMC, cintura, PA, glicemia (PTGO si glicemia 100–125), perfil lipídico, transaminasas; estimar riesgo cardiovascular global.
- Tratamiento de elección: cambio de estilo de vida, con baja de peso de 5–10%, dieta mediterránea/hipocalórica y actividad física ≥150 min/semana; cesación tabáquica.
- Tratar cada componente según metas: estatina por riesgo CV, antihipertensivos, metformina en prediabetes de alto riesgo; considerar fármacos antiobesidad o cirugía bariátrica en obesidad severa.
- Seguimiento completo en APS (Programa de Salud Cardiovascular / Vida Sana): control de peso, cintura y laboratorio periódico.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
>
> Un hombre de 48 años asiste a control de salud. Tiene circunferencia de cintura de 106 cm, presión arterial 136/86 mmHg, glicemia de ayuno 108 mg/dL, triglicéridos 190 mg/dL y colesterol HDL 36 mg/dL. No usa fármacos. **¿Cuál es el diagnóstico más adecuado?**
>
> **A)** Diabetes mellitus tipo 2
> **B)** Síndrome metabólico
> **C)** Hipertensión arterial etapa 1
> **D)** Hipercolesterolemia familiar
> **E)** Síndrome de Cushing
>
> Respuesta B. Cumple los 5 criterios de síndrome metabólico (bastan 3): obesidad abdominal, PA ≥130/85 mmHg, glicemia de ayuno ≥100 mg/dL, triglicéridos ≥150 mg/dL y HDL bajo 40 mg/dL en hombres. No tiene diabetes (ayuno bajo 126) ni hipertensión (bajo 140/90). Implica alto riesgo cardiovascular.

1.01.1.024 Taquicardia paroxística supraventricular (TPSV)

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 1.4 TPSV & Síndrome de Wolff-Parkinson-White

QUÉ HAY QUE SABER

- TPSV: taquicardia regular de QRS estrecho a 150–250 lpm, inicio y término súbitos; reentrada nodal la más frecuente (mujeres jóvenes), seguida de vía accesoria (WPW).
- ECG en crisis: ondas P ausentes o retrógradas (pseudo-r' en V1). En ritmo sinusal, WPW: PR corto <120 ms + onda delta + QRS ancho.
- Inestable (hipotensión, dolor, IC, compromiso de conciencia): cardioversión eléctrica sincronizada.
- Estable: maniobras vagales (Valsalva modificada, masaje carotídeo si sin soplos) → adenosina 6 mg EV en bolo rápido, 12 mg si no responde; alternativa verapamilo 5 mg EV o betabloqueador.
- En FA preexcitada (WPW, QRS ancho irregular) están contraindicados adenosina, verapamilo, digoxina y betabloqueadores: usar procainamida o cardioversión.
- Seguimiento completo: enseñar maniobras vagales, betabloqueador o verapamilo profiláctico si crisis frecuentes; derivar a electrofisiología para ablación (curativa) si recurrente o WPW.

PREGUNTAS (9)

Pregunta del libro · Tema 1.4

Hombre de 26 años con palpitaciones paroxísticas regulares de inicio súbito a 180 lpm y QRS estrecho. Se realizaron maniobras vagales sin éxito. ¿Cuál es el fármaco de primera línea y la técnica correcta de administración?

A) Adenosina 6 mg en bolo endovenoso ultrarrápido seguido de bolo de 20 mL de suero fisiológico
B) Amiodarona 300 mg en infusión continua para 1 hora
C) Verapamilo 10 mg por vía intramuscular profunda
D) Digoxina 0.5 mg en infusión lenta
E) Lidocaína 100 mg endovenosa

Respuesta A. La Adenosina tiene una vida media ultracorta (< 10 segundos). Para que alcance concentraciones terapéuticas en el nodo AV, debe inyectarse en bolo ultrarrápido (1-2 segundos) en una vena periférica proximal, seguido de un bolo de lavado de 20 mL de solución fisiológica y elevación del brazo. La dosis inicial es de 6 mg.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 3 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 28 años consulta por dolor torácico y disnea de 2 horas de evolución. Al examen Fsico presenta taquicardia a 170 lpm, presión arterial 120/80 mmHg y un examen cardiopulmonar con ritmo regular en dos tonos, sin soplos, en la auscultación cardíaca y murmullo pulmonar presente, sin ruidos agregados, en la auscultación pulmonar. Se solicita un electrocardiograma que se muestra a con8nuación: ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Verapamilo endovenoso
B) Amiodarona endovenosa
C) Adrenalina endovenosa
D) Adenosina endovenosa
E) Cardioversión eléctrica

Respuesta D. Tiene una TPSV clásica. El tratamiento de primera línea son las maniobras vagales (ej. Valsalva modificado es la más recomendada en adultos y niños que cooperan; en niños pequeño se prefiere la inmersión facial en agua fría. El masaje caroVdeo se puede usar en adultos, pero no se recomienda en niños ni en adultos mayores con riesgo de ateroma caroVdeo que se pueda soltar). De segunda línea se uGliza

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 134 · texto original del banco, sin revisar

Mujer de 25 años con palpitaciones paroxísticas. ECG en sinusal muestra intervalo PR corto y onda delta. Episodio de TPSV con QRS ancho. ¿Cuál es el diagnóstico?

A) Síndrome de Wolff-Parkinson-White (WPW)
B) Fibrilación auricular
C) Taquicardia ventricular
D) Bloqueo AV completo
E) Síndrome de QT largo

Respuesta A. PR corto + onda delta + TPSV con QRS ancho = síndrome de WPW (preexcitación ventricular por vía accesoria). La taquicardia puede ser ortodrómica (QRS estrecho) o antidrómica (QRS ancho).

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 87 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 22 años consulta por palpitaciones de inicio súbito, rápidas y molestas, que duraron cerca de 30 minutos y desaparecieron con maniobras vagales. Refiere que había presentado episodios previos, pero de menor duración y autolimitados. Actualmente está en buenas condiciones y al examen físico, no presenta alteraciones. Trae un electrocardiograma, que se muestra a continuación (fuente: cardioteca.com): ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Fibrilación auricular
B) Síndrome de Wolff Parkinson White
C) Bloqueo completo de rama izquierda
D) Flutter auricular
E) Síndrome de Brugada

Respuesta C. Diagnóstico: Bloqueo completo de rama izquierda (opción C). La taquicardia paroxística supraventricular (TPSV) es una taquicardia regular de complejos angostos con inicio y término súbitos. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 44 · texto original del banco, sin revisar

Joven de 22 años con palpitaciones súbitas de inicio y término brusco. ECG en crisis: taquicardia regular de QRS estrecho a 180 lpm. Cede con maniobra de Valsalva. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico de elección si reaparece?

A) Adenosina IV en bolo rápido
B) Amiodarona EV
C) Metoprolol oral
D) Digoxina IV
E) Cardioversión eléctrica sincronizada

Respuesta A. TPSV (taquicardia paroxística supraventricular) estable: si maniobras vagales fallan, adenosina IV 6 mg en bolo rápido es el tratamiento de elección por su efecto ultrabreve sobre el nodo AV.

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 141 · texto original del banco, sin revisar

Paciente con palpitaciones regulares y taquicardia supraventricular en el ECG. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

A) Verapamilo 5 mg EV lento
B) Amiodarona 300 mg EV
C) Cardioversión eléctrica sincronizada
D) Metoprolol 5 mg EV
E) Adenosina 6 mg IV en bolo rápido

Respuesta E. Conducta / Tratamiento indicado: Adenosina 6 mg IV en bolo rápido (opción E). Adenosina 6 mg IV en bolo rápido. Las maniobras vagales son el primer paso en el manejo agudo de la TPSV De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 69 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 10 años, es traído por cuadro de inicio agudo de dos horas de evolución caracterizados por palpitaciones y dolor torácico. Al ingreso se conecta a monitor que muestra frecuencia cardiaca de 200 latidos por minutos, regular y QRS angosto. La primera medida para el manejo en este caso es:

A) Realizar presión orcular
B) Realizar cardioversión eléctrica
C) Administrar adenosina endovenosa
D) Realizar masaje carotídeo
E) Administrar verapamilo endovenoso

Respuesta D. Conducta / Tratamiento indicado: Realizar masaje carotídeo (opción D). Tiene una TPSV y lo primero son las maniobras vagales, luego la adenosina.. Las maniobras vagales son el primer paso en el manejo agudo de la TPSV De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 59 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 28 años consulta por un cuadro de 3 horas de evolución de palpitaciones intensas, asociadas a disnea. Al examen físico, tiene FC: 160 por minuto, regular, PA: 110/70 mmHg, examen cardíaco con ritmo regular en dos tiempos, sin soplos y murmullo pulmonar presente, sin ruidos agregados. Se realiza un electrocardiograma, que se muestra a continuación: ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

A) Amiodarona 150 mg endovenosa
B) Lidocaína 100 mg endovenosa
C) Adenosina 6mg intravenosa
D) Diltiazem 25 mg endovenoso
E) cardioversión eléctrica

Respuesta C. Conducta / Tratamiento indicado: Adenosina 6mg intravenosa (opción C). Las maniobras vagales son el primer paso en el manejo agudo de la TPSV De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 31 · texto original del banco, sin revisar

Mujer con síntomas ansiosos y EKG (taquicardia regular QRS estrecho aprox 150 lpm): a. Adenosina

A) Insuficiencia cardíaca
B) Fibrilación auricular
C) Infarto agudo al miocardio
D) Tromboembolismo pulmonar
E) Pericarditis aguda

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (Insuficiencia cardíaca). La taquicardia paroxística supraventricular (TPSV) es una taquicardia regular de complejos angostos con inicio y término súbitos. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

Situaciones clínicas de urgencia 9 códigos

1.01.2.001 Angina inestable

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 2.2 SCASEST: Angina Inestable e IAM sin Supradesnivel del ST

QUÉ HAY QUE SABER

- Angina inestable: angina de reposo (>20 min), de reciente comienzo (<2 meses, CCS ≥III) o en crescendo; SCA sin supradesnivel ST con troponinas NORMALES (si se elevan es IAM sin SDST).
- ECG en <10 minutos: puede ser normal o con infradesnivel ST o inversión de T; repetir ECG seriado y troponinas ultrasensibles a las 0 y 1–3 h.
- Manejo inicial: aspirina 250–500 mg masticada, segundo antiagregante (ticagrelor 180 mg o clopidogrel 300–600 mg), enoxaparina 1 mg/kg c/12 h SC, atorvastatina 80 mg, nitroglicerina SL/EV si dolor, O2 solo si SatO2 <90%.
- Betabloqueador oral si no hay IC, bradicardia ni shock; morfina solo si dolor refractario. La trombolisis está CONTRAINDICADA en SCA sin supradesnivel.
- Estratificar riesgo (TIMI, GRACE): alto riesgo (dolor persistente, inestabilidad hemodinámica, arritmias, cambios dinámicos del ST) → coronariografía precoz (<24 h, inmediata si muy alto riesgo).
- Seguimiento: derivar a cardiología para estudio coronario y revascularización; GES de IAM/SCA.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta del libro · Tema 2.2**
>
> ¿Cuál de los siguientes pacientes con SCASEST tiene indicación de coronariografía invasiva urgente en MENOS de 2 horas?
>
> **A)** Paciente con dolor torácico persistente refractario al tratamiento médico e inestabilidad hemodinámica
> **B)** Paciente de 60 años asintomático tras recibir nitroglicerina con TIMI de 2 puntos
> **C)** Paciente con dolor torácico autolimitado y troponinas negativas
> **D)** Paciente hipertenso con ECG normal y dolor atípico
> **E)** Paciente con Score GRACE de 110 puntos sin nuevos episodios de dolor
>
> Respuesta A. La coronariografía inmediata (< 2 horas) se reserva para pacientes con criterios de muy alto riesgo isquémico o inestabilidad: shock cardiogénico, inestabilidad hemodinámica, dolor torácico refractario a nitratos/analgesia, arritmias ventriculares malignas o insuficiencia cardíaca aguda secundaria a isquemia.

1.01.2.002 Disección aórtica

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 5.4 Patología de la Aorta: Disección Aórtica Aguda & Aneurisma de Aorta Abdominal

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospechar ante dolor torácico o dorsal súbito, intenso, desgarrante y migratorio, en hipertenso, Marfan, válvula bicúspide o consumo de cocaína.
- Signos: asimetría de pulsos o PA >20 mmHg entre brazos, soplo de insuficiencia aórtica nuevo, déficit neurológico, isquemia de extremidades o mesentérica; Rx con ensanchamiento mediastínico.
- Confirmación: angioTAC de aorta (examen de elección); ecocardiograma transesofágico si inestable. No anticoagular ni trombolizar ante la sospecha (diferencial con IAM).
- Tratamiento inicial: analgesia con opioides, control de FC <60 lpm y PAS 100–120 mmHg con betabloqueador EV (labetalol o esmolol) ANTES de vasodilatadores (nitroprusiato).
- Stanford A (aorta ascendente): cirugía de urgencia. Stanford B (descendente): manejo médico en UCI, endoprótesis si complicada.
- Seguimiento: derivar de inmediato a cirugía cardiovascular/UCI.

PREGUNTAS (11)

Pregunta del libro · Tema 5.4

Hombre de 59 años hipertenso ingresa con dolor torácico retroesternal transfixiante hacia la espalda. AngioTAC confirma Disección Aórtica que compromete la aorta ascendente extendiéndose hasta el arco aórtico (Stanford A). ¿Cuál es el tratamiento definitivo de elección?

A) Cirugía cardíaca de reemplazo aórtico de urgencia inmediata
B) Manejo médico conservador exclusivo en UCI con Betabloqueadores
C) Fibrinólisis endovenosa con Tenecteplase
D) Implante de Stent aórtico percutáneo electivo en 1 mes
E) Anticoagulación con Heparina no fraccionada en infusión

Respuesta A. Toda Disección Aórtica Stanford A (que compromete la aorta ascendente) es una emergencia quirúrgica absoluta que exige resolución quirúrgica inmediata a tórax abierto para reemplazar el segmento disecado y evitar la muerte por rotura intrapericárdica, taponamiento o infarto masivo.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 98 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 69 años, con antecedente de hipertensión y diabetes, consulta por dolor torácico intenso EVA 10/10, de carácter lancinante y que se irradia a cuello y dorso. A lo anterior se agregó dolor intenso en la extremidad superior izquierda. Al examen físico tiene FC: 120x', PA: 200/140 mmHg, ritmo regular en dos tiempos, sin soplos, murmullo pulmonar bilateral conservado, sin otros ruidos, extremidad superior izquierda con disminución del pulso radial y frialdad de la mano. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Pericarditis aguda
B) Disección aórtica
C) Tromboembolismo pulmonar
D) Infarto agudo al miocardio
E) Embolias cardíacas

Respuesta B. Diagnóstico: Disección aórtica (opción B). La combinación cardinal de dolor torácico súbito desgarrador (EVA 10/10) irradiado a región interescapular o dorso, cifras tensionales severas y asimetría de pulsos periféricos en extremidades superiores es patognomónica de disección aórtica aguda. Requiere angio-TAC de tórax inmediato y estabilización hemodinámica con betabloqueadores EV para reducir la

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 22 · texto original del banco, sin revisar

Paciente masculino de 55 años con dolor torácico desgarrador de inicio súbito, irradiado a la espalda. TA en brazo derecho 185/100 y en brazo izquierdo 140/80. TC: disección de aorta tipo B de Stanford. ¿Cuál es el manejo inicial?

A) Manejo médico: control de frecuencia cardíaca y presión arterial
B) Cirugía de emergencia
C) Trombólisis sistémica
D) Endoprótesis aórtica de urgencia
E) Anticoagulación con heparina EV

Respuesta A. Disección aórtica tipo B de Stanford (no compromete aorta ascendente): manejo médico con betabloqueadores para reducir FC <60 lpm y PA sistólica 100-120 mmHg. Cirugía solo si hay complicaciones.

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 157 · texto original del banco, sin revisar

Paciente con dolor torácico EVA 10/10 retroesternal con irradiación a dorso, pulso radial izquierdo débil y llene capilar enlentecido. ¿Diagnóstico más probable?

A) SCA con elevación del ST
B) Tromboembolismo pulmonar masivo
C) Disección aórtica
D) Rotura esofágica (Boerhaave)
E) Neumotórax a tensión

Respuesta C. Diagnóstico: Disección aórtica (opción C). Disección aórtica. La combinación cardinal de dolor torácico súbito desgarrador (EVA 10/10) irradiado a región interescapular o dorso, cifras tensionales severas y asimetría de pulsos periféricos en extremidades superiores es patognomónica de disección aórtica aguda. Requiere angio-TAC de tórax inmediato y estabilización hemodinámica con betabloqueadores

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 12 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 70 años, con antecedente de hipertensión, en tratamiento con losartán e hidroclorotiazida, consulta por dolor torácico, EVA 9/10, irradiado a dorso, asociado a malestar general y sudoración. Al examen físico tiene FC: 110x', PA: 170/110 mmHg, examen pulmonar con crépitos escasos bibasales y examen cardíaco con choque de la punta no desplazado y auscultación con ritmo regular, en dos tiempos, con presencia de un soplo cardíaco diastólico aspirativo, de intensidad IV/VI, de ubicación paraesternal derecho. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Neumotórax
B) Aneurisma de la aorta ascendente
C) Infarto miocárdico con rotura del músculo papilar
D) Tromboembolismo pulmonar
E) Disección aórtica tipo A

Respuesta E. Es una clásica disección aórtica, con el soplo diastólico de la insuficiencia aórtica (se diseca la válvula). Es tipo A, porque, al afectar la válvula, obviamente está sobre la subclavia izquierda.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 16 · texto original del banco, sin revisar

Paciente de 50 años, con antecedente de hipertensión en tratamiento irregular con hidroclorotiazida, consulta por dolor torácico de 30 minutos de duración, transfixiante, irradiado a epigastrio, asociado a mareos y diaforesis. Al examen se aprecia pálido, sudoroso, PA 150/90, FC: 110x', saturación de oxígeno de 93% con FiO2 ambiental, ritmo regular, asociado a soplo diastólico II/ VI y disminución del segundo ruido, abdomen blando, depresible e indoloro, ruidos hidroaéreos presentes. Al ingreso se solicita ECG que muestra alteraciones inespecíficas en pared anterolateral, además troponinas que están con resultado pendiente. El diagnóstico más probable es:

A) Disección aórtica
B) Infarto agudo al miocardio sin supradesnivel de ST
C) Tromboembolismo pulmonar
D) Infarto mesentérico
E) Pancreatitis aguda

Respuesta A. Disección aórtica por el soplo diastólico. La disminución del R2 y el soplo son por la insuficiencia Aórtica

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 144 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 63 años, con antecedente de hipertensión y dislipidemia, en tratamiento con losartán, hidroclorotiazida y atorvastatina consulta en el servicio de urgencia por dolor torácico intenso, EVA 9/10, irradiado al dorso. Al examen físico está diaforético y angustiado, con FC: 115x', PA: 220/117 mmHg, examen pulmonar con crépitos escasos bibasales y examen cardíaco con choque de la punta no desplazado y auscultación con ritmo regular, en dos tiempos con ruidos apagados. Se solicita un electrocardiograma que muestra taquicardia sinusal y troponinas plasmáticas, que resultan negativas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Neumotórax
B) Infarto agudo al miocardio
C) Taponamiento pericárdico
D) Tromboembolismo pulmonar
E) Disección aórtica

Respuesta E. Orientan a disección aórtica la irradiación al dorso, la concomitancia con una crisis hipertensiva, el EKG sin signos de isquemia y las troponinas normales, que hacen menos probable un infarto. Se debe estudiar con angioTAC de tórax. Se maneja con drogas antiHTA por vía endovenosa y con cirugía, si es tipo A (sobre subclavia).

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 143 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 65 años, hipertenso de larga data, mal controlado, consulta por dolor torácico intenso, EVA 8/10, transfixiante. Al examen físico se observa angustiado y sudoroso, con FC: 115x' PA: 160/110 mmHg, murmullo pulonar presente, simétrico y examen cardíaco con ritmo regular en dos tiempos, con auscultación de un soplo diastólico III/VI en el precordio. Se solicita un electrocardiograma que muestra una taquicardia sinusal y las enzimas cardíacas resultan negativas. El diagnóstico más probable es:

A) Neumotórax
B) Espasmo esofágico
C) Infarto agudo al miocardio
D) Síndrome aórtico agudo
E) Tromboembolismo pulmonar

Respuesta D. Es una disección aórtica clásica, debido al soplo diastólico de la insuficiencia aórtica. Se debe estudiar con angioTAC y, en este caso, por ser probablemente tipo A, se debe operar (ya que está afectando la válvula aórtica y, por ello, se puede asumir que disecó sobre la subclavia izquierda).

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 12 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 75 años, diabético e hipertenso, consulta por dolor torácico intenso, de inicio súbito, que alcanza un EVA 7/10, de 2 horas de evolución. El dolor tenía una localización retroesternal, pero luego migra a la zona dorsolumbar. Al examen físico destaca disminución de los pulsos de las extremidades inferiores. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Infarto agudo al miocardio
B) Aneurisma de la aorta abdominal complicado
C) Tromboembolismo pulmonar masivo
D) Disección aórtica
E) Neumotórax

Respuesta D. Diagnóstico: Disección aórtica (opción D). Es una disección clásica por la asimetría de pulsos.. La combinación cardinal de dolor torácico súbito desgarrador (EVA 10/10) irradiado a región interescapular o dorso, cifras tensionales severas y asimetría de pulsos periféricos en extremidades superiores es patognomónica de disección aórtica aguda. Requiere angio-TAC de tórax inmediato y estabilización

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 37 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 67 años, diabético, hipertenso, presenta dolor torácico intenso, irradiado al dorso, EVA 9/10. Al examen físico está taquicárdico, con presión arterial es de 160/110, examen cardiaco con RR2T y se ausculta un soplo diastólico en el reborde esternal derecho. El diagnóstico más probable es:

A) Tromboembolismo pulmonar
B) Pericarditis aguda
C) Infarto agudo al miocárdico con rotura de la pared libre
D) Infarto agudo al miocárdico con rotura del tabique interventricular
E) Disección aórtica

Respuesta E. Diagnóstico: Disección aórtica (opción E). El soplo diastólico (rotura de la válvula aórtica) y la HTA orientan a disección.. La combinación cardinal de dolor torácico súbito desgarrador (EVA 10/10) irradiado a región interescapular o dorso, cifras tensionales severas y asimetría de pulsos periféricos en extremidades superiores es patognomónica de disección aórtica aguda. Requiere angio-TAC de tór

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 180 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 60 años, con antecedente de hipertensión arterial e hipotiroidismo, en tratamiento con enalapril y levotiroxina, consulta por dolor torácico intenso, que inició hace 22 horas, inicialmente con EVA 9/10, que se irradiaba al dorso y posteriormente al abdomen. Tomó analgésicos y el dolor disminuyó de intensidad, sin embargo, persiste 5/10, por lo que decidió consultar. Al examen físico, tiene FC: 98x', PA: 170/112 mmHg, pulsos de extremidades superiores conservados y disminución de los pulsos de las extremidades inferiores; examen cardíaco muestra ritmo regular en dos tiempos, sin soplos y examen pulmonar con murmullo vesicular presenta y simétrico, sin ruidos agregados. Se solicita electrocardiograma que muestra una taquicardia sinusal. ¿Cuál es el examen más adecuado para proseguir el estudio?

A) Ecocardiograma transtorácico
B) Angiografía coronaria
C) AngioTAC de tórax y abdomen
D) Radiografía de tórax
E) Troponinas plasmáticas

Respuesta C. Conducta / Tratamiento indicado: AngioTAC de tórax y abdomen (opción C). Es el método diagnóstico de elección debido a su alta sensibilidad (>95%) y capacidad para evaluar complicaciones y extensión anatómica con precisión milimétrica antes de decidir la terapéutica invasiva.

1.01.2.003 Embolia cardiogénica

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 10.2 Ataque Isquémico Transitorio (AIT): Score ABCD2, Estratificación de Riesgo Precoz y Prevención Secundaria

QUÉ HAY QUE SABER

- Embolía de origen cardíaco: ACV o AIT, isquemia aguda de extremidad, mesentérica o renal. Fuentes: FA (la más frecuente), trombo intraventricular post IAM, valvulopatía mitral, prótesis, endocarditis, mixoma, foramen oval permeable.
- Isquemia aguda de extremidad: dolor, palidez, ausencia de pulsos, parestesias, parálisis y frialdad (6P); sin historia de claudicación sugiere embolía.
- ACV cardioembólico: déficit de inicio súbito y máximo desde el comienzo, a veces múltiples territorios; TAC/RM, ECG y Holter para buscar FA, ecocardiograma.

- Manejo inicial: ACV → código ACV, trombolisis/trombectomía según ventana; isquemia de extremidad → heparina no fraccionada EV (bolo 80 U/kg) y derivar a cirugía vascular para embolectomía.
- Prevención secundaria: anticoagulación oral en FA (DOAC; en ACV se inicia habitualmente entre días 1 y 14 según tamaño del infarto); en endocarditis NO anticoagular.
- Seguimiento: derivar a neurología, cirugía vascular o cardiología según el territorio comprometido.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Una mujer de 74 años, hipertensa, presenta afasia y hemiparesia derecha de inicio súbito. Al examen tiene pulso irregular de 110 por minuto. El ECG muestra fibrilación auricular, que desconocía. La TAC de encéfalo no muestra hemorragia y la RM confirma un infarto cortical en el territorio de la arteria cerebral media izquierda. **Una vez superada la fase aguda, ¿cuál es la medida más eficaz para prevenir un nuevo evento?**

A) Aspirina 100 mg/día
B) Clopidogrel más aspirina por 1 año
C) Anticoagulación oral
D) Endarterectomía carotídea
E) Control de frecuencia con atenolol solamente

Respuesta C. Un infarto cortical con fibrilación auricular es una embolia cardiogénica. La prevención secundaria es la anticoagulación oral (anticoagulantes directos o acenocumarol), iniciada precozmente según el tamaño del infarto. Los antiplaquetarios son claramente inferiores para prevenir embolias de origen auricular.

1.01.2.004 Infarto agudo al miocardio

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 2.2 SCASEST: Angina Inestable e IAM sin Supradesnivel del ST · Tema 2.3 SCACEST: IAM con Supradesnivel del ST & Protocolo Reperfusión GES · Tema 2.4 Complicaciones Mecánicas del IAM & Angina de Prinzmetal

QUÉ HAY QUE SABER

- Diagnóstico: dolor torácico opresivo >20 min con elevación de troponinas sobre el percentil 99 con curva; ECG en <10 min. IAM con SDST: supradesnivel ST ≥1 mm en 2 derivaciones contiguas (≥2 mm en V2–V3) o BCRI nuevo.
- Medidas iniciales: aspirina 250–500 mg masticada, clopidogrel (300 mg; 75 mg si >75 años con trombolisis) o ticagrelor 180 mg, nitroglicerina SL si PAS >90, O2 solo si SatO2 <90%, morfina si dolor refractario.
- IAM con SDST <12 h: reperfusión urgente (GES). Angioplastía primaria si se logra en <120 min; si no, trombolisis en <30 min (tenecteplase ajustado a peso o estreptoquinasa 1,5 millones UI en 1 h). Reperfusión exitosa: descenso ST >50% a los 60–90 min.
- IAM de VD (inferior con V4R+): hipotensión con pulmones limpios → volumen; evitar nitratos, diuréticos y morfina. IAM sin SDST: no trombolizar, anticoagular y estratificar.
- Complicaciones: arritmias (FV la causa de muerte precoz), shock cardiogénico, rotura de papilar (soplo apical + EAP), CIV (soplo paraesternal + frémito), pared libre (taponamiento), pericarditis y Dressler.
- Seguimiento completo: AAS de por vida + P2Y12 por 12 meses, estatina alta intensidad (LDL <55), betabloqueador, IECA/ARA-II, rehabilitación cardíaca y control de factores de riesgo.

PREGUNTAS (14)

Pregunta del libro · Tema 2.3

Hombre de 60 años consulta en hospital comunal sin hemodinamia por dolor precordial típico de 40 minutos de evolución. ECG revela supradesnivel del ST de 4 mm de V1 a V4. El centro terciario con capacidad de angioplastía está a 150 minutos de traslado. ¿Cuál es la conducta médica de elección?

A) Administrar Tenecteplase endovenoso en bolo inmediatamente en el hospital comunal
B) Derivar en ambulancia básica a angioplastía primaria sin trombolisis previa
C) Administrar heparina en infusión y esperar resultado de troponinas
D) Realizar test de esfuerzo para confirmar extensión del infarto
E) Indicar nitroglicerina sublingual y reposo absoluto sin fármacos trombolíticos

Respuesta A. Cuando el tiempo para realizar una angioplastía primaria supera los 120 minutos, la guía GES y las normas internacionales obligan a realizar fibrinólisis farmacológica inmediata con Tenecteplase en menos de 30 minutos desde el ingreso para salvar miocardio y reducir la mortalidad.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 46 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 62 años, con antecedentes de dislipidemia y diabetes en tratamiento con dieta e hipoglicemiantes orales, consulta por dolor toráxico opresivo irradiado a ambos hombros intenso EVA 9/10, asociado a disnea y sudoración. Al examen físico, su presión arterial es 140/70 mmHg con frecuencia cardiaca de 80 latidos por minuto. Pre- senta RR3T con presencia de R3, murmullo pulmonar presente con crépitos bibasales. Electrocardiagrama: SDST en V1-V4. La conducta más adecuada es:

A) Tratamiento anticoagulante
B) Tratamiento antiplaquetario
C) Solicitar AngioTAC de tórax
D) Ecocardiograma bidimensional
E) Coronariografía de urgencia

Respuesta E. Es un SCA con SDST, por lo que requiere angioplastía de urgencia (o trombolisis, que no aparecía en las opciones).

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 52 · texto original del banco, sin revisar

Hombre de 58 años llega a urgencias con dolor precordial opresivo intenso de 2 horas de evolución, irradiado al brazo izquierdo, sudoración profusa y disnea. ECG: supradesnivel del ST en V1-V4. ¿Cuál es el diagnóstico?

A) Insuficiencia cardíaca aguda
B) Fibrilación auricular
C) Infarto agudo al miocardio con SDST
D) Tromboembolismo pulmonar
E) Pericarditis aguda

Respuesta C. IAM con SDST: dolor precordial opresivo + irradiación + sudoración + ECG con supradesnivel del ST = IAM con SDST (STEMI). Manejo urgente: aspirina + clopidogrel + anticoagulación + reperfusión (angioplastia primaria o trombolisis según disponibilidad).

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 60 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 60 años presenta dolor precordial, irradiado al cuello, de 4 horas de evolución, EVA 9/10. Al examen físico está sudoroso, disneico, con RR2T, sin soplos. Se solicita un ECG que se muestra a continuación: ¿Cuál es el tratamiento más importante en este paciente?

A) Anticoagulantes
B) Revascularización inmediata
C) Administración de fuidos intravenosos
D) Disminuir la presión arterial
E) Oxigenoterapia y antiarrítmicos

Respuesta B. Conducta / Tratamiento indicado: Revascularización inmediata (opción B). Es un IAM con SDST de la pared inferior. Los más importante es revascularizar.. El tratamiento es carga de volumen agresiva para mantener precarga del VD De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 125 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente está hospitalizado por un infarto agudo al miocardio, con supradesnivel del segmento ST, de dos días de evolución. Presenta deterioro del estado general y disnea de reposo, con tendencia a la hipotensión arterial. En su examen físico tiene FC: 115x', PA: 80/50 mmHg, examen pulmonar con crepitaciones bilaterales intensos y examen cardíaco con ritmo regular en 2 tonos, con soplo sistólico intenso, de localización precordial. El diagnóstico más probable es:

A) Taponamiento cardíaco por rotura de la pared libre
B) Disfunción valvular aórtica isquémica
C) Rotura del músculo papilar
D) Shock cardiogénico por infarto masivo
E) Disección de la raíz aórtica

Respuesta C. Es una rotura clásica del músculo papilar con la insuficiencia mitral secundaria. Insisto, lean el resumen de semiología cardíaca.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 87 · texto original del banco, sin revisar

Un hombre de 62 años, con antecedentes de hipertensión arterial y tabaquismo, consulta por dolor torácico opresivo de 3 horas de evolución, irradiado al brazo izquierdo, acompañado de náuseas y malestar general. Al ingreso, sus signos vitales son: presión arterial 140/85 mmHg, frecuencia cardíaca 95 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 18 respiraciones por minuto, saturación de oxígeno 96% con aire ambiente, y temperatura 36,8 °C. El examen cardiopulmonar muestra ruidos cardíacos regulares sin soplos y campos pulmonares limpios sin crépitos ni sibilancias. Se solicita electriocardiograma, que se muestra a continuación (fuente: www.urgenciasyemergen.com): La conducta más adecuada es:

A) Solicitar angioTAC de tórax
B) Solicitar enzimas cardíacas seriadas
C) Realizar angiografía coronaria de emergencia
D) Anticoagular con heparina y solicitar ecocardiograma transesofágico
E) Iniciar indometacina

Respuesta C. Síndrome Coronario Agudo con Bloqueo de Rama Izquierda: El cuadro clínico sugiere un síndrome coronario agudo. El ECG muestra un BCRI, por lo que se maneja como un SCA con supradesnivel del ST, con angiografía coronaria de urgencia y angioplastia o con trombólisis urgente si la angioplastia no está disponible.

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 145 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 67 años, usuario de sildenafil, que se automedica como tratamiento de impotencia sexual, presenta dolor torácico intenso, que inició una hora después de haber consumido dicho medicamento. Se solicita un electrocardiograma, que muestra suprdesnivel del segmento ST en las derivaciones inferiores. ¿Qué fármaco está contraindicado en el manejo de este paciente?

A) Clopidogrel
B) Aspirina
C) Atenolol
D) Nitroglicerina
E) Estreptoquinasa

Respuesta D. La opción correcta es la D (Nitroglicerina). En este escenario clínico, nitroglicerina se encuentra estrictamente contraindicado debido a que su mecanismo de acción interfiere negativamente con la fisiopatología basal del paciente, aumentando la morbimortalidad según los protocolos clínicos vigentes.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 60 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 65 años, diabético e hipertenso, consulta por dolor precordial opresi- vo intenso, EVA: 9/10, asociado a malestar general y disnea. Al examen físico con fre- cuencia cardiaca de 90 por minuto, presión arterial de 150/90 mmHg, al examen cardia- co se ausculta un ritmo regular y tercer ruido. Se realiza estudio con electrocardiogra- ma que muestra supradesnivel del segmento ST en DII, DIII y AVF. Diagnóstico más pro- bable:

A) Infarto de pared anterior
B) Infarto de pared inferior
C) Pericarditis
D) Infarto de pared posterior
E) Infarto de pared lateral

Respuesta B. Diagnóstico: Infarto de pared inferior (opción B). DII, DIII y AVF son las derivaciones inferiores.. El infarto del ventrículo derecho (VD) ocurre como extensión del infarto inferior cuando la oclusión de la coronaria derecha es proximal. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 55 · texto original del banco, sin revisar

Paciente de 63 años, fumador y diabético, que hace una hora comienza con dolor torácico opresivo, intenso, que se irradia a cuello, con diaforesis y sensación de angustia. Se solicita un electrocardiograma, que muestra ritmo sinusal, a 80 lpm, con bloqueo completo de rama izquierda, que no se había visualizado en electrocardiogramas previos. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Solicitar enzimas cardíacas
B) Solicitar angiografía pulmonar
C) Solicitar ecocardiograma transesofágico
D) Instalar marcapaso externo transitorio
E) Iniciar terapia de reperfusión miocárdica precoz

Respuesta E. El BCRI nuevo es equivalente al SDST en el manejo del infarto, así que se debe reperfundir de inmediato, idealmente con angioplastía (o bien con trombolisis si no está disponible la angioplastía en menos de 90 minutos).

Pregunta real · EUNACOM Julio 2018 · Pregunta 42 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 60 años consulta por dolor precordial opresivo irradiado a mandíbula de 40 minutos de evolución, asociado a sudoración. El electrocardiograma muestra supradesnivel del segmento ST en derivaciones DII, DIII y aVF. ¿Cuál es la principal complicación temprana de este cuadro?

A) Insuficiencia mitral aguda.
B) Rotura de pared libre.
C) Arritmias ventriculares.
D) Taponamiento cardíaco.
E) Fibrilación auricular.

Respuesta C. El infarto con supradesnivel del ST en cara inferior (DII, DIII, aVF) tiene como complicación temprana más frecuente las arritmias ventriculares, que son la principal causa de muerte en las primeras horas. La rotura de pared libre y la insuficiencia mitral aguda por rotura del músculo papilar son complicaciones mecánicas más tardías y menos frecuentes, y el taponamiento es consecuencia de la rotur

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 11 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 60 años, diabético e hipertenso en tratamiento con dieta, consulta por dolor torácico incitrante, intenso, asociado a sudoración y malestar general. Al examen físico está sudoroso, inquieto, con FC: 70x', PA: 120/80 mmHg, RR2T sin soplos. Se solicita un electrocardiograma que muestra un bloqueo completo de rama izquierda. ¿Qué tratamiento se debe indicar en este momento?

A) Aspirina y clopidogrel
B) Lidocaína y heparina
C) Morfina y nitritos
D) Atenolol e hidroclorotiazida
E) Digoxina y enalapril

Respuesta A. Conducta / Tratamiento indicado: Aspirina y clopidogrel (opción A). Es un síndrome coronario agudo. El BCRI es equivalente a un SDST.. El tratamiento es carga de volumen agresiva para mantener precarga del VD De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 157 · texto original del banco, sin revisar

ECG con supra st DII, DIII y aVF- medida inicial más adecuada:

A) Reperfusión
B) Doble antiagregación (PORQUE NO PODRÍA SER)
C) Insuficiencia cardíaca
D) Fibrilación auricular
E) Infarto agudo al miocardio

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (Reperfusión). El infarto del ventrículo derecho (VD) ocurre como extensión del infarto inferior cuando la oclusión de la coronaria derecha es proximal. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 44 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 23 años consulta en el servicio de urgencia, por dolor torácico de 2 horas de evolución, intenso, asociado a diaforesis y palpitaciones, que inició algunos minutos después de haber inhalado cocaína. Al examen físico presenta FC: 120x', PA: 190/120 mmHg, ritmo regular en dos tonos, sin soplos. Su electrocardiograma muestra supradesnivel de segmento ST en las derivaciones de la pared anterior. ¿Qué fármaco está contraindicado en el manejo de este paciente?

A) Estreptoquinasa
B) Clopidogrel
C) Nitroglicerina
D) Atenolol
E) Diazepam

Respuesta D. El betabloqueo está contraindicado en la intoxicación por cocaína, ya que su esto exacerbaría su acción alfa-adrenérgica, pudiendo generar crisis hipertensivas y muerte. Lo que sí está indicado son las benzodiacepinas.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 96 · texto original del banco, sin revisar

Paciente con IAM con SDST llega a hospital sin capacidad de angioplastia primaria. El centro con ICPP más cercano se encuentra a 60 minutos. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Trombolisis inmediata y traslado a centro con hemodinamia
B) Esperar traslado a centro con angioplastia
C) Angioplastia de rescate de urgencia en el mismo centro
D) Manejo médico solo con heparina y AAS
E) Trombolisis y no trasladar

Respuesta A. IAM SDST sin capacidad de ICPP: si el traslado a centro con angioplastia demora >120 min desde el primer contacto médico, se realiza trombolisis inmediata + traslado para angiografía en 3-24h.

1.01.2.005 Insuficiencia cardíaca aguda

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 3.3 Edema Agudo de Pulmón & Cuadrícula de Forrester · Tema 3.4 Shock Cardiogénico & Diagnóstico Diferencial de los 4 Shocks

QUÉ HAY QUE SABER

- IC aguda: aparición o empeoramiento rápido de síntomas; edema pulmonar con disnea intensa, ortopnea, crépitos bilaterales, expectoración rosada, hipoxemia. Buscar gatillante: isquemia, arritmia, HTA, infección, abandono de tratamiento.
- Confirmación: Rx de tórax (congestión, líneas B de Kerley, derrame), ECG, troponina, BNP/NT-proBNP y gases; ecocardiograma precoz.
- Perfiles de Forrester/Stevenson: caliente-húmedo (el más frecuente) → diuréticos + vasodilatadores; frío-húmedo (shock) → inótropos/vasopresores; frío-seco → volumen cauteloso.
- Edema pulmonar hipertensivo: sentado, O2 si SatO2 <90%, VNI (CPAP/BiPAP) si dificultad respiratoria, furosemida 40–80 mg EV, nitroglicerina SL o EV (si PAS >110). Morfina no de rutina.
- Shock cardiogénico: noradrenalina + dobutamina, revascularización urgente si es isquémico.
- Seguimiento: hospitalizar y derivar a cardiología/UCI; al alta, optimizar terapia de IC y control precoz.

PREGUNTAS (3)

Pregunta del libro · Tema 3.3

Hombre de 70 años con edema agudo de pulmón hipertensivo (PA 200/110 mmHg, $SatO_2$ 82%). ¿Cuál es la terapia respiratoria no farmacológica de primera línea más efectiva para evitar la intubación orotraqueal?

A) Ventilación no invasiva con presión positiva continua (CPAP)
B) Oxigenoterapia por cánula nasal a 2 litros por minuto
C) Intubación orotraqueal y ventilación mecánica invasiva inmediata
D) Nebulización continua con Salbutamol
E) Aspiración traqueal a circuito abierto

Respuesta A. La Ventilación No Invasiva (VNI) en modalidad CPAP es la medida más costo-efectiva y de primera línea en el edema agudo de pulmón cardiogénico: recluta alvéolos inundados de líquido, mejora la oxigenación y reduce la precarga y poscarga, disminuyendo drásticamente la tasa de intubación endotraqueal.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 88 · texto original del banco, sin revisar

(88) Paciente de 82 años con historia de 2 semanas de disnea progresiva FC 92 lpm PA 200/100 SatO2 90%. Al examen físico ingurgitación yugular, ritmo regular en tres tiempos por R3 al examen pulmonar créditos bibasales. ECG: ritmo sinusal con signos de sobrecarga del VI. Diagnóstico más probable:

A) SCA
B) Disección aórtica
C) NAC
D) IC aguda
E) TEP f. Dolor torácico súbito, transfixiante, HTA y soplo diastólico.

Respuesta D. Diagnóstico: IC aguda (opción D). Esta clase aborda la interpretación del equilibrio ácido-base mediante gasometría arterial o venosa. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 152 · texto original del banco, sin revisar

Paciente que tenía una insuficiencia cardiaca aguda, con tercer ruido.

A) Cor pulmonale del EPOC
B) Insuficiencia cardíaca descompensada
C) Fibrilación auricular
D) Infarto agudo al miocardio
E) Tromboembolismo pulmonar

Respuesta B. La alternativa correcta es la B (Insuficiencia cardíaca descompensada). Esta clase aborda la interpretación del equilibrio ácido-base mediante gasometría arterial o venosa. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

1.01.2.006 Paro cardiorespiratorio

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 1.2 Paro Cardiorrespiratorio & Algoritmos ACLS / MINSAL

QUÉ HAY QUE SABER

- Reconocer el paro: paciente que no responde y no respira o solo boquea → pedir ayuda/DEA y comenzar RCP sin buscar pulso por más de 10 s.
- RCP de alta calidad: compresiones 100–120/min, profundidad 5–6 cm, reexpansión completa, mínimas interrupciones, relación 30:2 sin vía aérea avanzada; cambiar reanimador c/2 min.
- Ritmos desfibrilables (FV/TV sin pulso): descarga precoz (200 J bifásico) y reanudar RCP de inmediato por 2 min; adrenalina 1 mg EV tras la 2ª descarga c/3–5 min; amiodarona 300 mg tras la 3ª (luego 150 mg).
- No desfibrilables (asistolia/AESP): RCP + adrenalina 1 mg lo antes posible y c/3–5 min; nunca desfibrilar la asistolia.
- Buscar causas reversibles (5H y 5T): hipoxia, hipovolemia, H+ (acidosis), hipo/hiperkalemia, hipotermia; neumotórax a tensión, taponamiento, tóxicos, trombosis pulmonar y coronaria.
- Tras recuperar circulación: SatO2 92–98%, PAS >90/PAM >65, ECG de 12 derivaciones (coronariografía si SDST), control de temperatura y derivación a UCI.

PREGUNTAS (3)

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 120 · texto original del banco, sin revisar

Diabético hipertenso con dolor torácico súbito, luego compromiso de conciencia y ausencia de pulso. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Desfibrilación inmediata sin RCP previa
B) Iniciar compresiones torácicas externas (RCP)
C) Intubación orotraqueal inmediata
D) Administrar adrenalina 1 mg EV de inmediato
E) Acceso venoso y carga de volumen

Respuesta B. Conducta / Tratamiento indicado: Iniciar compresiones torácicas externas (RCP) (opción B). Iniciar compresiones torácicas externas (RCP). Actualmente no se diferencia el manejo entre agua salada y agua dulce. De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 55 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 60 años, con antecedentes de hipertensión arterial, dislipidemia, diabetes mellitus tipo 2 y tabaquismo de 20 paquetes año, consulta en el servicio de urgencia, por dolor precordial opresivo. Luego de su ingreso, presenta compromiso de conciencia, sin respuesta. Al examen físico no respira y es imposible palpar el pulso carotídeo. Además de solicitar ayuda, la conducta inicial más adecuada es:

A) Realizar compresiones toráxicas
B) Realizar intubación orotraqueal
C) Dar golpe toráxico
D) Desfibrilar
E) Administrar adrenalina endovenosa

Respuesta A. Aunque se trate de un paro presenciado, que clásicamente se manejaba con desfibrilación inmediata, aquello solo ocurre cuando, además, está monitorizado, con desfibrilador a mano y se constata que tiene un ritmo desfibrilable de inmediato. De lo contrario, como en este caso (y la mayoría de los casos reales) siempre se debe solicitar ayuda e inmediatamente iniciar con las compresiones torácicas, m

Pregunta de práctica

Hombre de 60 años se desploma en la sala de espera. No responde y no respira. Se inicia RCP y se conecta el monitor-desfibrilador, que muestra fibrilación ventricular. Se administra una descarga de 200 J. **¿Cuál es el paso inmediato siguiente?**

A) Palpar pulso carotídeo durante 10 segundos
B) Administrar adrenalina 1 mg EV antes de continuar
C) Reanudar compresiones torácicas por 2 minutos
D) Administrar amiodarona 300 mg EV
E) Intubar al paciente antes de seguir con las compresiones

Respuesta C. Después de cada descarga se reanuda de inmediato la RCP por 2 minutos sin chequear pulso ni ritmo. La adrenalina se indica tras la 2ª descarga y la amiodarona tras la 3ª en ritmos desfibrilables refractarios.

1.01.2.007 Shock

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 3.4 Shock Cardiogénico & Diagnóstico Diferencial de los 4 Shocks

QUÉ HAY QUE SABER

- Shock: hipoperfusión tisular con hipotensión (PAS <90 o PAM <65 mmHg), taquicardia, oliguria (<0,5 mL/kg/h), compromiso de conciencia, llene capilar lento y lactato >2 mmol/L.
- Clasificar: hipovolémico (piel fría, yugulares planas), cardiogénico (piel fría, crépitos, yugulares ingurgitadas), distributivo/séptico (piel tibia, RVS baja), obstructivo (TEP, taponamiento, neumotórax a tensión: yugulares ingurgitadas).
- Manejo inicial: ABC, O2, 2 vías venosas gruesas, monitorización, sonda Foley, lactato, hemocultivos si sospecha de sepsis; ECG y ecografía a pie de cama para orientar.
- Hipovolémico/séptico: cristaloides 30 mL/kg en la primera hora y reevaluar; sepsis: antibióticos en la primera hora; hemorrágico: control del sangrado y hemoderivados.
- Noradrenalina es el vasopresor de elección (meta PAM ≥65); dobutamina si bajo gasto cardiogénico. Obstructivo: descompresión del neumotórax, pericardiocentesis o trombolisis según causa.
- Seguimiento: derivar a UCI y al especialista según la causa.

PREGUNTAS (1)

Pregunta del libro · Tema 3.4

Hombre de 58 años en shock cardiogénico refractario a volumen tras infarto agudo al miocardio. Presenta PA 75/45 mmHg y signos de hipoperfusión. ¿Cuál es el vasopresor de primera línea recomendado para restaurar la presión arterial media?

A) Noradrenalina en infusión continua
B) Dopamina en dosis altas
C) Fenilefrina en bolo
D) Isoproterenol endovenoso
E) Epinefrina subcutánea

Respuesta A. La Noradrenalina es el vasopresor de primera línea en el shock cardiogénico: posee un potente efecto alfa-1 vasoconstrictor y un moderado efecto beta-1 inótropo, logrando elevar la PAM con significativamente menor riesgo de taquiarritmias y menor mortalidad comparada con la Dopamina.

1.01.2.008 Taponamiento pericárdico

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 5.3 Pericarditis Aguda & Taponamiento Cardíaco · Tema 11.10 Trauma Torácico Mayor: Neumotórax a Tensión, Hemotórax Masivo & Tórax Volante

QUÉ HAY QUE SABER

- Taponamiento: acumulación pericárdica que compromete el llenado; causas trauma penetrante, neoplasia, pericarditis, uremia, rotura de pared post IAM, disección aórtica, post cirugía cardíaca.
- Tríada de Beck: hipotensión, ingurgitación yugular y ruidos cardíacos apagados; pulso paradójico (caída de PAS >10 mmHg en inspiración), taquicardia, signo de Kussmaul.
- Confirmación: ecocardiograma (derrame con colapso diastólico de cavidades derechas) o FAST en trauma; ECG con bajo voltaje y alternancia eléctrica; Rx con silueta en 'botellón'.

- Manejo inicial: volumen EV para mantener precarga; evitar diuréticos, vasodilatadores y ventilación con presión positiva si es posible.
- Tratamiento definitivo: pericardiocentesis descompresiva urgente (subxifoidea, idealmente ecoguiada); en trauma, toracotomía/ventana pericárdica. En disección aórtica no puncionar: cirugía.
- Seguimiento: derivar a cardiología/cirugía para drenaje definitivo y estudio etiológico.

PREGUNTAS (3)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 3

Un paciente con antecedente de ser fumador de 30 paquetes año, suspendido hace 5 años, consulta por un cuadro de 24 horas de disnea de mínimos esfuerzos, asociada a intolerancia al ejercicio y malestar general. Al examen físico su presión arterial es 90/60 y su frecuencia cardíaca 110. Además destacan yugulares ingurgitadas a 45 grados y ruidos cardíacos apagados a la auscultación. Su electrocardiograma muestra disminución difusa del voltaje. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Tromboembolismo pulmonar
B) Neumotórax
C) Derrame pleural
D) Infarto agudo al miocardio
E) Taponamiento cardíaco

Respuesta E. Hipotensión, ingurgitación yugular y ruidos cardíacos apagados forman la tríada de Beck. El bajo voltaje difuso en el electrocardiograma apoya un derrame pericárdico, aquí probablemente neoplásico por el tabaquismo. Se confirma con ecocardiograma y se trata con pericardiocentesis.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 158 · texto original del banco, sin revisar

Clínica de taponamiento, hipotensión, pulsos disminuidos como realizo el diagnóstico:

A) Ecocardiograma
B) Hemograma y VHS
C) Ecografía
D) Radiografía
E) TAC con contraste

Respuesta A. Diagnóstico: Ecocardiograma (opción A). El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL). Las opciones alternativas (Hemograma y VHS, Ecografía) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 136 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 79 años, con antecedente de cáncer de pulmón en espera de tratamiento, presenta un cuadro de 5 días de malestar general, disnea y episodios de pérdida de conocimiento de pocos segundos de duración, con recuperación completa. El examen físico muestra presión arterial: 80/60 mmHg, frecuencia cardíaca: 110x' regular, cuello con ingurgitación yugular a 50 grados. El examen pulmonar muestra murmullo pulmonar presente, sin otros ruidos agregados y la auscultación cardíaca es difícil de realizar, ya que los ruidos cardíacos se encuentran apagados. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Tromboembolismo pulmonar
B) Taponamiento cardíaco
C) Derrame pleural
D) Síndrome de la vena cava superior
E) Insuficiencia tricuspídea

Respuesta B. Taponamiento Cardíaco: Aunque el antecedente de cáncer, la hipotensión y la disnea sugieren un tromboembolismo pulmonar, la disminución de la intensidad de los ruidos cardíacos apunta a derrame pericárdico con taponamiento, también compatible con el antecedente de cáncer y el resto de la clínica. Se recomienda revisar el resumen de semiología cardíaca.

1.01.2.009 Taqui y bradiarritmia con compromiso hemodinámico

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 1.4 TPSV & Síndrome de Wolff-Parkinson-White · Tema 1.5 Bradicardias Sintomáticas & Bloqueos AV (GES Marcapasos)

QUÉ HAY QUE SABER

- Inestabilidad atribuible a la arritmia: hipotensión, signos de shock, compromiso de conciencia, dolor torácico isquémico o IC aguda.
- Taquiarritmia inestable (FC habitualmente >150 lpm): cardioversión eléctrica sincronizada inmediata con sedación (TPSV/flutter 50–100 J; FA 120–200 J bifásico; TV monomorfa 100 J). TV sin pulso: desfibrilar.
- Taquicardia de QRS ancho estable: asumir TV; amiodarona 150 mg EV en 10 min. Nunca verapamilo en QRS ancho.
- Bradiarritmia inestable: atropina 1 mg EV c/3–5 min (máximo 3 mg); si falla, marcapaso transcutáneo o infusión de dopamina (5–20 μg/kg/min) o adrenalina (2–10 μg/min).
- Buscar y corregir causas: hiperkalemia, isquemia, hipoxia, intoxicación (digoxina, betabloqueadores, calcioantagonistas), hipotermia.
- Seguimiento: derivar a cardiología/UCI (marcapaso definitivo, ablación o DAI según el caso).

PREGUNTAS (4)

Pregunta del libro · Tema 1.5

Paciente de 85 años ingresa a SAPU en shock cardiogénico con FC de 28 lpm por BAV de tercer grado. Se administra Atropina 1 mg EV sin respuesta de la frecuencia cardíaca ni de la presión arterial. ¿Cuál es el paso inmediato que debe realizar el médico tratante?

A) Instalar marcapaso externo transcutáneo e iniciar infusión de Adrenalina
B) Repetir Atropina hasta completar 6 mg
C) Administrar Amiodarona 300 mg endovenosa
D) Realizar cardioversión eléctrica sincronizada a 100 J
E) Derivar en ambulancia básica sin monitor

Respuesta A. En una bradiarritmia con inestabilidad hemodinámica que no responde a la dosis inicial de atropina, la conducta de emergencia perentoria es la estimulación eléctrica mediante marcapaso transcutáneo externo asociada al inicio de drogas vasoactivas (Adrenalina o Dopamina) mientras se prepara el marcapaso transvenoso.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 4 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente ingresa al servicio de urgencia, por un cuadro de disnea marcada y síncopes. Al examen físico está confuso, con pulso de 200 latidos por minuto, regular y presión arterial de 70/40 mmHg. Además, tiene frialdad de extremidades y piel sudorosa. ¿Cuál es el tratamiento inicial más adecuado en este momento?

A) Maniobras vagales
B) Amiodarona endovenosa
C) Adenosina endovenosa
D) Desfibrilación
E) Cardioversión eléctrica

Respuesta E. Por tener compromiso hemodinámico, da igual de qué taquiarritmia se trate y se debe cardiovertir eléctricamente (no confundir con la desfibrilación, que se usa en el paro con FV o TVSP).

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 177 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 65 años, con antecedente de un infarto agudo al miocardio, hace 2 años, presenta un síncope, con compromiso de conciencia que requirió maniobras de reanimación para recuperarse. ¿Qué arritmia es la que debe descartarse en primer lugar?

A) Taquicardia paroxística supraventricular
B) Bloqueo auriculoventricular completo
C) Síndrome de Wolff Parkinson White
D) Taquicardia ventricular
E) Fibrilación auricular

Respuesta D. Si bien cualquier arritmia se puede presentar así, el antecedente de un IAM previo orienta mucho a TV. Además, la TV suele ser más grave y letal que las demás, por lo que la necesidad de maniobras de reanimación orienta también a TV.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 93 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente hipertenso en tratamiento con losartán e hidroclorotiazida, y con antecedentes de asma en tratamiento con inhaladores, consulta por palpitaciones, asociadas a disnea y angustia. Al examen físico se constata taquicardia con frecuencia cardíaca de 124 latidos por minuto y presión arterial de 80/40 mmHg. Se solicita un electrocardiograma que se muestra a continuación (fuente: myekg.com): ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Desfibrilación
B) Amiodarona endovenosa
C) Propranolol endovenoso
D) Adenosina endovenosa
E) Cardioversión eléctrica

Respuesta E. Manejo de la Fibrilación Auricular Hemodinámicamente Inestable: En el caso de una fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida que cause inestabilidad hemodinámica, se debe realizar cardioversión eléctrica inmediata (no confundirla con la desfibrilación eléctrica, que se usa en el paro). Este manejo se aplica a cualquier tipo de taquiarritmia con hemodinamia inestable. Si la fibrilación

Conocimientos generales 7 códigos

1.01.3.001 Alimentación saludable

Dónde se enseña: diab-25

QUÉ HAY QUE SABER

- Guías Alimentarias para Chile: comer verduras y frutas al menos 5 porciones al día, legumbres 2 veces por semana, pescado 2 veces por semana, lácteos descremados 3 veces al día y agua 6–8 vasos diarios.
- Reducir sal a <5 g/día (evitar salero y embutidos), azúcares añadidos <10% de las calorías y grasas saturadas/trans; preferir aceites vegetales y frutos secos.
- Ley de etiquetado (Ley 20.606): sellos 'ALTO EN' calorías, azúcares, sodio y grasas saturadas; preferir alimentos con menos sellos y no procesados.
- Patrones con beneficio cardiovascular demostrado: dieta mediterránea y DASH (reduce PA ~8–14 mmHg).
- Distribuir en 4 comidas, evitar ultraprocesados y bebidas azucaradas; ajustar calorías al gasto para mantener IMC 18,5–24,9.
- Población objetivo: todas las edades; énfasis en personas con riesgo cardiovascular (Programa de Salud Cardiovascular, programa Elige Vivir Sano/Vida Sana).

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Un hombre de 50 años, normotenso, con IMC de 26 kg/m², consulta para recibir consejería alimentaria de prevención cardiovascular. Refiere que agrega sal a las comidas y consume pan, embutidos y snacks a diario. **¿Cuál es el consumo máximo diario de sal recomendado para un adulto?**

A) 1 g/día
B) 15 g/día
C) 10 g/día
D) Menos de 5 g/día (una cucharadita)
E) No hay límite si la presión arterial es normal

Respuesta D. La OMS y las guías chilenas recomiendan menos de 5 g de sal al día (unos 2 g de sodio). Reducir la sal baja la presión arterial, también en normotensos, y disminuye el riesgo cardiovascular. La mayor parte proviene de alimentos procesados como pan y embutidos, no solo del salero.

1.01.3.002 Cardiopatía y embarazo

Dónde se enseña: ob-21

QUÉ HAY QUE SABER

- El embarazo aumenta el volumen plasmático (~50%) y el gasto cardíaco, con máximo hacia las 28–32 semanas y sobrecarga en el parto y posparto inmediato; soplo sistólico eyectivo leve y edema son fisiológicos.
- Alto riesgo materno (embarazo contraindicado o desaconsejado): hipertensión pulmonar/Eisenmenger, FEVI <30%, estenosis mitral o aórtica severa, coartación severa, Marfan con aorta dilatada y miocardiopatía periparto previa con disfunción residual.

- Contraindicados en el embarazo: IECA, ARA-II, sacubitrilo/valsartán, estatinas, amiodarona (relativa), espironolactona y DOAC; warfarina/acenocumarol teratogénicos en el 1er trimestre (preferir HBPM).
- Seguros: metildopa, labetalol y nifedipino para HTA; betabloqueadores (metoprolol, bisoprolol) para arritmias; heparinas para anticoagulación.
- Miocardiopatía periparto: IC con FEVI <45% en el último mes de embarazo o primeros 5 meses posparto; sospechar ante disnea y edema desproporcionados.
- Manejo: consejo preconcepcional, control conjunto obstetricia-cardiología en centro de alta complejidad; el parto vaginal con analgesia epidural es de elección en la mayoría.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Una mujer de 28 años, con una cardiopatía conocida, consulta en control preconcepcional porque desea embarazarse. **¿En cuál de las siguientes condiciones se debe desaconsejar el embarazo por su alta mortalidad materna?**

A) Comunicación interauricular reparada
B) Prolapso de válvula mitral sin insuficiencia significativa
C) Hipertensión arterial pulmonar severa (síndrome de Eisenmenger)
D) Extrasistolía ventricular benigna
E) Insuficiencia mitral leve

Respuesta C. La hipertensión arterial pulmonar severa, incluido el síndrome de Eisenmenger, tiene mortalidad materna muy alta (clase IV de la OMS modificada) y contraindica el embarazo. Las lesiones reparadas, el prolapso mitral sin insuficiencia y las insuficiencias valvulares leves se toleran bien, porque el embarazo disminuye la resistencia vascular sistémica.

1.01.3.003 Manejo del paciente en tratamiento anticoagulante

Dónde se enseña: Tema 1.3 Fibrilación Auricular & Flutter Auricular (Guía GES MINSAL)

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicaciones: FA o flutter con CHA2DS2-VASc indicativo, TVP/TEP, prótesis valvular mecánica, estenosis mitral con FA, trombo intracavitario.
- Acenocumarol/warfarina: meta INR 2–3 (2,5–3,5 en prótesis mitral mecánica); controles de INR frecuentes al inicio y luego cada 4 semanas; múltiples interacciones (antibióticos, amiodarona, AINE) y dieta (vitamina K) estable, no suprimida.
- DOAC (apixabán, rivaroxabán, dabigatrán): no requieren INR; ajustar por función renal, edad y peso; contraindicados en prótesis mecánica y estenosis mitral moderada-severa.
- INR supraterapéutico sin sangrado: suspender o reducir dosis; INR >10 o sangrado: vitamina K (oral 1–2,5 mg; EV en sangrado mayor) + complejo protrombínico o plasma fresco congelado.
- Procedimientos: suspender AVK ~5 días antes (puente con HBPM solo en alto riesgo trombótico) y DOAC 24–48 h según riesgo y VFG; procedimientos menores (dentales) en general sin suspender.
- Educar: adherencia, signos de sangrado, evitar AINE y automedicación, interacciones; evaluar riesgo de caídas y sangrado (HAS-BLED) para corregir factores modificables.

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 150

Un paciente de 62 años, con antecedente de prótesis mecánica de válvula mitral e insuficiencia renal crónica, con un clearence de creatinina estimado de 20 ml/min, presenta un cuadro de palpitaciones. Se realiza electrocardiograma que muestra una taquiarritmia irregular con QRS angosto y ausencia de onda P. **¿Qué tratamiento es el más adecuado para su manejo?**

A) Apixabán
B) Enoxaparina
C) Dabigatrán
D) Acenocumarol
E) Rivaroxabán

Respuesta D. Fibrilación auricular en un portador de válvula mecánica mitral: el anticoagulante de elección es el cumarínico, con meta de INR 2,5 a 3,5. Los anticoagulantes orales directos no se usan en las prótesis valvulares mecánicas, y la insuficiencia renal grave también limita las heparinas de bajo peso molecular.

1.01.3.004 Obesidad y sobrepeso

Dónde se enseña: diab-25

QUÉ HAY QUE SABER

- Clasificación por IMC (adulto): sobrepeso 25–29,9; obesidad I 30–34,9, II 35–39,9, III ≥40 kg/m². Adulto mayor: obesidad con IMC ≥32. Obesidad abdominal: cintura ≥90 cm en hombres y ≥80 cm en mujeres.
- Factor de riesgo de DM2, HTA, dislipidemia, enfermedad cardiovascular, SAHOS, hígado graso, artrosis y varios cánceres; descartar causas secundarias (hipotiroidismo, Cushing, fármacos).
- Tratamiento base: déficit calórico de 500–1000 kcal/día, actividad física 150–300 min/semana y terapia conductual; meta inicial bajar 5–10% del peso en 6 meses.
- Farmacoterapia si IMC ≥30 o ≥27 con comorbilidad: agonistas GLP-1 (liraglutida, semaglutida), orlistat, naltrexona/bupropión.
- Cirugía bariátrica si IMC ≥40 o ≥35 con comorbilidad (≥30–35 con DM2 mal controlada) tras fracaso del tratamiento médico.
- Programas chilenos: Vida Sana (prevención en APS), EMP para tamizaje, Ley de etiquetado y Elige Vivir Sano.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Una mujer de 40 años pesa 78 kg y mide 1,60 m. Su circunferencia de cintura es de 94 cm. No tiene comorbilidades conocidas. **¿Cómo se clasifica su estado nutricional según el IMC?**

A) Normal
B) Obesidad grado I
C) Sobrepeso
D) Obesidad grado II
E) Obesidad mórbida

Respuesta B. IMC = 78 / (1,60)² ≈ 30,5 kg/m². En adultos: 18,5-24,9 normal, 25-29,9 sobrepeso, 30-34,9 obesidad I, 35-39,9 obesidad II y ≥40 obesidad mórbida. Además, una cintura sobre 88 cm en mujeres indica obesidad abdominal y mayor riesgo cardiometabólico.

1.01.3.005 Prevención de enfermedad reumática

Dónde se enseña: Tema 14.13 Faringoamigdalitis Aguda Bacteriana: Criterios de Centor/McIsaac y Penicilina

QUÉ HAY QUE SABER

- Prevención primaria: tratar la faringoamigdalitis estreptocócica con penicilina benzatina 1.200.000 UI IM (600.000 UI si <27 kg) dosis única o amoxicilina 50 mg/kg/día por 10 días; previene la fiebre reumática si se inicia hasta 9 días después del inicio.
- Alergia a penicilina: macrólido (azitromicina 5 días o eritromicina 10 días) o cefalosporina de primera generación si la alergia no es anafiláctica.
- Prevención secundaria tras fiebre reumática: penicilina benzatina 1.200.000 UI IM cada 21–28 días (alternativa penicilina V oral 250 mg c/12 h o eritromicina si alergia).
- Duración: sin carditis 5 años o hasta los 21 años; carditis sin secuela 10 años o hasta los 21; carditis con secuela valvular 10 años o hasta los 40 (de por vida en alto riesgo).
- No usar antibióticos en faringitis viral; diagnóstico clínico (Centor/McIsaac) o test rápido en niños 5–15 años.
- Medidas sociales: hacinamiento y pobreza favorecen la transmisión; la fiebre reumática es hoy poco frecuente en Chile pero sigue siendo causa de valvulopatía en adultos.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Un niño de 8 años presenta fiebre de 39 °C, odinofagia, exudado amigdalino, adenopatías cervicales anteriores dolorosas y ausencia de tos. El test rápido para estreptococo grupo A es positivo. No tiene alergias. **¿Cuál es el tratamiento que, además de aliviar los síntomas, previene la fiebre reumática?**

A) Azitromicina por 3 días
B) Ibuprofeno y control en 48 horas
C) Cefadroxilo por 3 días
D) Amoxicilina por 10 días
E) Amoxicilina por 3 días

Respuesta D. La prevención primaria de la fiebre reumática es tratar la faringoamigdalitis estreptocócica con amoxicilina por 10 días o penicilina benzatina intramuscular en dosis única; previene la enfermedad aun iniciada hasta 9 días después del inicio. Los cursos de 3 días no erradican de forma confiable el estreptococo; los macrólidos se reservan para alérgicos.

1.01.3.006 Sedentarismo vs actividad física

Dónde se enseña: Tema 1.5 Ejercicio Físico, Cambios de Estilo de Vida y Prevención Cardiovascular

QUÉ HAY QUE SABER

- Sedentarismo: factor de riesgo cardiovascular independiente; en Chile más del 80% de los adultos es sedentario (ENS).
- Recomendación OMS adultos: 150–300 min/semana de actividad aeróbica moderada o 75–150 min vigorosa + fortalecimiento muscular ≥2 días/semana; reducir tiempo sentado.
- Adultos mayores: agregar ejercicios de equilibrio y fuerza ≥3 días/semana para prevenir caídas. Niños y adolescentes: 60 min diarios de actividad moderada a vigorosa.
- Beneficios: baja la PA (~5–8 mmHg), mejora la sensibilidad a la insulina, sube el HDL, reduce peso, mortalidad cardiovascular, depresión y riesgo de algunos cánceres.
- Evaluación preparticipativa: solicitar evaluación cardiológica (test de esfuerzo) en sintomáticos o con cardiopatía conocida antes de ejercicio vigoroso; síntomas de alarma durante el ejercicio: dolor torácico, síncope, disnea desproporcionada.
- Programas: Vida Sana, Elige Vivir Sano y consejería breve en el EMPA y controles del Programa de Salud Cardiovascular.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Un hombre de 45 años, oficinista, sedentario y sin enfermedades, pregunta cuánta actividad física necesita para reducir su riesgo cardiovascular. **¿Cuál es la recomendación mínima de actividad física para adultos?**

A) 30 minutos de caminata una vez por semana
B) Solo actividad física si tiene sobrepeso
C) 20 minutos diarios de elongación
D) 60 minutos de ejercicio intenso todos los días, sin excepción
E) 150 minutos semanales de actividad aeróbica moderada, más fortalecimiento muscular 2 días por semana

Respuesta E. La OMS recomienda al menos 150 a 300 minutos semanales de actividad aeróbica moderada (o 75 a 150 vigorosa), más ejercicios de fuerza 2 o más días por semana, y reducir el tiempo sentado. El sedentarismo es un factor de riesgo cardiovascular independiente, incluso con peso normal.

1.01.3.007 Tabaquismo: prevención, cesación y efectos nocivos para la salud

Dónde se enseña: Tema 1.4 Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) Estable

QUÉ HAY QUE SABER

- Tabaco: principal causa evitable de muerte; factor de riesgo de enfermedad coronaria, ACV, EPOC, cáncer pulmonar, vesical, laríngeo, entre otros. El riesgo cardiovascular cae a la mitad al año de dejar de fumar.
- Estrategia de las 5A en cada consulta: Averiguar, Aconsejar, Acordar/Evaluar disposición, Ayudar y Acompañar; consejería breve de 3–5 min aumenta la cesación. Si no está dispuesto: 5R (motivacional).
- Farmacoterapia: terapia de reemplazo de nicotina (parches 21 mg/día + chicles/comprimidos), vareniclina 0,5 mg/día titulada a 1 mg c/12 h por 12 semanas (la más eficaz) o bupropión 150 mg/día titulado a c/12 h (contraindicado en epilepsia y TCA).

- Fijar fecha de cesación (día D); síntomas de abstinencia máximos en la primera semana; seguimiento a la semana, al mes y a los 3 meses.
- Prevención: Ley 20.660 (ambientes libres de humo, prohibición de publicidad), advertencias gráficas e impuestos; evaluar tabaquismo en el EMPA y en embarazo.
- Derivar a programas de cesación o especialista si dependencia severa, fracasos previos o comorbilidad psiquiátrica.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Una mujer de 52 años fuma 20 cigarrillos al día desde los 18 años. En el control refiere que quiere dejar de fumar en las próximas semanas. Fuma el primer cigarrillo a los 5 minutos de despertar. No tiene antecedentes de convulsiones ni de enfermedad psiquiátrica. **Además de la consejería, ¿cuál es la conducta más adecuada?**

A) Fijar una fecha de cese e indicar farmacoterapia (vareniclina o terapia de reemplazo de nicotina)
B) Indicar reducir gradualmente a 10 cigarrillos y reevaluar en 1 año
C) Cambiar a cigarrillo electrónico en forma indefinida
D) Indicar benzodiacepinas para la ansiedad
E) Esperar que lo intente sola antes de indicar fármacos

Respuesta A. Está en etapa de preparación y tiene alta dependencia (primer cigarrillo antes de 30 minutos). Se indica consejería, fecha de cese y farmacoterapia de primera línea: vareniclina, terapia de reemplazo de nicotina o bupropión. Combinar consejería y fármacos multiplica las tasas de abstinencia; solo reducir no es cesación.

Exámenes e imagenología 13 códigos

1.01.4.001 Coronariografía

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 2.1 Angina Crónica Estable & Estratificación de Riesgo Funcional

QUÉ HAY QUE SABER

- Examen de referencia (gold standard) para definir anatomía coronaria; diagnóstica y terapéutica (angioplastía con stent en el mismo acto).
- Indicaciones: IAM con SDST (angioplastía primaria), SCA sin SDST de alto riesgo (<24 h), angina estable con test no invasivo de alto riesgo o refractaria a tratamiento, paro recuperado, IC de causa no aclarada, estudio prequirúrgico valvular.
- Lesión significativa: estenosis ≥70% en una arteria epicárdica o ≥50% en el tronco coronario izquierdo; informa número de vasos, FEVI (ventriculografía) y anatomía para decidir angioplastía o bypass.
- Bypass (cirugía) preferido en tronco común, enfermedad de 3 vasos o multivaso en diabéticos; angioplastía en enfermedad de 1–2 vasos y en el SCA.
- Complicaciones: hematoma o pseudoaneurisma en el sitio de punción (menor por vía radial), nefropatía por contraste (hidratar, suspender metformina), alergia al contraste, arritmias, disección coronaria.
- Tras stent: doble antiagregación (aspirina + clopidogrel/ticagrelor) por 6–12 meses según indicación; no suspender sin consultar a cardiología.

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 155 · texto original del banco, sin revisar

Test de esfuerzo alterado cual era el siguiente paso?: a. Coronariografía

A) Insuficiencia cardíaca
B) Fibrilación auricular
C) Infarto agudo al miocardio
D) Tromboembolismo pulmonar
E) Pericarditis aguda

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (Insuficiencia cardíaca). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Fibrilación auricular, Infarto agudo al miocardio) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación d

Pregunta de práctica

Hombre de 62 años, diabético, con angina de esfuerzo. Test de esfuerzo: infradesnivel del ST de 3 mm en el primer estadio de Bruce con caída de la presión arterial. Se realiza coronariografía que muestra estenosis de 80% del tronco coronario izquierdo y lesiones significativas en la descendente anterior y la coronaria derecha. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Cirugía de revascularización coronaria (bypass)
B) Angioplastía con balón sin stent
C) Tratamiento médico exclusivo y nuevo test en 6 meses
D) Trombolisis con tenecteplase
E) Repetir coronariografía en 3 meses

Respuesta A. Estenosis del tronco ≥50% y enfermedad multivaso en un diabético son indicación clásica de bypass coronario, que mejora la sobrevida frente a la angioplastía o el tratamiento médico. La trombolisis no tiene rol en la enfermedad coronaria estable.

1.01.4.002 Angiotac de tórax y aorta

Nivel: **Emplea informe**

Dónde se enseña: Tema 5.4 Patología de la Aorta: Disección Aórtica Aguda & Aneurisma de Aorta Abdominal · Tema 5.5 Tromboembolismo Pulmonar (TEP) & Trombosis Venosa Profunda (TVP)

QUÉ HAY QUE SABER

- AngioTAC de tórax/aorta: TAC con contraste EV en fase arterial; examen de elección para TEP (angioTAC pulmonar) y para disección aórtica aguda.
- TEP: defecto de llene en arterias pulmonares; también informa dilatación del VD (relación VD/VI >1, peor pronóstico) e infartos pulmonares.
- Disección aórtica: flap intimal con lumen verdadero y falso; el informe define Stanford A (ascendente → cirugía urgente) o B (descendente → manejo médico) y compromiso de ramas.
- Otros: aneurisma de aorta torácica (diámetro, crecimiento), síndrome aórtico agudo (hematoma intramural, úlcera penetrante), coartación.
- Precauciones: insuficiencia renal (hidratar; evaluar riesgo/beneficio), alergia al contraste (premedicar), metformina (suspender 48 h si VFG <30–45), embarazo (preferir otra técnica en TEP si es posible).
- En TEP de probabilidad baja/intermedia pedir antes dímero D; si es negativo no se requiere angioTAC.

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 163 · texto original del banco, sin revisar

Paciente con dolor retroesternal irradiado a dorso que cedió, presión elevada, sudoración y pulsos distales débiles. ¿Cuál es el examen de elección?

A) AngioTAC de tórax y abdomen
B) Ecocardiografía transtorácica urgente
C) Coronariografía urgente
D) Radiografía de tórax anteroposterior
E) Resonancia magnética cardíaca

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (AngioTAC de tórax y abdomen). AngioTAC de tórax y abdomen. Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh.

Pregunta de práctica

Mujer de 55 años, operada de cadera hace 10 días, presenta disnea súbita y dolor pleurítico. FC 110 lpm, PA 125/80 mmHg, SatO2 91%. Score de Wells: 7,5 puntos. **¿Cuál es el examen a solicitar para confirmar el diagnóstico?**

A) Dímero D
B) Ecocardiograma transtorácico
C) Radiografía de tórax
D) AngioTAC de tórax
E) Gases arteriales

Respuesta D. Con probabilidad clínica alta de TEP (Wells >6 o >4 según la versión) se solicita directamente angioTAC de tórax; el dímero D solo es útil para descartar en probabilidad baja/intermedia. Se debe anticoagular mientras se espera el examen.

1.01.4.003 Radiografía de tórax

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 5.2 Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo (SDRA): Criterios de Berlín

QUÉ HAY QUE SABER

- Lectura sistemática: técnica (PA vs AP, inspiración, rotación, penetración), partes blandas y huesos, mediastino, hilios, silueta cardíaca, parénquima, pleura y senos costofrénicos.
- Índice cardiotorácico >0,5 en PA indica cardiomegalia (no valorable en AP). Botellón: derrame pericárdico. Doble contorno y 4° arco: crecimiento de AI (estenosis mitral).
- Congestión por IC: redistribución de flujo a vértices, líneas B de Kerley, edema intersticial y alveolar en 'alas de mariposa', derrame pleural bilateral o derecho.
- Ensanchamiento mediastínico (>8 cm): disección o aneurisma aórtico, trauma; signo del 3 y muescas costales (Roesler): coartación aórtica.
- Neumonía: consolidación con broncograma aéreo; neumotórax: línea pleural sin trama distal; SDRA: infiltrados bilaterales sin cardiomegalia; derrame: borramiento del seno costofrénico (≥200 mL en PA).
- Hallazgos que obligan a acción urgente: neumotórax a tensión (desviación mediastínica), ensanchamiento mediastínico con dolor torácico, edema pulmonar agudo, neumoperitoneo.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Un hombre de 70 años con antecedente de infarto antiguo consulta por disnea progresiva y ortopnea. La radiografía de tórax muestra índice cardiotorácico de 0,6, redistribución de flujo hacia los vértices, líneas B de Kerley y derrame pleural bilateral pequeño. **¿Cuál es la interpretación más probable de la radiografía?**

A) Edema pulmonar cardiogénico por insuficiencia cardíaca
B) Neumonía bilateral
C) Síndrome de distrés respiratorio agudo
D) Fibrosis pulmonar
E) Derrame pleural tuberculoso

Respuesta A. Cardiomegalia (índice cardiotorácico sobre 0,5), redistribución de flujo a los vértices, líneas B de Kerley y derrame bilateral son signos clásicos de congestión por insuficiencia cardíaca. En el SDRA el edema es no cardiogénico: corazón de tamaño normal, sin redistribución ni líneas de Kerley y con infiltrados más periféricos.

1.01.4.005 Cintigrafía de perfusión miocárdica

Nivel: **Emplea informe**

Dónde se enseña: Tema 2.1 Angina Crónica Estable & Estratificación de Riesgo Funcional

QUÉ HAY QUE SABER

- Cintigrafía de perfusión miocárdica (SPECT con tecnecio o talio): compara imágenes en estrés (ejercicio o fármaco: dipiridamol, adenosina, dobutamina) y en reposo.
- Indicación: sospecha de enfermedad coronaria cuando el test de esfuerzo no es interpretable (BCRI, marcapaso, HVI, digoxina, WPW, infradesnivel basal) o el paciente no puede caminar; estratificación de riesgo y viabilidad.
- Defecto reversible (hipoperfusión en estrés que normaliza en reposo) = isquemia; defecto fijo = necrosis/cicatriz. Isquemia extensa (>10% del VI) indica alto riesgo → coronariografía.
- Ventajas: mayor sensibilidad y especificidad que la ergometría; informa FEVI y territorio coronario comprometido.
- Contraindicaciones del estrés con dipiridamol/adenosina: asma o broncoespasmo activo, BAV avanzado; suspender cafeína y teofilinas 24 h antes. Evitar en embarazo.
- El médico general usa el informe: resultado de alto riesgo o isquemia significativa → derivar a cardiología para coronariografía.

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 61 · texto original del banco, sin revisar

¿Cuál es el mejor examen para determinar si una insuficiencia cardiaca es de origen isquémico?

A) Electrocardiograma
B) Holter de electrocardiograma
C) Contigrafia de perfusión miocárdica
D) Ecografía bidimensional
E) Test de esfuerzo

Respuesta C. D? La verdad es que tanto la Ecocardiografía, como la Cintigrafía de perfusión son útiles para determinar la etiología isquémica de una ICC. La Ecocadiografía verá zonas hipoquinéticas y necrosadas o fibrosadas. La cintigrafía verá las zonas que se isquemizan con la actividad física.

Pregunta de práctica

Hombre de 66 años con dolor torácico de esfuerzo atípico. ECG de reposo: bloqueo completo de rama izquierda. Camina sin dificultad. **¿Cuál es el examen más adecuado para el estudio de isquemia?**

A) Test de esfuerzo convencional
B) Cintigrafía de perfusión miocárdica con estrés farmacológico
C) Holter de ritmo de 24 horas
D) Radiografía de tórax
E) Troponina ultrasensible seriada

Respuesta B. El BCRI impide interpretar el segmento ST en el test de esfuerzo convencional. En ese caso se prefiere un examen de imagen; con BCRI se prefiere el estrés farmacológico con vasodilatador (dipiridamol/adenosina) para evitar defectos septales falsos positivos.

1.01.4.006 Ecocardiografía

Nivel: **Emplea informe**

Dónde se enseña: Tema 2.4 Complicaciones Mecánicas del IAM & Angina de Prinzmetal · Tema 3.1 Insuficiencia Cardíaca Crónica: Fenotipos, Diagnóstico & Criterios Framingham · Tema 4.1 Estenosis Aórtica: Semiología, Severidad & TAVI vs SAVR (Guía GES)

QUÉ HAY QUE SABER

- Ecocardiograma transtorácico: examen de elección para evaluar estructura y función cardíaca; no invasivo, sin radiación. Transesofágico para prótesis, endocarditis, trombo en orejuela y aorta.
- Informa FEVI: reducida ≤40%, levemente reducida 41–49%, preservada ≥50%; trastornos segmentarios de motilidad (isquemia/infarto), hipertrofia (>11–12 mm) y dilatación de cavidades.
- Valvulopatías: área y gradientes; EAo severa (área <1 cm², gradiente medio ≥40 mmHg, velocidad ≥4 m/s); EM severa (área <1,5 cm²).
- Pericardio: derrame y signos de taponamiento (colapso diastólico de AD/VD). Estima PSAP (hipertensión pulmonar si >35–40 mmHg) y función del VD (TEP, cor pulmonale).
- Indicaciones: IC, soplo patológico, síncope de esfuerzo, FA, post IAM, sospecha de endocarditis (vegetaciones), cardiopatía congénita, HTA con sospecha de HVI.
- El médico general solicita e integra el informe; derivar a cardiología ante FEVI reducida, valvulopatía significativa, derrame importante o vegetaciones.

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 53 · texto original del banco, sin revisar

Paciente de 67 años, con antecedentes de infarto agudo al miocardio hace 6 meses tratado con stent, hipertensión arterial tratada con enalapril e hidroclorotiazida, y diabetes mellitus tratada con insulina horaria, consulta por cuadro de dos meses de disnea de medianos esfuerzos, asociado a ortopnea y edema de extremidades inferiores que aumenta en las tardes. Al examen cardiopulmonar destaca ritmo regular en dos tiempos sin soplos y murmullo pulmonar presente con crepitaciones bibasales. ¿Cuál de los siguientes es el examen de elección para iniciar el estudio diagnóstico?

A) Electrocardiograma
B) Coronariografía
C) Test de esfuerzo
D) Radiografía de torax
E) Ecocardiograma

Respuesta E. Tiene una insuficiencia cardiaca, secundaria a cardiopatía coronaria. Hay que pedir la Ecocardiografía, para ver la función ventricular.

Pregunta de práctica

Mujer de 70 años con disnea de esfuerzo progresiva, edema de extremidades y crépitos basales. NT-proBNP 2.400 pg/mL. Ecocardiograma: FEVI 32%, VI dilatado, hipocinesia difusa, sin valvulopatías significativas. **¿Cómo se clasifica su insuficiencia cardíaca según el ecocardiograma?**

A) IC con FEVI preservada
B) IC con FEVI levemente reducida
C) Miocardiopatía hipertrófica
D) Disfunción diastólica aislada
E) IC con FEVI reducida

Respuesta E. Una FEVI ≤40% define IC con fracción de eyección reducida, el fenotipo con tratamiento que reduce mortalidad (ARNI/IECA, betabloqueador, antialdosterónico e iSGLT2). FEVI 41–49% es levemente reducida y ≥50% preservada.

1.01.4.007 Electrocardiograma

Nivel: **Realiza, interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 1.1 Lectura Sistemática del ECG en Urgencias y APS · Tema 2.3 SCACEST: IAM con Supradesnivel del ST & Protocolo Reperfusión GES · Tema 3.1 Hiperkalemia Grave y Algoritmo de Estabilización de Membrana

QUÉ HAY QUE SABER

- Lectura sistemática: ritmo, frecuencia (300/nº cuadros grandes), eje (DI y aVF), onda P, PR (120–200 ms), QRS (<120 ms), QT corregido (<450 ms H, <460 M), ST y onda T.
- Isquemia/IAM: supradesnivel ST ≥1 mm en 2 derivaciones contiguas (≥2 mm en V2–V3 hombres) = SCACEST; localización: inferior DII-DIII-aVF (coronaria derecha), anterior V1–V4 (descendente anterior), lateral DI-aVL-V5-V6 (circunfleja); V4R en IAM inferior.
- Hiperkalemia: T alta y picuda → PR largo y P aplanada → QRS ancho → onda sinusoidal/FV. Hipokalemia: T plana, onda U, QT largo.
- Arritmias: FA (irregular sin P), flutter (dientes de sierra), BAV (ver relación P-QRS), TV (QRS ancho regular); WPW (PR corto + onda delta). Pericarditis: ST cóncavo difuso + PR deprimido.
- HVI: Sokolow-Lyon (S V1 + R V5/V6) ≥35 mm; BCRD: rSR' en V1 con QRS ≥120 ms; BCRI: QRS ancho con R mellada en V6 (impide valorar isquemia).
- Técnica: V1–V2 en 4° espacio paraesternal, V4 en 5° espacio línea medioclavicular, V3 entre ambas, V5–V6 a la misma altura en líneas axilares anterior y media; realizar ECG en <10 min ante dolor torácico.

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 180

Un paciente de 70 años, sin antecedentes de importancia presenta un síncope de reposo sin pródromo, con recuperación completa. Al examen físico se encuentra orientado, en Glasgow 15, con frecuencia cardíaca de 40 latidos por minuto. **¿Cuál es el examen de elección para iniciar el estudio?**

A) Monitoreo electrocardiográfico de 24 horas
B) Ecocardiograma
C) TAC de cerebro
D) Resonancia magnética de cerebro
E) Electrocardiograma

Respuesta E. Síncope de reposo, sin pródromos y con bradicardia: sospecha de síncope cardiogénico por bradiarritmia. El examen inicial es el electrocardiograma de 12 derivaciones, que puede mostrar bloqueos AV o enfermedad del nodo.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 180

Un paciente de 70 años, sin antecedentes de importancia, presenta un síncope de reposo sin pródromo, con recuperación completa. Al examen físico se encuentra orientado, con Glasgow 15 y frecuencia cardíaca de 40 latidos por minuto. **¿Cuál es el examen de elección para iniciar el estudio?**

A) Monitoreo electrocardiográfico de 24 horas
B) Ecocardiograma
C) TAC de cerebro
D) Resonancia magnética de cerebro
E) Electrocardiograma

Respuesta E. Síncope sin pródromo, en reposo y con bradicardia sugiere causa cardíaca arrítmica. El ECG de 12 derivaciones es el examen inicial: muestra bloqueos AV, disfunción sinusal y signos de trastornos electrolíticos como la hiperkalemia. El Holter se pide si el ECG no es concluyente.

1.01.4.008 Test de esfuerzo

Nivel: **Emplea informe**

Dónde se enseña: Tema 2.1 Angina Crónica Estable & Estratificación de Riesgo Funcional

QUÉ HAY QUE SABER

- Ergometría (test de esfuerzo en cinta, protocolo de Bruce): examen inicial para diagnóstico y estratificación de enfermedad coronaria en pacientes que pueden caminar y con ECG basal interpretable.
- Positivo: infradesnivel ST horizontal o descendente ≥1 mm a 80 ms del punto J, o angina típica durante el esfuerzo. Se considera válido si alcanza ≥85% de la FC máxima teórica (220 – edad).
- Alto riesgo: infradesnivel ≥2 mm, positivo en etapa 1, caída de la PAS con el esfuerzo, arritmias ventriculares o duración prolongada de la depresión del ST → coronariografía.
- Contraindicaciones: SCA reciente (<48 h), estenosis aórtica severa sintomática, IC descompensada, arritmias no controladas, disección aórtica, TEP o miopericarditis aguda.
- No interpretable con ECG basal alterado (BCRI, marcapaso, WPW, HVI con alteración de repolarización, digoxina): preferir imagen (cintigrafía o eco de estrés).
- También evalúa capacidad funcional, respuesta presora y cronotrópica y orienta la prescripción de ejercicio y rehabilitación cardíaca.

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 85 · texto original del banco, sin revisar

Paciente de 57 años, hipertenso en tratamiento con losartan y tabáquico, consulta por historia de 3 semanas de evolución de episodios caracterizados por dolor torácico que aparece al caminar por más de 10 minutos, el cual tiene una duración máxima de 5 minutos y luego cede al reposo, no asociado a otros síntomas. Actualmente se encuentra asintomático y su examen físico es normal. ¿Cuál de los siguientes exámenes es más adecuado para iniciar su estudio?

A) Radiografía de tórax
B) Ecocardiograma
C) Coronariografía
D) Electrocardiograma
E) Test de esfuerzo

Respuesta E. Es una angina de esfuerzo. Si bien hay que pedir un ECG, el TE es el examen para la angina en sí. Además el test de esfuerzo es un ECG y si está malo al inicio, no se prosigue con el examen. En la vida real, sí se pedirá probablemente el ECG, pero se debe simplificar la pregunta, a ¿cómo se estudia una angina estable?... con Test d esfuerzo. Si viniera con soplo, se sospecharía una estenosis aórtic

Pregunta de práctica

Hombre de 58 años con angina de esfuerzo. En el test de esfuerzo presenta, en el primer estadio del protocolo de Bruce, angina típica, infradesnivel horizontal del ST de 2,5 mm en V4–V6 y descenso de la presión sistólica de 20 mmHg. **¿Cuál es la interpretación y conducta?**

A) Test negativo; control anual
B) Test positivo de bajo riesgo; iniciar betabloqueador y control
C) Test positivo de alto riesgo; derivar para coronariografía
D) Test no concluyente; repetir en 6 meses
E) Test positivo; indicar trombolisis

Respuesta C. Infradesnivel ≥2 mm, positividad en el primer estadio y caída de la PAS con el esfuerzo son criterios de alto riesgo (sugieren enfermedad de tronco o multivaso), por lo que corresponde coronariografía.

1.01.4.009 Enzimas cardíacas (CPK, MB, LDH, troponinas)

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 2.2 SCASEST: Angina Inestable e IAM sin Supradesnivel del ST

QUÉ HAY QUE SABER

- Troponina T o I (ultrasensible): marcador de elección de daño miocárdico; sube a las 2–4 h, peak a las 24 h y persiste 7–14 días. IAM: elevación sobre el percentil 99 con curva de ascenso/descenso + contexto isquémico.
- Protocolo rápido: troponina ultrasensible a las 0 y 1–3 h; un valor normal muy precoz (<3 h del inicio del dolor) no descarta infarto y debe repetirse.
- CK-MB: sube a las 4–6 h y se normaliza a las 48–72 h; útil para detectar reinfarto. CK total también sube en daño muscular esquelético (rabdomiólisis, ejercicio, IM). LDH: tardía e inespecífica, en desuso.
- Troponina elevada sin SCA: miocarditis, TEP, IC, sepsis, ERC, taquiarritmias, disección aórtica, contusión miocárdica, ACV.
- Angina inestable: troponinas normales; IAM sin SDST: troponinas elevadas sin supradesnivel. En IAM con SDST no esperar troponinas para reperfundir.
- Interpretar siempre junto a la clínica y el ECG; la magnitud de la elevación se asocia al tamaño del infarto y al pronóstico.

PREGUNTAS (1)

Pregunta del libro · Tema 2.2

Hombre de 64 años con dolor torácico opresivo de reposo prolongado ingresa a urgencias. El ECG muestra infradesnivel del ST de 2 mm en derivaciones DII, DIII y aVF. Troponinas ultrasensibles positivas. ¿Cuál es el esquema antitrombótico inicial más adecuado mientras se programa la coronariografía?

A) Aspirina 250 mg + Ticagrelor 180 mg + Enoxaparina 1 mg/kg subcutánea
B) Aspirina 100 mg en monoterapia oral
C) Trombólisis con Tenecteplase endovenoso inmediato
D) Heparina no fraccionada en infusión sin antiagregantes plaquetarios
E) Acenocumarol oral para alcanzar INR de 2.5

Respuesta A. El pilar farmacológico del SCASEST confirmado es la triple terapia antitrombótica inicial: doble antiagregación plaquetaria (Aspirina + Ticagrelor) asociada a anticoagulación parenteral (Enoxaparina). La trombólisis farmacológica está formalmente CONTRAINDICADA en el SCASEST (solo se usa en SCACEST con supradesnivel del ST).

1.01.4.010 Hemograma y velocidad de hemosedimentación (VHS)

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 9.21 Vasculitis de Vaso Grande y Mediano: Arteritis de la Temporal (Células Gigantes / Urgencia Visual) y Arteritis de Takayasu

QUÉ HAY QUE SABER

- Hemograma: serie roja (Hb, VCM: microcítica ferropriva/talasemia, macrocítica B12/folato/alcohol/hipotiroidismo), blanca (leucocitosis con desviación izquierda en infección bacteriana) y plaquetas.
- Anemia: Hb <13 g/dL en hombres, <12 en mujeres no embarazadas y <11 en embarazadas; puede descompensar angina o IC.

- Neutropenia <1.500/μL (grave <500); linfocitosis en virosis; eosinofilia en parasitosis, alergias y fármacos; pancitopenia o blastos → derivar a hematología.
- VHS: reactante de fase aguda inespecífico; normal aproximadamente edad/2 en hombres y (edad+10)/2 en mujeres. Sube en infecciones, neoplasias, mieloma, anemia y embarazo.
- VHS muy elevada (>50–100 mm/h): arteritis de células gigantes y polimialgia reumática (iniciar corticoides sin esperar biopsia si hay síntomas visuales), mieloma, endocarditis, osteomielitis.
- En cardiología: VHS/PCR elevadas apoyan fiebre reumática (criterio menor de Jones), pericarditis y endocarditis.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
> Una mujer de 74 años consulta por cefalea temporal derecha de 3 semanas, claudicación mandibular y malestar general. Tiene la arteria temporal engrosada y dolorosa. Hemograma: hemoglobina 10,8 g/dL normocítica, plaquetas 480.000/mm³. **¿Qué resultado de laboratorio apoya con mayor fuerza la sospecha diagnóstica?**
> **A)** Eosinofilia de 15%
> **B)** Leucopenia con linfocitosis
> **C)** VHS de 95 mm/h
> **D)** VHS de 8 mm/h
> **E)** Policitemia
> Respuesta C. Cefalea temporal, claudicación mandibular y arteria temporal engrosada en mayor de 50 años sugieren arteritis de células gigantes. Una VHS muy elevada (habitualmente sobre 50 mm/h) la apoya, junto a anemia de enfermedad crónica y trombocitosis; una VHS normal la hace improbable. Se inicia prednisona sin esperar la biopsia.

1.01.4.011 Holter de presión arterial

Nivel: **Emplea informe**

Dónde se enseña: Tema 5.1 Hipertensión Arterial Esencial & Secundaria: Diagnóstico, Metas GES & Terapia Dual

QUÉ HAY QUE SABER

- MAPA (monitoreo ambulatorio de PA de 24 h): mediciones automáticas cada 15–30 min durante actividades habituales y el sueño.
- Valores diagnósticos de HTA: promedio de 24 h ≥130/80 mmHg, vigilia ≥135/85, sueño ≥120/70 mmHg.
- Indicaciones: sospecha de HTA de delantal blanco (PA alta en consulta sin daño de órgano), HTA enmascarada (normal en consulta con daño de órgano), HTA resistente, hipotensión sintomática por fármacos, HTA en embarazo y evaluación del patrón nocturno.
- Patrón dipper normal: descenso nocturno de 10–20%; non-dipper (<10%) o riser asocian mayor riesgo cardiovascular y sugieren SAHOS, ERC o HTA secundaria.
- HTA de delantal blanco: no requiere fármacos si no hay daño de órgano ni alto riesgo, pero sí control periódico y estilo de vida.
- El médico general emplea el informe para confirmar el diagnóstico y ajustar el tratamiento; alternativa válida es la automedición domiciliaria estandarizada (≥135/85 = HTA).

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
> Una mujer de 55 años tiene presiones en la consulta de 152/94 y 148/92 mmHg en dos controles, pero refiere que en la farmacia y en su casa sus mediciones son de 120/78 mmHg. No tiene daño de órgano blanco. **¿Cuál es el examen más adecuado para confirmar el diagnóstico?**
> **A)** Ecocardiograma
> **B)** Monitoreo ambulatorio de presión arterial de 24 horas (MAPA)
> **C)** Holter de ritmo
> **D)** Prueba de esfuerzo
> **E)** Fondo de ojo
> Respuesta B. Ante sospecha de hipertensión de bata blanca (PA alta en consulta y normal fuera de ella), el MAPA de 24 horas es el estándar para confirmar o descartar hipertensión: un promedio de 24 horas bajo 130/80 mmHg la descarta. También detecta hipertensión enmascarada y ausencia de descenso nocturno.

1.01.4.012 Perfil bioquímico

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 3.1 Ictericia y Colestasia: Enfrentamiento Diagnóstico

QUÉ HAY QUE SABER

- Perfil bioquímico: glicemia, BUN/urea, creatinina, ácido úrico, calcio, fósforo, proteínas totales, albúmina, colesterol, bilirrubina, fosfatasas alcalinas, transaminasas (GOT/GPT), LDH.
- Patrón hepatocelular: transaminasas muy elevadas (GPT > GOT en hepatitis viral; GOT/GPT >2 en hepatopatía alcohólica). Patrón colestásico: fosfatasas alcalinas y GGT elevadas con bilirrubina directa.
- Función renal: creatinina para estimar VFG (CKD-EPI); BUN/creatinina >20 sugiere causa prerrenal o hemorragia digestiva alta.
- Calcio: corregir por albúmina (Ca + 0,8 × [4 – albúmina]); hipercalcemia por hiperparatiroidismo o neoplasia. Hipoalbuminemia en desnutrición, síndrome nefrótico o daño hepático crónico.
- Ácido úrico elevado en gota, ERC, diuréticos tiazídicos y síndrome de lisis tumoral; glicemia en ayunas ≥126 mg/dL en 2 ocasiones diagnostica DM.
- En cardiología: necesario al iniciar IECA/ARA-II/diuréticos/espironolactona (función renal y electrolitos) y para monitorizar estatinas (transaminasas).

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Un hombre de 72 años, asintomático, tiene en su perfil bioquímico fosfatasa alcalina de 420 U/L (normal hasta 120), con GGT, bilirrubina, transaminasas, calcio y fósforo normales. Refiere dolor leve en la tibia derecha, que se ve arqueada.

¿Cuál es el origen más probable de la elevación de la fosfatasa alcalina?

A) Colestasia intrahepática
B) Obstrucción de la vía biliar
C) Hepatitis aguda
D) Origen óseo, sugerente de enfermedad de Paget
E) Metástasis hepáticas

Respuesta D. La fosfatasa alcalina proviene de hígado y hueso; si la GGT es normal, el origen es óseo. En un adulto mayor con fosfatasa alcalina aislada, calcio normal y tibia arqueada, sugiere enfermedad de Paget, que se confirma con radiografías y cintigrama óseo. La colestasia elevaría también la GGT.

1.01.4.013 Perfil lipídico

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 5.4 Dislipidemias: Clasificación de Fredrickson, Riesgo Cardiovascular y Estatinas

QUÉ HAY QUE SABER

- Componentes: colesterol total, HDL, triglicéridos y LDL calculado por Friedewald (LDL = CT – HDL – TG/5), no válido si TG >400 mg/dL; colesterol no-HDL = CT – HDL (meta = meta LDL + 30).
- Valores deseables: CT <200 mg/dL, TG <150, HDL ≥40 en hombres y ≥50 en mujeres; LDL según riesgo cardiovascular (<55–70 en alto riesgo, <100 moderado, <130 bajo).
- LDL ≥190 mg/dL: sospechar hipercolesterolemia familiar (xantomas tendinosos, historia familiar de enfermedad coronaria precoz) → estatina de alta intensidad y estudio familiar.
- TG ≥500 mg/dL (sobre todo ≥1000): riesgo de pancreatitis aguda → fibrato y control de alcohol/azúcares/DM.
- Ayuno de 9–12 h recomendado si se sospecha hipertrigliceridemia; descartar causas secundarias (hipotiroidismo, DM, síndrome nefrótico, colestasia, alcohol, fármacos).
- Control: 6–12 semanas tras iniciar o ajustar estatina y luego cada 6–12 meses; tamizaje en el EMPA desde los 40 años o antes si hay factores de riesgo.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Un hombre de 50 años se realiza un perfil lipídico con 12 horas de ayuno: colesterol total 260 mg/dL, HDL 40 mg/dL y triglicéridos 600 mg/dL. El laboratorio no informa el LDL calculado. **¿Por qué no se informa el colesterol LDL?**

A) Porque el ayuno fue insuficiente
B) Porque el LDL solo se mide en diabéticos
C) Porque el HDL es bajo
D) Porque el colesterol total es normal
E) Porque la fórmula de Friedewald no es válida con triglicéridos sobre 400 mg/dL

Respuesta E. El LDL suele calcularse con Friedewald: LDL = CT – HDL – TG/5. Con triglicéridos sobre 400 mg/dL la fórmula pierde validez y se mide el LDL directo o se usa el colesterol no-HDL (CT – HDL), aquí 220 mg/dL. Con TG sobre 500, la prioridad es bajarlos para prevenir pancreatitis.

1.01.4.014 Holter de ritmo

Nivel: **Emplea informe**

Dónde se enseña: cardiologia:1.6

QUÉ HAY QUE SABER

- Holter de ritmo: registro ECG continuo de 24–48 h (o más días con monitores de eventos) durante actividades habituales con diario de síntomas.
- Indicaciones: palpitaciones, síncope o presíncope no explicados, sospecha de FA paroxística (incluido estudio de ACV criptogénico), cuantificar extrasistolía y evaluar respuesta a antiarrítmicos o control de frecuencia en FA.
- Correlacionar síntomas con el ritmo: síntoma sin arritmia orienta a causa no arrítmica; arritmia sin síntoma puede ser hallazgo.
- Hallazgos de alarma: pausas >3 s en vigilia, BAV 2° Mobitz II o 3°, TV sostenida o no sostenida frecuente, FA paroxística → derivar a cardiología.
- Carga de extrasístoles ventriculares >10–20% se asocia a miocardiopatía inducida; bradicardia sinusal nocturna y BAV 1° o Wenckebach nocturnos pueden ser fisiológicos.
- Si los síntomas son infrecuentes (mensuales), el Holter de 24 h tiene bajo rendimiento: preferir monitor de eventos o Holter implantable.

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 7

Una paciente de 67 años, con antecedente de hipertensión arterial y fibrilación auricular, en tratamiento con atenolol, verapamilo y acenocumarol, consulta porque presenta repetidos episodios de malestar, sudoración y ortostatismo, que duran algunos segundos y revierten espontáneamente. Al examen físico destaca frecuencia cardíaca de 60 por minuto, irregular, y presión arterial 110/70 mmHg. Su examen cardiopulmonar es normal. **¿Cuál es el examen más adecuado para confirmar la sospecha diagnóstica?**

A) Test de esfuerzo
B) Ecocardiograma
C) Ecografía doppler de extremidades inferiores
D) Tilt test
E) Monitoreo electrocardiográfico de 24 horas

Respuesta E. Episodios presincopales breves y recurrentes en una paciente con fibrilación auricular y dos frenadores del nodo (atenolol más verapamilo, combinación riesgosa) sugieren bradiarritmia: pausas o síndrome taquicardia-bradicardia. El Holter de 24 horas correlaciona síntomas con el ritmo. El tilt test estudia el síncope vasovagal.

Procedimientos diagnósticos y terapéuticos 8 códigos

1.01.5.002 Cardioversión eléctrica

Nivel: **Derivar a especialista**

Dónde se enseña: Tema 1.4 TPSV & Síndrome de Wolff-Parkinson-White

QUÉ HAY QUE SABER

- Cardioversión eléctrica sincronizada: descarga coincidente con la onda R para evitar caer en período vulnerable (fenómeno R sobre T → FV).

- Urgente en toda taquiarritmia con pulso e inestabilidad (hipotensión, shock, dolor isquémico, IC aguda, compromiso de conciencia): FA 120–200 J bifásico, flutter y TPSV 50–100 J, TV monomorfa con pulso 100 J.
- Electiva en FA o flutter estables: requiere anticoagulación ≥3 semanas antes (o ETE sin trombo) si duran >48 h o tiempo incierto, y 4 semanas después en todos.
- Preparación: ayuno, consentimiento, sedación breve (midazolam, propofol o etomidato), monitorización y equipo de vía aérea; corregir hipokalemia y descartar intoxicación digitálica.
- No sincronizar en FV o TV sin pulso (desfibrilación); no es útil en taquicardia sinusal ni taquicardia auricular multifocal.
- El médico general deriva al especialista la cardioversión electiva; en urgencia vital con inestabilidad debe realizarla sin demora.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 70 años con FA de 5 días de evolución, en buenas condiciones, PA 130/80 mmHg y FC 100 lpm. Sin anticoagulación previa. Se plantea restablecer el ritmo sinusal mediante cardioversión eléctrica electiva. **¿Cuál es el requisito previo más importante?**

A) Anticoagular al menos 3 semanas antes o descartar trombo con ecocardiograma transesofágico
B) Realizar la cardioversión inmediatamente sin más estudio
C) Administrar digoxina EV antes de la descarga
D) Usar descarga no sincronizada de 360 J
E) Suspender toda anticoagulación después del procedimiento

Respuesta A. En FA >48 horas, cardiovertir sin anticoagulación previa expone a embolía al restablecer la contracción auricular. Se anticoagula 3 semanas antes (o ETE sin trombo) y al menos 4 semanas después; la descarga debe ser sincronizada.

1.01.5.003 Cateterismo venoso central

Nivel: **Derivar a especialista**

Dónde se enseña: Tema 2.3 IAAS, Infecciones de Catéteres Vasculares y Precauciones de Aislamiento

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicaciones: administración de drogas vasoactivas, nutrición parenteral, quimioterapia o soluciones irritantes, monitorización de PVC, hemodiálisis de urgencia, ausencia de acceso periférico.
- Accesos: yugular interna (preferida con ecografía), subclavia (menor infección, mayor riesgo de neumotórax) y femoral (más infección y trombosis, útil en paro).
- Técnica de Seldinger con barreras máximas (gorro, mascarilla, delantal, guantes estériles, campo amplio), antisepsia con clorhexidina y guía ecográfica.
- Complicaciones: neumotórax, punción arterial, hematoma, arritmias, embolía gaseosa, trombosis e infección del torrente sanguíneo (IAAS). Rx de tórax post instalación (yugular/subclavia) para posición y descartar neumotórax.
- Prevención de infección asociada a catéter: indicación diaria de necesidad, retirar lo antes posible, curaciones con técnica aséptica; fiebre sin foco en portador → hemocultivos central y periférico.
- El médico general conoce indicaciones y complicaciones y lo deriva al especialista (intensivista, anestesista o cirujano) para su instalación.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Se instala un catéter venoso central por vía subclavia derecha a un paciente de 60 años en UCI. A los 20 minutos presenta disnea súbita, taquicardia y saturación de 88%, con murmullo pulmonar abolido en el hemitórax derecho. **¿Cuál es la complicación más probable?**

A) Neumotórax iatrogénico
B) Embolia gaseosa
C) Infección del torrente sanguíneo asociada a catéter
D) Trombosis venosa asociada al catéter
E) Arritmia por catéter en el ventrículo

Respuesta A. La punción subclavia es la vía con mayor riesgo de neumotórax. Disnea, desaturación y murmullo abolido ipsilateral tras la instalación lo sugieren; por eso siempre se toma radiografía de tórax post procedimiento, que además verifica la punta del catéter. La infección asociada a catéter aparece días después, no a los minutos.

1.01.5.004 Desfibrilación

Nivel: **Realizar**

Dónde se enseña: Tema 1.2 Paro Cardiorrespiratorio & Algoritmos ACLS / MINSAL

QUÉ HAY QUE SABER

- Desfibrilación: descarga eléctrica NO sincronizada; único tratamiento eficaz de la FV y TV sin pulso. Cada minuto de retraso reduce la sobrevida ~7–10%.
- Energía: bifásico 120–200 J según fabricante (o máxima), monofásico 360 J; con DEA seguir las instrucciones del equipo.
- Posición de las paletas: esternal (bajo la clavícula derecha) y apical (línea axilar media izquierda, 5° espacio); alternativa anteroposterior. Evitar parches de nitroglicerina y alejarse ≥8 cm de marcapasos.
- Seguridad: anunciar la descarga, nadie en contacto con el paciente, retirar el O2 del tórax; secar el tórax si está mojado.
- Tras la descarga reanudar inmediatamente compresiones por 2 minutos sin revisar pulso; adrenalina tras la 2ª descarga y amiodarona 300 mg tras la 3ª.
- No desfibrilar asistolia ni AESP; los DEA en lugares públicos (Ley 21.156 de Chile) permiten desfibrilación precoz por legos.

PREGUNTAS (2)

Pregunta del libro · Tema 1.2

Durante la reanimación cardiopulmonar avanzada de una mujer de 50 años en fibrilación ventricular, se realiza la primera descarga de 200 J bifásicos. ¿Cuál es la acción inmediata que debe realizar el equipo?

A) Reanudar inmediatamente las compresiones torácicas durante 2 minutos antes de cualquier otra evaluación
B) Palpar el pulso carotídeo para verificar si recuperó circulación espontánea
C) Mirar el monitor para comprobar si el ritmo cambió a sinusal
D) Administrar inmediatamente 1 mg de adrenalina endovenosa
E) Administrar 300 mg de amiodarona en bolo rápido

Respuesta A. La regla de oro del ACLS establece que inmediatamente después de administrar una descarga eléctrica, se deben reanudar las compresiones torácicas durante 2 minutos completos sin interrumpir para verificar el ritmo o el pulso. Chequear el pulso inmediatamente después del choque genera pausas innecesarias y el corazón recién desfibrilado requiere soporte hemodinámico mediante compresiones para recuperar el gasto cardíaco.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 4 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 64 años, con antecedente de diabetes mellitus 8po 2 e hipertensión arterial mal controlados, consulta en el servicio de urgencia por dolor torácico opresivo EVA 9/10, asociado a disnea y malestar general. Durante su atención presenta un electrocardiograma que muestra a con8nuación: ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Cardioversión eléctrica
B) Desfibrilación eléctrica
C) Amiodarona endovenosa
D) Maniobras de reanimación cardiopulmonar
E) Coronariogra:a urgente

Respuesta B. El ECG corresponde a un síndrome coronario agudo con supradesnivel del ST (cara inferior), que evoluciona a fibrilación ventricular, lo que consGtuye un paro cardíaco presenciado en ritmo desfibrilable (fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso). Por ser un paro presenciado, la conducta inmediata es la desfibrilación eléctrica. Las maniobras de RCP se inician de forma simultánea, per

1.01.5.005 Intubación traqueal

Nivel: **Realizar**

Dónde se enseña: Tema 11.9 Evaluación Inicial del Politraumatizado: Protocolo ATLS (A-B-C-D-E)

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicaciones: incapacidad de proteger la vía aérea (Glasgow ≤8), insuficiencia respiratoria refractaria, paro cardiorrespiratorio sin ventilación eficaz con bolsa, shock grave, quemadura de vía aérea u obstrucción inminente.
- Preparación: preoxigenar con O2 100% por 3–5 min, posición de olfateo, equipo (laringoscopio, tubos 7–8 en mujeres y 8–8,5 en hombres, guía, aspiración, bolsa-mascarilla, capnógrafo) y vía venosa.
- Secuencia de intubación rápida: inductor (etomidato 0,3 mg/kg, ketamina 1–2 mg/kg o propofol) + relajante (succinilcolina 1–1,5 mg/kg o rocuronio 1–1,2 mg/kg).
- Confirmación: capnografía (gold standard), visualización del paso por cuerdas, auscultación bilateral simétrica y epigastrio silente; Rx de tórax (punta 2–4 cm sobre la carina). Fijar a 21–23 cm en la comisura.
- En trauma: inmovilización cervical manual en línea; si falla la intubación y no se puede ventilar: dispositivo supraglótico o cricotiroidotomía.
- Complicaciones: intubación esofágica o selectiva derecha (hipoventilación izquierda), hipoxemia, broncoaspiración, trauma dental o laríngeo, hipotensión post inducción. Succinilcolina contraindicada en hiperkalemia, quemados/aplastamiento >24 h y neuromusculares.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Un motociclista de 25 años ingresa tras un choque. Tiene Glasgow de 7 (O1 V2 M4), respiración ruidosa y saturación de 90% con mascarilla de alto flujo. Se mantiene la restricción de movimiento cervical. **¿Cuál es la conducta más adecuada respecto de la vía aérea?**

A) Mantener la mascarilla de alto flujo y realizar TAC de encéfalo
B) Intubación orotraqueal con secuencia rápida, manteniendo la restricción del movimiento cervical
C) Cánula nasofaríngea y observación
D) Traqueostomía electiva
E) Ventilación no invasiva

Respuesta B. Un Glasgow de 8 o menos indica incapacidad de proteger la vía aérea y es indicación de vía aérea definitiva. En trauma se realiza intubación orotraqueal con secuencia rápida y restricción del movimiento cervical en línea. La ventilación no invasiva está contraindicada con compromiso de conciencia; la vía quirúrgica se reserva si falla la intubación.

1.01.5.006 Resucitación cardiorespiratoria

Nivel: **Realizar**

Dónde se enseña: Tema 1.2 Paro Cardiorrespiratorio & Algoritmos ACLS / MINSAL

QUÉ HAY QUE SABER

- Cadena de sobrevida: reconocer el paro, activar emergencia (131) y pedir DEA, RCP precoz, desfibrilación precoz, soporte vital avanzado y cuidados post-paro.

- Adultos: si no responde y no respira normalmente, iniciar compresiones de inmediato (C-A-B); centro del tórax, 100–120/min, 5–6 cm, reexpansión completa, interrupciones <10 s.
- Relación 30:2 sin vía aérea avanzada; con tubo o dispositivo supraglótico, compresiones continuas y 1 ventilación cada 6 s (10/min). Legos no entrenados: solo compresiones.
- Conectar el DEA/monitor lo antes posible: FV/TV sin pulso → descarga; asistolia/AESP → RCP + adrenalina 1 mg c/3–5 min; buscar 5H y 5T.
- Pediatría: compresiones 1/3 del diámetro anteroposterior, relación 30:2 con un reanimador y 15:2 con dos; en niños el paro suele ser de causa respiratoria.
- Finalizar según criterio clínico (asistolia prolongada sin causa reversible, capnografía persistentemente <10 mmHg tras 20 min de RCP avanzada); post-paro: SatO2 92–98%, PAM ≥65, control de temperatura y coronariografía si hay SDST.

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 158 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 67 años, diabético, hipertenso y dislipidémico, fumador activo, consulta en el servicio de urgencia por dolor torácico opresivo e intenso, de 2 horas de evolución, irradiado al hombro derecho y asociado a disnea. Mientras estaba en la sala de reanimación presenta pérdida de conciencia y usted constata que no se mueve, no respira y no tiene pulso. Además de pedir ayuda y activar el código de paro, ¿cuál es la conducta inmediata?

A) Instalar el monitor cardíaco en modo paletas
B) Realizar intubación orotraqueal
C) Solicitar electrocardiograma
D) Realizar compresiones torácicas
E) Administrar adrenalina endovenosa en bolo

Respuesta D. Conducta / Tratamiento indicado: Realizar compresiones torácicas (opción D). Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

Pregunta de práctica

En el pasillo del hospital usted encuentra a un hombre de 55 años tendido en el suelo. No responde al estímulo y solo presenta respiraciones agónicas. Ya pidió ayuda y que traigan el desfibrilador. **¿Cuál es la acción inmediata siguiente?**

A) Dar 5 ventilaciones de rescate antes de comprimir
B) Buscar pulso carotídeo durante 30 segundos
C) Colocar al paciente en posición lateral de seguridad
D) Iniciar compresiones torácicas a 100–120 por minuto
E) Esperar el desfibrilador para decidir la conducta

Respuesta D. Un paciente que no responde y respira de forma agónica está en paro: se deben iniciar compresiones de alta calidad de inmediato, sin buscar pulso por más de 10 segundos. Las respiraciones agónicas no son respiración normal; la posición lateral es para pacientes que respiran.

1.01.5.007 Punción pericárdica

Nivel: **Derivar a especialista**

Dónde se enseña: Tema 5.3 Pericarditis Aguda & Taponamiento Cardíaco

QUÉ HAY QUE SABER

- Pericardiocentesis: punción del saco pericárdico para drenaje; indicación urgente en taponamiento cardíaco (tríada de Beck, pulso paradójico, colapso de cavidades derechas en eco).
- Indicación diagnóstica: derrame de causa no aclarada (sospecha bacteriana, tuberculosa o neoplásica) con estudio citoquímico, cultivo, ADA y citología del líquido.
- Técnica: vía subxifoidea dirigiendo la aguja hacia el hombro izquierdo en 30–45°, idealmente guiada por ecocardiografía, con monitorización ECG; dejar catéter de drenaje.
- Complicaciones: punción ventricular o coronaria, arritmias, neumotórax, lesión hepática, edema pulmonar por descompresión e infección.
- Contraindicaciones: disección aórtica con hemopericardio (requiere cirugía), rotura de pared libre post IAM; relativas: coagulopatía, derrame pequeño o posterior o loculado.
- El médico general reconoce la indicación y deriva al especialista; en paro por taponamiento sin especialista disponible, la punción es salvadora.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Mujer de 62 años con cáncer pulmonar avanzado consulta por disnea progresiva. PA 82/60 mmHg, FC 120 lpm, ingurgitación yugular, ruidos cardíacos apagados y caída de la PAS de 15 mmHg en inspiración. Ecocardiograma: derrame pericárdico severo con colapso diastólico del ventrículo derecho. **¿Cuál es el tratamiento inmediato?**

A) Furosemida 40 mg EV
B) Pericardiocentesis descompresiva
C) Nitroglicerina en infusión EV
D) Ibuprofeno y colchicina
E) Dobutamina como única medida

Respuesta B. Hipotensión, ingurgitación yugular, ruidos apagados y pulso paradójico con colapso del VD configuran un taponamiento cardíaco: requiere pericardiocentesis urgente. Diuréticos y vasodilatadores reducen la precarga y pueden precipitar un colapso hemodinámico.

1.01.5.008 Punción venosa

Nivel: **Realizar**

Dónde se enseña: cirugia-21

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicaciones: toma de muestras de sangre e instalación de vía venosa periférica para fluidos, fármacos y hemoderivados.
- Sitios: venas del dorso de la mano y antebrazo (cefálica, basílica); fosa antecubital para muestras. Evitar extremidad con fístula AV, linfedema o mastectomía homolateral, zonas infectadas o con flebitis.
- Técnica: lavado de manos y guantes, ligadura 7–10 cm proximal, antisepsia (alcohol 70% o clorhexidina) dejando secar, punción con bisel hacia arriba en 15–30°, retirar ligadura antes de sacar la aguja y comprimir.
- Calibre: 14–16 G en reanimación y trauma (2 vías gruesas), 18–20 G para uso habitual, 22–24 G en ancianos y niños.
- Complicaciones: hematoma, flebitis (cambiar el catéter cada 72–96 h o ante signos), extravasación, infección, punción arterial accidental.
- Orden de tubos para extracción: hemocultivos primero, luego citrato (coagulación), suero, heparina, EDTA (hemograma) y fluoruro (glicemia).

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Una mujer de 62 años, con antecedente de mastectomía izquierda con disección axilar por cáncer de mama, requiere toma de exámenes de sangre. **¿Cuál es la indicación más adecuada para la punción venosa?**

A) Puncionar el brazo izquierdo, porque tiene venas más visibles
B) Mantener el torniquete apretado más de 3 minutos para facilitar la punción
C) Puncionar el brazo derecho, evitando el brazo con disección axilar
D) Retirar la aguja antes de soltar el torniquete
E) Puncionar siempre la vena femoral

Respuesta C. Se evita puncionar la extremidad con disección axilar (riesgo de linfedema e infección), con fístula arteriovenosa o con una vía venosa en curso. El torniquete debe mantenerse menos de 1 minuto para no alterar resultados (hemoconcentración, potasio) y soltarse antes de retirar la aguja, para evitar hematomas.

1.01.5.009 Trombolisis

Nivel: **Realizar**

Dónde se enseña: Tema 2.3 SCACEST: IAM con Supradesnivel del ST & Protocolo Reperfusión GES

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicación: IAM con supradesnivel ST (o BCRI nuevo) de <12 h de evolución cuando la angioplastía primaria no se puede realizar en <120 min desde el diagnóstico; meta puerta-aguja <30 min (GES).
- Fármacos: tenecteplase en bolo único EV ajustado a peso (30–50 mg; 6.000 a 10.000 UI) o estreptoquinasa 1,5 millones UI en 60 min; asociar aspirina, clopidogrel y enoxaparina.
- Contraindicaciones absolutas: ACV hemorrágico previo, ACV isquémico <3 meses, neoplasia o malformación intracraneal, sangrado activo, sospecha de disección aórtica, TEC o cirugía mayor reciente (<3 semanas).

- Relativas: HTA no controlada (>180/110), anticoagulación oral, embarazo, RCP traumática o prolongada, úlcera péptica activa.
- Criterios de reperfusión a los 60–90 min: descenso del ST >50%, alivio del dolor, arritmias de reperfusión (RIVA); si falla → angioplastía de rescate. Siempre trasladar a centro con hemodinamia en 2–24 h.
- Complicación principal: hemorragia (intracraneal ~1%); estreptoquinasa produce hipotensión y alergia y no debe repetirse. No trombolizar el SCA sin supradesnivel.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 56 años en un hospital sin hemodinamia, con dolor torácico opresivo de 2 horas de evolución y supradesnivel del ST de 3 mm en V1–V4. El traslado a un centro con angioplastía tomaría unas 3 horas. Sin antecedentes de ACV ni sangrado. **¿Cuál es la conducta de reperfusión más adecuada?**

A) Esperar troponinas antes de decidir
B) Trasladar para angioplastía primaria sin otra medida
C) Trombolisis solo si el dolor supera las 12 horas
D) Solo aspirina y enoxaparina, sin reperfusión
E) Trombolisis con tenecteplase y luego traslado a centro con hemodinamia

Respuesta E. En IAM con SDST de <12 horas, si la angioplastía no puede realizarse en <120 minutos, se indica trombolisis lo antes posible (meta <30 min) y traslado posterior a un centro con hemodinamia. No se esperan troponinas para reperfundir.